

HECHOS, INFERENCIAS E INCERTIDUMBRE

Metacognición, lenguaje y decisión clínica

Una epistemología operativa para médicos

DANIEL OPAZO

2026 · Edición de trabajo revisada

Hechos, inferencias e incertidumbre. Metacognición, lenguaje y decisión clínica.

Daniel Opazo

Edición de trabajo, 2026. Ensayo académico dirigido a profesionales de la salud. Todas las viñetas clínicas —incluido el caso longitudinal que atraviesa el libro, los interludios y los pasajes narrados en primera persona— son composiciones docentes: combinan situaciones frecuentes de la práctica hospitalaria y no corresponden a pacientes identificables ni a episodios reproducidos literalmente. Este manuscrito fue desarrollado a partir de ideas y formulaciones del autor, con asistencia de inteligencia artificial en investigación, redacción y edición; la responsabilidad por el contenido, las tesis y los errores es del autor. No sustituye guías clínicas, evaluación especializada ni juicio profesional en casos individuales.

Contenido

Prefacio.....	1
Cómo leer este libro.....	3
Introducción. La medicina como práctica de conocimiento incompleto. .4	4
PARTE I. Las capas del conocimiento clínico.....	8
Capítulo 1. El hecho clínico: observación, medición y procedencia.....	9
Capítulo 2. Inferir: del signo a la explicación.....	14
Capítulo 3. Incertidumbre: una condición estructural.....	18
Capítulo 4. Lenguaje clínico y densidad epistémica.....	22
Interludio I. La ficha de Carmen.....	26
PARTE II. La mente que se observa.....	27
Capítulo 5. Metacognición: monitorear y regular el propio juicio.....	28
Capítulo 6. Pericia, intuición y conocimiento tácito.....	33
Capítulo 7. Error, sesgo y ecología del diagnóstico.....	36
Capítulo 8. Reflexión y desaceleración selectiva.....	39
Interludio II. Lo que el equipo pensó.....	42
PARTE III. Decidir en el tiempo y con otros.....	43
Capítulo 9. De la evidencia a la decisión: poblaciones, umbrales y consecuencias	44
Capítulo 10. Temporalidad, trayectoria y razonamiento contrafactual.....	50
Capítulo 11. La ficha clínica como instrumento de pensamiento.....	53
Capítulo 12. Pensar con otros: equipos, desacuerdo y comunicación de la incertidumbre.....	57
Interludio III. La decisión de Carmen.....	62
PARTE IV. Una epistemología operativa.....	63
Capítulo 13. Inteligencia artificial como espejo del razonamiento.....	64
Capítulo 14. Humildad epistémica y responsabilidad clínica.....	67
Capítulo 15. El método HII-D: una epistemología operativa.....	71
Cuaderno de casos. Ocho viñetas para una lectura metacognitiva.....	77
Capítulo 16. Enseñar y organizar la metacognición clínica.....	84
Conclusión. Una medicina lúcida.....	88
Apéndice A. Hoja HII-D para discusión de casos.....	90
Apéndice B. Léxico de certeza y pausa diagnóstica.....	92
Apéndice C. Guía de implementación en un servicio clínico.....	94
Glosario.....	96
Índice analítico.....	99

Referencias.....	101
-------------------------	------------

Prefacio

Durante mi residencia escribí una frase que tardé años en devolver a su tamaño real. El paciente había vomitado durante la noche; en la radiografía de la mañana aparecieron infiltrados basales. Yo escribí: "neumonía aspirativa". Dos palabras, limpias, verosímiles. La frase viajó conmigo al pase de visita, del pase de visita a la epicrisis, de la epicrisis a la nota de ingreso siguiente, meses después, redactada por alguien que nunca vio al paciente vomitar. Nadie mintió en ningún momento. Pero en algún punto del trayecto una hipótesis razonable se había convertido en un antecedente, y el antecedente en un hecho. Cuando volví a encontrar la frase, ya nadie recordaba que había nacido siendo una conjetura mía, escrita a las siete de la mañana, con la certeza frágil de quien lleva doce horas despierto.

Este libro nace de esa observación, repetida después en mil variantes: algunas frases clínicas hacen algo más que resumir. En pocas líneas consiguen distinguir el dato de su interpretación, jerarquizar lo decisivo, preservar la incertidumbre y dejar visible por qué una conducta es razonable. Otras frases, aun siendo técnicamente correctas, confunden observación con explicación, ocultan los grados de certeza o convierten una posibilidad en un hecho. La diferencia no es sólo estilística. Es epistemológica y, por sus consecuencias, también clínica.

La medicina trabaja con información incompleta. Los síntomas son relatos situados; los signos dependen de quién observa y cómo observa; los exámenes tienen error, umbrales y contextos de validez; los hallazgos negativos pueden reflejar ausencia real, oportunidad inadecuada o sensibilidad insuficiente. Sobre esa base se construyen inferencias de distinta fuerza. Algunas son casi obligadas; otras compiten con explicaciones rivales; muchas permanecen abiertas. Sin embargo, la práctica exige decidir antes de alcanzar certeza.

La tesis central puede formularse así:

El conocimiento clínico está compuesto por hechos incompletos, inferencias graduadas e incertidumbre irreductible; la inteligencia médica consiste en distinguirlos, integrarlos y decidir sin convertir la probabilidad en certeza.

Este no es un catálogo de sesgos cognitivos ni una historia exhaustiva de la filosofía de la medicina. Es un ensayo de integración dirigido a médicos que desean pensar con mayor precisión acerca de su propio pensamiento. Reúne aportes de la investigación sobre razonamiento clínico, metacognición, decisión bajo incertidumbre, lenguaje científico, seguridad diagnóstica y educación médica. Los pone en diálogo con Aristóteles, Peirce, Wittgenstein, Polanyi, Gadamer, Canguilhem, Foucault y otros autores que permiten comprender por qué observar, nombrar y decidir nunca son operaciones completamente separables.

Conviene decir desde el inicio en qué conversación entra este libro. Jerome Groopman mostró al gran público cómo piensan los médicos y dónde se tuercen

sus atajos (Groopman, 2007); Pat Croskerry catalogó esos desvíos y propuso estrategias para contenerlos (Croskerry, 2003); Kathryn Montgomery demostró que el juicio clínico es un razonamiento práctico irreducible a la aplicación de reglas (Montgomery, 2006). Este ensayo se sitúa después de esas tres operaciones y propone la que falta: cómo escribir y decidir para que las capas del conocimiento clínico —lo observado, lo inferido, lo incierto, lo decidido— permanezcan visibles y auditables en el trabajo de cada día. No va de la teoría hacia la clínica, sino de la ficha, el pase de visita y la nota de evolución hacia la epistemología. Y está escrito en español a propósito: la reflexión sistemática sobre el razonamiento clínico apenas circula en nuestra lengua fuera de traducciones, y las palabras con que un equipo hispanohablante fija sus certezas merecen un examen hecho desde dentro.

El propósito es operativo. Cada capítulo intenta conservar una doble exigencia: rigor conceptual y utilidad clínica. La pregunta no es únicamente qué significa conocer, sino cómo escribir una evolución, discutir un diagnóstico, comunicar una duda, reconocer un cierre prematuro o decidir una intervención cuando la evidencia no permite una conclusión definitiva.

Escribo desde la práctica y no desde la tribuna. Los errores que analizo en estas páginas incluyen los míos; los he reconstruido como composiciones docentes — igual que todas las viñetas del libro— para proteger a los pacientes y a los equipos, pero no para protegerme a mí. Un libro sobre la lucidez clínica que ocultara la falibilidad de quien lo escribe se refutaría solo.

El método HII-D propuesto en la parte final —hechos, inferencias, incertidumbre y decisión— debe entenderse como una heurística de escritura y deliberación, no como una escala validada ni como sustituto del conocimiento clínico específico.

La aspiración del libro es modesta y exigente a la vez: favorecer una medicina capaz de afirmar con claridad, dudar con precisión y actuar con responsabilidad.

Cómo leer este libro

El libro está organizado en cuatro partes. La **Parte I** separa las capas del conocimiento clínico: hechos, inferencias, incertidumbre y el lenguaje que las expresa o las confunde. La **Parte II** examina la mente que se observa a sí misma: metacognición, pericia, error y desaceleración selectiva. La **Parte III** amplía el foco hacia la decisión en el tiempo y con otros: evidencia poblacional y umbrales, trayectoria, ficha clínica, equipos y comunicación de incertidumbre. La **Parte IV** propone una epistemología operativa: inteligencia artificial, responsabilidad, el método HII-D, un cuaderno de ocho casos y la enseñanza de la metacognición clínica.

Un caso atraviesa todo el libro: el de Carmen, una mujer con una hernia incisional y episodios repetidos de obstrucción intestinal, cuyo ingreso abre la introducción. Cada parte termina con un interludio que vuelve a su cama con las herramientas recién presentadas, y su historia se resuelve en el cuaderno de casos. Ningún caso resume la medicina; uno bien seguido, sin embargo, permite ver cómo las capas del conocimiento se mezclan, se separan y deciden cosas reales sobre una persona real.

Cada capítulo cierra con tres dispositivos breves. **En una frase** condensa la tesis del capítulo. **Tres preguntas para la próxima visita** convierte el concepto en autoexamen aplicable al siguiente paciente que el lector atienda. Y en la mayoría de los capítulos, un **Taller** propone un ejercicio concreto —casi siempre reescribir una frase clínica real— con una solución comentada. Los talleres no tienen respuestas únicas; las soluciones muestran un camino, no el camino.

Conviene leer con un caso propio en mente. Ante cada concepto, puede preguntarse: ¿qué frase uso habitualmente para esto?, ¿qué parte de esa frase es dato?, ¿qué presupuestos contiene?, ¿cómo la entendería otro profesional?, ¿qué conducta habilita? El libro pretende producir una pequeña fricción entre pensamiento y lenguaje. Esa fricción es deliberada: permite observar operaciones que la experiencia vuelve rápidas e invisibles.

No se propone reemplazar la intuición por análisis permanente. El objetivo es construir mecanismos para reconocer cuándo una intuición merece confianza y cuándo necesita ser desplegada. La metacognición útil no ocupa el centro de la escena todo el tiempo; aparece en puntos de cambio, discordancia, alto riesgo o baja familiaridad. Luego vuelve a retirarse, dejando una práctica mejor calibrada.

Introducción. La medicina como práctica de conocimiento incompleto

Carmen tiene sesenta y un años y una cicatriz mediana que le cruza el abdomen desde una cirugía de hace una década. Sobre la cicatriz, una hernia incisional que ella conoce mejor que nadie: sabe qué comidas la inflaman, sabe dormir de lado cuando "se le aprieta", sabe distinguir la molestia habitual del dolor que la trae al hospital. Ha ingresado tres veces en el último año por episodios de suboclusión intestinal que se resolvieron con reposo digestivo y sonda. Esta madrugada llegó por cuarta vez, y algo es distinto: está hipotensa, taquicárdica, con las rodillas moteadas y un lactato de 6. En la nota de ingreso, alguien escribió: "Paciente con hernia complicada conocida, cuadro habitual, se maneja de forma habitual".

Casi todo en esa frase es razonable. Y casi todo está por verse. ¿Qué significa "conocida"? ¿Qué significa "habitual" en una paciente que nunca había llegado en shock? ¿"Complicada" describe lo que la tomografía mostró alguna vez o lo que el equipo teme ahora? La frase no es falsa: es prematura. Comprime cuatro operaciones distintas —observar, inferir, reconocer lo incierto y decidir— en un gesto único que ya no deja ver sus partes. Este libro trata de esas cuatro operaciones, de cómo se mezclan y de cómo volver a separarlas cuando importa. Volveremos a la cama de Carmen al final de cada parte.

La medicina suele describirse como una ciencia aplicada. La fórmula es útil, pero incompleta. El médico no recibe una realidad ya ordenada que sólo deba comparar con un manual. Recibe fragmentos: una historia narrada desde una perspectiva particular, signos obtenidos en condiciones variables, imágenes que requieren interpretación, biomarcadores cuya relevancia depende de la probabilidad previa y una evolución temporal que a menudo se revela mientras la conducta ya está en curso. La ciencia aporta modelos, regularidades, estimaciones y pruebas. La práctica clínica debe particularizarlos en una persona concreta, en un momento concreto y bajo restricciones concretas.

Esta tensión no es nueva. Alvan Feinstein reclamaba ya en los años sesenta una ciencia del juicio clínico: un examen disciplinado de cómo los médicos observan, clasifican y deciden, en lugar de tratar esas operaciones como talento inefable (Feinstein, 1967). En español, Alberto Lifshitz ha sostenido la misma causa durante décadas: la tecnología no reemplaza el método clínico sino que lo vuelve más exigente, y la clínica debe reformularse sin renunciar a su núcleo de juicio (Lifshitz, 2014). Kathryn Montgomery, por su parte, llamó la atención sobre el carácter de razonamiento práctico de la medicina. No se trata de negar su base científica, sino de reconocer que la decisión clínica no se deduce mecánicamente de una ley general (Montgomery, 2006). La evidencia poblacional informa; no reemplaza el juicio. El caso particular exige seleccionar qué información importa, determinar qué regularidad es pertinente, estimar consecuencias y actuar bajo condiciones de tiempo, recursos, valores y riesgo.

La estructura más elemental de este trabajo puede dividirse en cuatro capas. La primera es lo observado: hechos clínicos con una fuente y una confiabilidad

determinadas. La segunda es lo inferido: hipótesis diagnósticas, explicaciones causales, pronósticos y atribuciones de relevancia. La tercera es lo incierto: aquello que no se conoce, aquello que se conoce sólo probabilísticamente y aquello cuya propia formulación es ambigua. La cuarta es lo decidido: una acción que incorpora no sólo probabilidad, sino gravedad, oportunidad, reversibilidad, preferencias y costo de los errores.

Cada capa se apoya en la anterior; ninguna se deduce automáticamente de ella

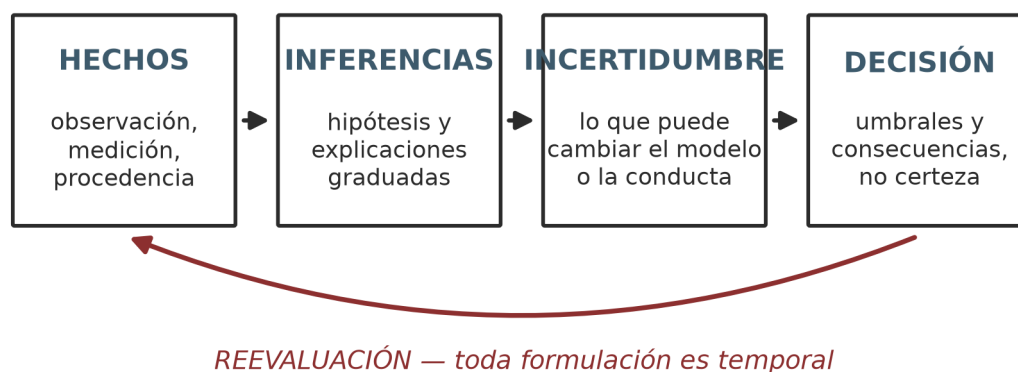


Figura 1. Las cuatro capas del conocimiento clínico y el movimiento transversal de reevaluación. Cada capa se apoya en la anterior, pero ninguna se deduce automáticamente de ella.

Estas capas se mezclan con facilidad. Una nota puede escribir "neumonía aspirativa" donde sólo existen infiltrados pulmonares y un episodio de vómito; puede declarar "infección urinaria" ante bacteriuria en un paciente sondado sin evidencia clínica de infección; puede describir "fracaso del manejo conservador" sin explicitar cuál era el objetivo, durante cuánto tiempo fue intentado y qué desenlace cambió el balance. La frase parece resolver el problema, pero en realidad oculta el camino inferencial. La nota de ingreso de Carmen —"cuadro habitual, manejo habitual"— pertenece a esta familia.

La metacognición permite examinar ese camino. Desde Flavell, el término designa el conocimiento y monitoreo de los propios procesos cognitivos (Flavell, 1979). Nelson y Narens distinguieron un nivel objeto —el proceso que realiza la tarea— y un nivel meta —el que supervisa y regula ese proceso— (Nelson & Narens, 1990). En clínica, esto implica no sólo preguntar "¿cuál es el diagnóstico?", sino "¿qué me lleva a pensar esto?", "¿qué parte es observación y qué parte interpretación?", "¿qué evidencia podría hacerme cambiar?", "¿mi confianza corresponde a mi precisión?" y "¿por qué este caso requiere actuar ahora?".

La confianza subjetiva no constituye una medida suficiente de exactitud. La investigación sobre metacognición diferencia el nivel general de confianza de la sensibilidad metacognitiva: la capacidad de asignar mayor confianza a los juicios

correctos que a los incorrectos (Fleming & Dolan, 2012; Fleming & Lau, 2014). Un clínico puede ser seguro y poco calibrado, o prudente y altamente discriminativo. La excelencia no consiste en dudar de todo, sino en ajustar la fuerza de cada afirmación a la evidencia disponible.

El lenguaje es central porque el razonamiento clínico se hace visible y transmisible mediante formulaciones. La representación del problema convierte una acumulación de datos en una descripción compacta mediante calificadores semánticos, relaciones temporales y conocimiento de enfermedades (Bordage, 1994; Bowen, 2006). Esta compresión puede aumentar la comprensión o destruirla. Una frase de alta densidad epistémica conserva las relaciones necesarias; una frase meramente abreviada omite lo que permitiría evaluar su validez.

La buena frase clínica no reemplaza al evento: revela su estructura relevante y deja visible la fuerza de sus afirmaciones.

El error diagnóstico tampoco puede reducirse a la mente aislada. La literatura sobre sesgos ha mostrado mecanismos como anclaje, disponibilidad, cierre prematuro y búsqueda satisfecha, pero el error emerge de la interacción entre conocimiento, atención, carga asistencial, comunicación, tecnología, organización y evolución de la enfermedad (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015; Norman et al., 2017). Una epistemología clínica seria debe evitar dos reduccionismos: pensar que todo error es un sesgo individual o pensar que el sistema vuelve irrelevante la responsabilidad cognitiva del médico.

La incertidumbre, finalmente, no es una etapa transitoria que desaparecerá con suficientes exámenes. Parte de ella puede reducirse; otra persiste por variabilidad biológica, indeterminación causal, límites tecnológicos, ambigüedad conceptual o contingencia futura (Fox, 1980; Han et al., 2011). La práctica madura no elimina la incertidumbre mediante retórica. La clasifica, la comunica y diseña decisiones robustas frente a ella.

Este libro propone una disciplina de lucidez clínica. Lucidez no significa omnisciencia ni certeza permanente. Significa mantener separadas, pero comunicadas, las capas del conocimiento; reconocer los mecanismos propios de razonamiento; formular hipótesis con fuerza proporcional; decidir de acuerdo con las consecuencias; y establecer de antemano cómo se revisará la decisión. La meta no es pensar siempre más, sino saber cuándo el pensamiento automático es suficiente y cuándo debe ser interrumpido.

En una frase. El conocimiento clínico tiene capas —hechos, inferencias, incertidumbre, decisión— que se mezclan con facilidad; la lucidez consiste en mantenerlas separadas pero comunicadas.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. En la última nota que escribí, ¿qué afirmación era un dato y cuál era mi interpretación del dato?

2. ¿Qué frase de la ficha de mi paciente actual heredé de otra nota sin verificar su origen?
3. ¿Cuál es la decisión concreta que este caso me exige hoy, y qué me haría cambiarla?

PARTE I

Las capas del conocimiento clínico

¿De qué está hecho lo que sabemos de un paciente? Esta parte separa los materiales: el hecho clínico y su procedencia (capítulo 1), la inferencia que lo convierte en explicación (capítulo 2), la incertidumbre que persiste (capítulo 3) y el lenguaje que puede conservar o borrar las tres capas anteriores (capítulo 4). Al final, un interludio vuelve a la cama de Carmen con estas herramientas.

Capítulo 1

El hecho clínico: observación, medición y procedencia

Son las 7:40 y el residente presenta a Carmen en el pase de visita: "Paciente séptica de foco abdominal, hernia complicada". El jefe de servicio mira la hoja de enfermería y hace una sola pregunta: "¿Qué de todo eso lo vio alguien y qué lo estamos suponiendo?". El silencio que sigue es el tema de este capítulo.

Los datos no llegan desnudos

En la conversación cotidiana llamamos hecho a algo que simplemente ocurrió. En clínica, el término requiere mayor disciplina. Un hecho clínico es una observación o medición situada, obtenida mediante una fuente y un procedimiento concretos. "Temperatura de 38,4 °C", "hemocultivo positivo", "dolor iniciado hace seis horas" y "sin signos tomográficos de perforación" no tienen la misma procedencia, resolución temporal ni vulnerabilidad al error. Su valor depende de cómo fueron producidos.

La tradición empirista hizo de la observación el punto de partida del conocimiento. Sin embargo, la filosofía de la ciencia mostró que observar implica seleccionar, clasificar y usar conceptos previos. El médico que identifica trabajo respiratorio, livedo o esclerodactilia no recibe esas entidades como objetos puros; las reconoce dentro de una práctica aprendida. Wittgenstein permitió comprender que el significado de los términos depende de su uso en una forma de vida, mientras Polanyi destacó que una parte de la pericia permanece tácita: sabemos reconocer más de lo que podemos formular exhaustivamente (Wittgenstein, 2009; Polanyi, 1966).

Esto no vuelve arbitraria la observación. Obliga a hacer explícitas sus condiciones. Un dato clínico fuerte conserva al menos cuatro atributos: fuente, método, tiempo y confiabilidad. "Paciente refiere ausencia de dolor" no equivale a "sin dolor a la palpación"; "presión radial invasiva" no equivale sin más a presión femoral en shock vasopléjico; "sin fiebre" puede significar afebril durante una hora, durante 48 horas o bajo antipiréticos. La precisión empieza antes de interpretar.

Hechos incompletos

Los hechos clínicos son incompletos por diseño. Ninguna anamnesis recoge toda la experiencia del paciente, ningún examen físico agota el cuerpo y ningún panel de laboratorio representa la totalidad del proceso biológico. La historia clínica es una muestra orientada por preguntas. Lo que no se pregunta puede quedar inexistente en el registro, aunque haya estado presente en la realidad.

La ausencia de un dato tampoco es equivalente a un hallazgo negativo. "No consignado" significa que el registro no permite saber; "no evaluado" indica que la observación no se realizó; "ausente" supone una búsqueda adecuada; "sin evidencia de" añade el límite del método. Confundir estas expresiones crea

certezas retrospectivas. En seguridad diagnóstica, la distinción entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia es fundamental; volveremos a ella cada vez que un hallazgo negativo amenace con decidir demasiado.

La medición introduce otra capa. Los valores dependen de precisión analítica, variabilidad biológica, umbrales de decisión y contexto pretest. Un lactato elevado es un hecho medido; su significado puede ser hipoperfusión, estimulación adrenérgica, menor depuración u otra causa. Una PCR elevada informa inflamación, no su etiología. El salto desde el marcador a la enfermedad pertenece ya a la inferencia.

La distinción no es académica. El ensayo ANDROMEDA-SHOCK comparó dos maneras de leer al mismo paciente en shock séptico —guiar la reanimación por la normalización del lactato o por la del relleno capilar— y la estrategia guiada por el marcador de laboratorio no resultó superior a la guiada por la perfusión periférica observada en la piel (Hernández et al., 2019). Cuando dos blancos que supuestamente "miden lo mismo" conducen a conductas y desenlaces distintos, lo que queda expuesto es exactamente la brecha entre el dato y su interpretación: el lactato era un hecho; "el paciente sigue hipoperfundido" era una inferencia que convenía someter a examen.

El testimonio como evidencia

Los síntomas no son datos inferiores por ser subjetivos. Son evidencia de otra naturaleza. El paciente informa una experiencia corporal mediante lenguaje, memoria, categorías culturales y expectativas. La tarea clínica consiste en respetar ese testimonio y, al mismo tiempo, examinar su forma temporal, desencadenantes, consistencia y relación con otros hallazgos. La medicina narrativa ha recordado que la historia no es ruido alrededor del diagnóstico; es una de sus fuentes constitutivas (Hunter, 1991; Charon, 2006).

El problema surge cuando el relato es traducido demasiado rápido a una categoría diagnóstica. "Opresión cervical" puede transformarse en "disfagia", "sensación de falta de aire" en "disnea" y "mareo" en "vértigo" sin haber preservado la descripción original. Cada traducción añade inferencia. Una buena nota conserva suficiente material fenomenológico para que otro clínico pueda reconstruir el paso.

Carmen, por ejemplo, no dijo "dolor abdominal difuso": dijo que esta vez "la hernia no se dejó acomodar", que el dolor "era otro" y que por primera vez le dio miedo. Tres datos con forma de frase. La nota que los reduce a "dolor abdominal en paciente con hernia conocida" no ha mentido; ha destruido información.

Trazabilidad epistemológica

Canguilhem mostró que la medicina no describe simplemente desviaciones estadísticas: juzga relaciones entre el organismo, sus normas y su capacidad de habitar un medio (Canguilhem, 1991). El hecho clínico adquiere relevancia dentro de esa relación. Una cifra fuera de rango puede ser irrelevante; una

variación dentro del rango puede ser decisiva para ese paciente. La observación científica y la singularidad no son opuestas, pero deben articularse.

Por ello, conviene escribir los hechos de modo trazable. Una formulación como "shock séptico abdominal" fusiona estado fisiológico, etiología y foco. Una versión más limpia separa: hipotensión con requerimiento de noradrenalina, hiperlactatemia y relleno capilar prolongado; hemocultivos con bacilos gramnegativos; episodio obstructivo por hernia incisional; sin perforación, isquemia ni estrangulación en tomografía. Recién después puede formularse el foco abdominal como hipótesis probable.

Un hecho clínico no es una verdad sin historia: es una observación con procedencia, oportunidad, método y límites.

La práctica mejora cuando el médico puede responder, para cada afirmación relevante: ¿quién lo observó?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué sensibilidad?, ¿qué no permite concluir? Esa disciplina no vuelve lenta toda decisión. Con la experiencia se vuelve una forma de lectura. Su objetivo es impedir que la interpretación borre las huellas del dato que la sostiene.

Grados de facticidad

No todos los hechos clínicos poseen la misma solidez. Puede distinguirse un gradiente: dato directamente medido y verificable; observación profesional reproducible; relato consistente del paciente o tercero; dato heredado de una nota anterior; y ausencia inferida porque algo no fue registrado. Esta jerarquía no pretende desacreditar el relato. Busca que la procedencia viaje junto con la afirmación. "Paciente niega fiebre", "afebril durante observación" y "sin fiebre" no son equivalentes.



Ninguna categoría es despreciable; cada una exige un lenguaje distinto

Figura 2. Gradiente de facticidad: la solidez de un "hecho" clínico depende de su procedencia. Ninguna categoría es despreciable, pero cada una exige un lenguaje distinto.

Los hallazgos negativos exigen especial cautela. "Sin peritonismo" puede significar examen dirigido negativo; "sin evidencia de isquemia en TAC" limita la conclusión al rendimiento de una técnica y a un momento; "no refiere dolor" depende de capacidad comunicativa, neuroanatomía y contexto. El lenguaje debe impedir que ausencia de evidencia se transforme automáticamente en evidencia de ausencia.

Caja de herramientas. Tres metadatos por hecho decisivo

Una práctica útil consiste en adjuntar mentalmente tres metadatos a cada hecho que sostiene una conclusión importante: **fuentes** (¿quién lo produjo: el paciente, un profesional, un instrumento, una nota anterior?), **momento** (¿cuándo, y qué ha pasado desde entonces?) y **método** (¿con qué sensibilidad y en qué condiciones?). Cuando una conclusión depende de un dato frágil, esa fragilidad debe elevarse a la formulación del problema. La trazabilidad no agrega burocracia cuando está bien hecha: permite que otro clínico pueda reconstruir el juicio, detectar dónde cambiaría y evitar que una frase repetida adquiriera autoridad sólo por antigüedad.

Taller 1. ¿Qué tan hecho es este hecho?

Clasifique cada afirmación según el gradiente de facticidad (medido / observado por profesional / relato / heredado / ausencia inferida) y reescriba la que considere más frágil:

1. "Lactato 6,0 mmol/L (7:15, arterial)."
2. "Abdomen sin signos de irritación peritoneal."
3. "Alérgica a penicilina."
4. "Sin episodios previos de sangrado."
5. "La hernia no se dejó acomodar y el dolor era distinto al de otras veces."

Solución comentada. (1) Medido, con hora y método: el hecho más sólido de la lista. (2) Observación profesional: sólida, pero reproducible sólo si consigna quién y cuándo examinó; en un abdomen que evoluciona, el examen de las 3:00 no cubre las 9:00. (3) Casi siempre heredado: pocas fichas registran quién documentó la alergia, cuándo y con qué reacción; merece la reescritura "alergia a penicilina referida por la paciente (rash, según recuerda; sin registro del episodio)". (4) Ausencia inferida o relato, según cómo se obtuvo: "niega sangrados previos" (relato) no equivale a "sin sangrados documentados en ficha" (revisión de registro). (5) Relato del paciente con material fenomenológico intacto: frágil como medición, valiosísimo como señal de cambio; consérvelo textual.

En una frase. Un hecho clínico vale lo que vale su procedencia: fuente, momento, método y límites deben viajar con la afirmación.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál es el dato más decisivo de mi evaluación de hoy y quién lo produjo realmente?
2. ¿Qué "hallazgo negativo" estoy tratando como evidencia de ausencia sin preguntarme por la sensibilidad de la búsqueda?
3. ¿Qué dijo mi paciente con sus propias palabras que yo ya traduje a jerga?

Capítulo 2

Inferir: del signo a la explicación

En la carpeta de Carmen, la tomografía informa: "hernia incisional con asas dilatadas, sin signos de isquemia ni perforación". El residente escribe: "TAC descarta complicación". Son siete palabras que transforman un informe radiológico en una sentencia. Este capítulo trata del salto —inevitable, necesario, riesgoso— entre lo que vemos y lo que concluimos.

La medicina como razonamiento abductivo

El diagnóstico no aparece contenido dentro del dato. Se propone como la explicación que mejor organiza un conjunto de hallazgos. Peirce describió este movimiento —que en 1878 llamó "hipótesis" y en sus lecciones de 1903 bautizó "abducción"— como la operación por la cual formulamos una conjetura capaz de hacer inteligible un hecho sorprendente. La deducción deriva consecuencias de una regla; la inducción aprende regularidades desde casos; la abducción pregunta qué explicación, si fuera verdadera, volvería esperable lo observado (Peirce, 1878).

La clínica combina los tres movimientos. El médico reconoce un patrón y propone una hipótesis; deduce qué otros hallazgos deberían existir; busca o solicita información; luego actualiza la plausibilidad de las alternativas. El proceso no es lineal. La anamnesis ya está guiada por hipótesis incipientes y cada respuesta modifica qué se pregunta después. Los estudios clásicos del proceso de razonamiento clínico documentaron precisamente eso: la generación temprana de hipótesis y su refinamiento iterativo durante el encuentro (Elstein et al., 1978; Barrows & Feltovich, 1987). La investigación posterior desplazó la idea de una habilidad general de razonamiento hacia el papel del conocimiento organizado: prototipos, ejemplares, esquemas e illness scripts (Norman, 2005; Schmidt & Rikers, 2007).

Representar el problema

Una representación del problema es una formulación breve que transforma datos particulares en relaciones clínicamente significativas. Utiliza calificadores como agudo o crónico, focal o difuso, progresivo o episódico, espontáneo o provocado. Bordage destacó que estas oposiciones semánticas ayudan a activar redes diagnósticas y a comparar el caso con estructuras de conocimiento elaboradas (Bordage, 1994).

La compresión no debe confundirse con amputación. "Mujer de 60 años con dolor abdominal" tiene poco poder discriminativo. "Mujer de 60 años con hernia incisional y episodios recurrentes de suboclusión, que presenta obstrucción aguda asociada a shock, bacteriemia por gramnegativos y recuperación con soporte hemodinámico y antibióticos, sin signos tomográficos de isquemia o perforación" conserva temporalidad, recurrencia, gravedad, evidencia microbiológica y límites anatómicos.

Una buena representación permite que el conocimiento experto se aplique sin ocultar los hechos. Los illness scripts integran condiciones predisponentes, mecanismos fisiopatológicos y consecuencias clínicas (Charlin et al., 2007; Custers, 2015). Con la experiencia, el conocimiento biomédico se encapsula en conceptos clínicos más accesibles, pero puede ser desplegado nuevamente cuando el caso no encaja (Schmidt & Rikers, 2007).

Inferencias con distinta fuerza

No todas las inferencias merecen el mismo lenguaje. Algunas son definicionales: una presión arterial baja con signos de hipoperfusión configura shock, aunque su mecanismo sea incierto. Otras son probabilísticas: una bacteriemia por enterobacteriales durante una obstrucción intestinal hace plausible un foco abdominal. Otras son causales y exigen más: afirmar que la hernia produjo translocación bacteriana implica una cadena no observada directamente.

La fuerza de una inferencia aumenta por convergencia. Importan la compatibilidad fisiopatológica, la secuencia temporal, la especificidad de los hallazgos, la respuesta a intervenciones, la ausencia de explicaciones rivales y la coherencia con la prevalencia. Ningún criterio aislado garantiza causalidad. La mejor explicación actual sigue siendo revisable.

El razonamiento bayesiano formaliza parte de este proceso: la evidencia modifica una probabilidad previa según su capacidad discriminativa. Sin embargo, la clínica cotidiana rara vez dispone de probabilidades precisas. Incluso así, el principio permanece: un hallazgo no tiene significado fijo; cambia la plausibilidad de hipótesis en relación con el contexto. Las frecuencias naturales pueden mejorar la comprensión de este cambio y reducir errores intuitivos con probabilidades condicionales (Hoffrage & Gigerenzer, 1998; Gigerenzer et al., 2007).

Explicaciones rivales y prueba de resistencia

Una inferencia se fortalece cuando sobrevive a alternativas serias. Preguntar "¿qué más podría producir este conjunto?" no exige elaborar listas interminables. Exige identificar competidores capaces de modificar la conducta. La hipótesis rival debe tener derecho a explicar los mismos hechos, no ser un nombre añadido por obligación ritual.

Una prueba de resistencia útil contiene cuatro preguntas: ¿qué dato es más difícil de explicar con mi hipótesis?, ¿qué hallazgo esperaría y no está?, ¿qué explicación rival produciría una conducta diferente?, ¿qué nueva información haría cambiar mi jerarquía? Estas preguntas convierten el diagnóstico diferencial en una herramienta de falsación práctica.

La lección de Popper, bien leída, no es el eslogan de que toda hipótesis deba poder refutarse en el acto. Es una asimetría más fina: las confirmaciones valen poco cuando se obtienen buscando lo que la hipótesis predice cómodamente, y valen mucho cuando provienen de pruebas severas — aquellas que tenían una probabilidad real de desmentirla (Popper, 1959). En clínica, esto distingue dos

maneras de pedir exámenes: el que confirma lo que ya se cree —otro marcador inflamatorio en quien ya fue etiquetado de infección— y el que somete la hipótesis a riesgo — el examen cuyo resultado obligaría a abandonar el diagnóstico si vuelve normal. Un diagnóstico que sólo acumula hallazgos "compatibles" no está corroborado; está mimado.

La inferencia clínica no es una licencia para completar la realidad; es una hipótesis graduada que debe conservar el camino de regreso a los hechos.

El objetivo no es evitar inferir. Sin inferencias no hay medicina. La lucidez consiste en reconocer el momento exacto en que dejamos de describir y comenzamos a explicar, y en asignar a esa explicación la fuerza que realmente posee.

Explicar, predecir y actuar

Una hipótesis puede explicar bien el pasado y predecir mal el futuro. También puede orientar una conducta útil sin identificar el mecanismo último. Esta distinción importa porque el diagnóstico cumple funciones diferentes: clasificar, explicar, estimar pronóstico y seleccionar una intervención. La misma etiqueta no garantiza éxito en todas.

La abducción elige la explicación más plausible; la predicción pregunta qué debería observarse después; la decisión evalúa qué acción es preferible aun si la explicación permanece abierta. En ocasiones varias etiologías convergen en el mismo manejo inicial. En otras, una pequeña diferencia causal cambia por completo la conducta. Por eso, el diagnóstico diferencial debe organizarse según discriminación clínica y no sólo semejanza nominal.

Una inferencia gana calidad cuando produce compromisos observables: "si esta explicación es correcta, debería mejorar X antes de Y", "esperaría encontrar Z", "la ausencia persistente de W disminuiría su probabilidad". Estos compromisos evitan que la hipótesis se vuelva inmune a la experiencia. También hacen posible una revisión prospectiva, menos contaminada por el desenlace conocido. El buen razonamiento no se limita a contar una historia coherente; especifica qué realidad podría desmentirla.

Taller 2. La sentencia del TAC

El informe dice: "hernia incisional con asas dilatadas, sin signos de isquemia ni perforación". El residente escribió: "TAC descarta complicación". Reescriba la frase para que conserve (a) lo que la imagen mostró, (b) lo que la imagen no puede mostrar, y (c) la inferencia que de verdad autoriza.

Solución comentada. Una versión defendible: "TAC sin signos de isquemia, perforación ni estrangulación **en este momento**; no excluye isquemia incipiente ni predice recurrencia. Con clínica y laboratorio actuales, baja probabilidad de complicación anatómica que exija cirugía de emergencia." La diferencia no es cosmética: "descarta complicación" cierra la vigilancia; la reescritura define qué

se vigila (deterioro clínico, nuevo dolor desproporcionado, lactato en ascenso) y qué autoriza (no operar de urgencia ahora, no "no operar nunca"). Nótese el patrón general: el hallazgo negativo se limita al rendimiento del método y al momento; la conducta se justifica por umbral, no por exclusión ontológica.

En una frase. Inferir es proponer la mejor explicación disponible sabiendo que es una apuesta graduada, no un hecho que la realidad ya entregó.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál es el dato más difícil de explicar con mi hipótesis principal?
2. ¿Qué explicación rival cambiaría mi conducta hoy, y qué me costaría buscarla?
3. ¿Qué predicción concreta hace mi diagnóstico para las próximas 24 horas?

Capítulo 3

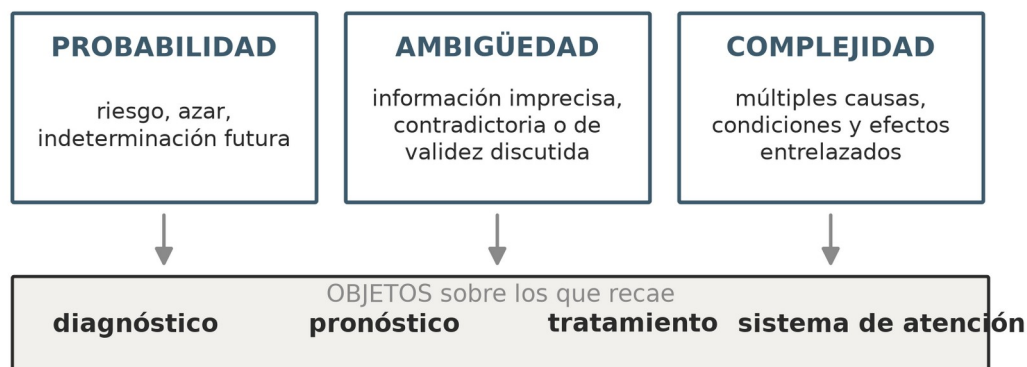
Incertidumbre: una condición estructural

A las 48 horas, Carmen está estable, afebril, con la sonda en declive. La familia pregunta: "¿Ya saben qué tuvo?". El equipo sabe muchas cosas: que hubo obstrucción, que hubo shock, que los hemocultivos crecieron gramnegativos, que la imagen no mostró isquemia. Y no sabe otras: por qué esta vez fue tan grave, si la bacteriemia vino del abdomen, cuándo volverá a obstruirse. "¿Ya saben qué tuvo?" tiene, en rigor, varias respuestas simultáneas. Este capítulo trata de cómo nombrarlas sin mentir en ninguna dirección.

Más que falta de información

La incertidumbre clínica suele describirse como aquello que aún no sabemos. Esa definición captura una parte, pero no toda. Podemos desconocer porque faltan datos, porque los datos son contradictorios, porque las probabilidades son imprecisas, porque el fenómeno es complejo o porque el futuro permanece abierto. Han y colaboradores distinguieron fuentes relacionadas con probabilidad, ambigüedad y complejidad, y mostraron que la incertidumbre puede referirse al diagnóstico, pronóstico, tratamiento o funcionamiento del sistema (Han et al., 2011).

FUENTES de la incertidumbre (Han et al., 2011)



Cada combinación pide una respuesta distinta:

reducir con información · aclarar con evolución · tolerar con vigilancia · conversar (valores)

Figura 3. Un mapa de la incertidumbre clínica (adaptado de la taxonomía de Han et al.): fuentes y objetos se combinan, y cada combinación pide una respuesta distinta.

También conviene separar incertidumbre epistémica y aleatoria. La primera surge de conocimiento insuficiente y, en principio, puede reducirse mediante nueva información. La segunda proviene de variabilidad o contingencia que persiste incluso con buen conocimiento. En la práctica ambas se mezclan. Una

tomografía puede reducir la incertidumbre sobre perforación, pero no determinar con certeza si una obstrucción volverá a ocurrir ni cuándo.

Frank Knight distinguió riesgo —cuando las probabilidades pueden estimarse— de incertidumbre en sentido estricto —cuando ni siquiera contamos con una distribución confiable— (Knight, 1921). La medicina moderna cuantifica cada vez mejor algunos riesgos, pero conserva extensas zonas knightianas: pacientes excluidos de estudios, combinaciones infrecuentes, desenlaces dependientes de múltiples decisiones y contextos locales cambiantes.

La formación médica y la fantasía de certeza

Renée Fox describió cómo la incertidumbre acompaña la socialización médica: al inicio el estudiante no sabe si su duda se debe a ignorancia personal o a límites de la disciplina; más tarde aprende que incluso los expertos habitan zonas de no saber (Fox, 1980). La cultura médica, sin embargo, puede premiar la respuesta rápida y penalizar la duda visible. El resultado es una retórica de seguridad que no siempre corresponde a la evidencia.

Simpkin y Schwartzstein propusieron que tolerar la incertidumbre constituye una competencia central y no una debilidad profesional (Simpkin & Schwartzstein, 2016). Tolerar no significa resignarse ni abandonar la investigación. Significa no llenar prematuramente el vacío con una certeza ficticia. El médico competente reduce la incertidumbre que puede reducirse y organiza una conducta segura frente a la que permanece.

La intolerancia puede expresarse como sobreestudio, sobretratamiento, cierre prematuro o derivación defensiva. Curiosamente, conductas opuestas pueden tener la misma raíz: necesidad de escapar de la ambigüedad. Gérvas y Pérez Fernández han documentado la versión poblacional de esa intolerancia: cascadas de intervenciones innecesarias que nacen de no soportar la espera vigilante, y que dañan con especial eficacia a los más sanos (Gérvas & Pérez Fernández, 2013). Por ello, la pregunta no es sólo cuánta incertidumbre existe, sino qué hacemos emocional y cognitivamente con ella.

Incetidumbre precisa

Decir "todo es incierto" no aporta. La incertidumbre útil es específica. Puede formularse así: el diagnóstico principal es probable, pero el mecanismo exacto no está demostrado; la infección parece poco probable, aunque no puede excluirse por ausencia de síntomas típicos; la imagen no muestra isquemia en este momento, pero no elimina el riesgo de recurrencia; la respuesta terapéutica apoya una hipótesis, sin ser específica de ella.

Una cartografía clínica de la incertidumbre puede distinguir:

- lo desconocido que puede resolverse con un examen;
- lo que sólo puede aclararse con evolución temporal;
- lo que no cambiaría la conducta inmediata;
- lo que, si estuviera equivocado, produciría daño grave;

- lo que depende de valores y preferencias más que de información adicional.

La incertidumbre más importante no siempre es la mayor. Una duda pequeña puede dominar la decisión si el error asociado es catastrófico. Por el contrario, una amplia incertidumbre etiológica puede ser tolerable cuando varias explicaciones comparten el mismo manejo inicial.

La certeza práctica

Kassirer criticó la búsqueda obstinada de certeza diagnóstica porque puede generar pruebas innecesarias sin eliminar el residuo de duda (Kassirer, 1989). La práctica requiere una certeza diferente: suficiente para actuar. Esta certeza práctica no afirma que el mundo haya quedado resuelto. Afirma que, dados los hechos, consecuencias y alternativas, una conducta supera un umbral razonable.

Gadamer observó que la medicina es una praxis orientada a restablecer un equilibrio, no una mera aplicación técnica de conocimiento universal (Gadamer, 1996). La decisión se completa en la situación. Su racionalidad incluye aquello que todavía no puede saberse y la obligación de vigilar cómo evoluciona.

La incertidumbre no es el espacio vacío entre los hechos y la decisión; es una dimensión positiva del caso que debe describirse y gobernarse.

Una medicina lúcida no promete eliminar toda incertidumbre. Promete distinguir sus fuentes, comunicar su alcance, proteger al paciente de sus consecuencias y revisar la conducta cuando el mundo entregue nueva información.

Taller 3. El mapa de lo que no sabemos de Carmen

Tome las cuatro dudas del equipo: (a) ¿por qué este episodio fue tan grave?, (b) ¿la bacteriemia vino del abdomen?, (c) ¿cuándo volverá a obstruirse?, (d) ¿resistirá una cirugía electiva? Clasifique cada una según la cartografía del capítulo (reducible con examen / dependiente de evolución / irrelevante para la conducta inmediata / peligrosa si está equivocada / dependiente de valores).

Solución comentada. (a) Parcialmente reducible (revisar imagen, laboratorio, cronología) pero con residuo probablemente irreducible: puede quedar "no demostrado" sin bloquear ninguna decisión. (b) Reducible sólo en parte (cultivos, foco alternativo); importa porque cambia la duración antibiótica, no la conducta quirúrgica: incertidumbre tolerable con decisión robusta. (c) Irreducible por examen: sólo la evolución la aclarará; es la duda **peligrosa**, porque el error (esperar y que el próximo episodio sea peor) tiene el costo más alto. Domina la decisión. (d) Mixta: la evaluación preoperatoria la reduce; el resto es preferencia de Carmen —cuánto riesgo quirúrgico acepta hoy para evitar un riesgo obstructivo mañana—, es decir, valores. La clasificación no resuelve el caso: ordena qué se estudia, qué se vigila, qué se conversa y qué se tolera.

En una frase. No hay una incertidumbre sino varias: distinguir cuál se reduce, cuál se vigila, cuál se tolera y cuál se conversa es parte del trabajo clínico, no su fracaso.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. De todo lo que no sé de este paciente, ¿qué duda cambiaría mi conducta si se resolviera?
2. ¿Cuál es la duda pequeña con consecuencia catastrófica que merece vigilancia explícita?
3. ¿Qué parte de mi plan depende de valores del paciente que aún no he preguntado?

Capítulo 4

Lenguaje clínico y densidad epistémica

En el pase de sala, dos residentes presentan a la misma Carmen. Uno dice: "Paciente con hernia y sepsis, actualmente mejor". La otra dice: "Episodio obstructivo recurrente por hernia incisional, esta vez asociado a bacteriemia por gramnegativos, shock e hipoperfusión grave, con resolución bajo soporte y antibióticos y sin signos tomográficos de isquemia o perforación; la mayor gravedad redefine el riesgo de una nueva estrategia expectante". Los dos dicen la verdad. Sólo una de las dos frases piensa.

Nombrar es organizar

El lenguaje clínico no se limita a transportar un pensamiento previamente terminado. Ayuda a producirlo. Al elegir entre "dolor torácico", "dolor pleurítico" y "dolor opresivo de esfuerzo", el médico no sólo cambia palabras: delimita mecanismos, comparadores y preguntas. Al escribir "compatible con", "probable" o "demostrado", establece una relación entre evidencia y confianza.

La filosofía hermenéutica recuerda que comprendemos desde un horizonte lingüístico e histórico. Gadamer sostuvo que el lenguaje es el medio en el que algo llega a ser comprendido; Foucault mostró que la mirada clínica moderna se organizó mediante formas específicas de describir, localizar y correlacionar signos (Foucault, 1973; Gadamer, 1996). Estas perspectivas no obligan a pensar que toda descripción sea relativa. Obligan a reconocer que las categorías hacen visible una parte de la realidad y pueden ocultar otra.

Compresión y pérdida

La representación del problema es una operación de compresión. Su calidad puede evaluarse por cuánto significado conserva. Una frase es densa cuando incluye los ejes que cambian la interpretación: tiempo, severidad, recurrencia, contexto, mecanismo probable, evidencia contraria y consecuencia práctica. No es densa por acumular adjetivos.

Las dos presentaciones de Carmen que abren este capítulo son el ejemplo. La segunda distingue hechos, inferencia etiológica, evidencia negativa, evolución y efecto sobre la decisión. También conserva incertidumbre: no afirma estrangulación ni perforación si no fueron demostradas. La primera no es falsa; es hueca. Comprimió hasta perder la estructura.

Modalidad epistémica

El lenguaje científico dispone de recursos para calibrar afirmaciones. La investigación sobre hedging en textos médicos mostró que expresiones de cautela no son meros adornos defensivos; cumplen funciones retóricas y epistémicas al limitar el alcance de una conclusión (Salager-Meyer, 1994; Hyland, 1998). En clínica, el problema no es usar "probable", sino usarlo sin criterio o reemplazar con él una explicación ausente.

Puede distinguirse una escala práctica:

- **Documentado o demostrado:** existe evidencia directa suficiente bajo un método pertinente.
- **Altamente probable:** múltiples líneas convergentes, con alternativas importantes poco plausibles.
- **Probable o compatible con:** la explicación organiza bien los hechos, pero persisten rivales o faltan elementos.
- **Posible:** no contradice los datos y merece consideración, aunque el soporte es limitado.
- **No demostrado:** la hipótesis puede ser razonable, pero el caso no aporta evidencia suficiente para afirmarla.
- **Sin evidencia de:** el método empleado no mostró el fenómeno; la fuerza depende de su sensibilidad y oportunidad.

"Se descarta" debería reservarse para situaciones en que el método y el contexto realmente permiten excluir. Con frecuencia es más exacto escribir "sin evidencia actual de" o "probabilidad suficientemente baja para no justificar". El Apéndice B desarrolla este léxico completo, con ejemplos de uso correcto e incorrecto de cada término.

Verbos que ocultan

Algunos verbos compactan causalidad sin mostrarla: "secundario a", "debido a", "complicado por", "en contexto de". Son útiles, pero pueden convertir correlación temporal en mecanismo. "En contexto de" es especialmente ambiguo: a veces significa coexistencia, otras causalidad probable y otras simple proximidad narrativa. La buena escritura especifica la relación cuando importa.

También debe evitarse la autoridad retrospectiva. Una evolución favorable después de antibióticos no demuestra por sí sola etiología bacteriana; una respuesta a diuréticos no prueba que todo el cuadro fuera cardiogénico; la normalización espontánea no invalida la gravedad inicial. El relato clínico tiende a construir una historia coherente una vez conocido el desenlace. La nota contemporánea debe preservar qué se sabía en cada momento.

Frases operativas

Una frase operativa enlaza comprensión con acción. No prescribe necesariamente una conducta única, pero explica por qué cambia el umbral. "Tercer episodio de suboclusión" informa recurrencia; "primer episodio complicado por shock y bacteriemia" informa un cambio cualitativo; "sin evidencia de isquemia actual" limita la urgencia anatómica; "riesgo de nueva recurrencia potencialmente grave" informa la oportunidad de resolución electiva.

La precisión clínica consiste en decir qué creemos, por qué lo creemos y cuánto derecho tenemos a creerlo.

La buena prosa médica no busca sonar prudente ni categórica. Busca que la gramática de la frase corresponda a la arquitectura de la evidencia. Cuando lo logra, el lenguaje se convierte en instrumento de metacognición: obliga al médico a descubrir si realmente ha distinguido el hecho de la inferencia y si su confianza tiene fundamento.

La sintaxis como registro de auditoría

La estructura gramatical puede mostrar o esconder causalidad. "Shock séptico por hernia" comprime una cadena compleja en una preposición. "Shock con bacteriemia por gramnegativos, temporalmente asociado a obstrucción por hernia; foco abdominal probable, mecanismo exacto no demostrado" separa observación, asociación e inferencia causal. La segunda formulación es más larga, pero también más auditable.

Los verbos cumplen una función epistémica: "muestra" y "documenta" se reservan para evidencia directa; "apoya" expresa contribución; "sugiere" reconoce interpretación; "explica" compromete una relación más fuerte; "no excluye" delimita el rendimiento negativo. Los adverbios de certeza sólo son útiles si corresponden a criterios compartidos. Sin ellos, "probablemente" puede significar desde una intuición leve hasta una convicción casi definitiva.

La escritura clínica mejora cuando cada oración responde una pregunta: ¿qué ocurrió?, ¿qué significa?, ¿cuánto respaldo tiene?, ¿por qué importa ahora? Una frase que intenta responderlas todas sin marcadores suele mezclar niveles. Separar no empobrece la prosa. Hace visible el razonamiento y permite que la discrepancia futura se localice con precisión.

Taller 4. Cinco frases para reescribir

Reescriba cada frase para que la fuerza del lenguaje corresponda a la fuerza de la evidencia disponible (invente los mínimos datos verosímiles que necesite):

1. "Se descarta tromboembolismo pulmonar."
2. "Neumonía que respondió a antibióticos."
3. "Paciente poco colaborador."
4. "ITU en tratamiento" (paciente sondado, urocultivo positivo, afebril, sin síntomas nuevos).
5. "Fracaso de manejo médico."

Solución comentada. (1) "AngioTAC sin evidencia de TEP; probabilidad clínica pretest baja: no se justifica más estudio por ahora" —el método, su resultado y la decisión por umbral quedan separados. (2) "Infiltrado con mejoría clínica bajo antibióticos, soporte y kinesioterapia simultáneos; etiología bacteriana probable, no demostrada" —la respuesta terapéutica es un hecho; su atribución causal, una inferencia. (3) "Responde con monosílabos; refiere dolor 8/10 y no durmió; evaluación limitada por dolor no controlado" —el adjetivo moral se sustituye por observaciones y una causa verificable. (4) "Bacteriuria en usuario de sonda, sin

síndrome clínico atribuible: no se trata; vigilancia según criterios explícitos" —la etiqueta "ITU" activaba antibióticos que los hechos no piden. (5) "Objetivo del manejo médico era X durante Y días; se alcanzó/no se alcanzó Z; el balance cambia por W" —"fracaso" sin objetivo, plazo ni desenlace es retórica, no evaluación.

En una frase. La gramática de la frase clínica debe corresponder a la arquitectura de la evidencia: eso la vuelve auditable y convierte la escritura en metacognición.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. En mi última evolución, ¿qué verbo causal ("secundario a", "por", "complicado por") no podría defender si me lo preguntaran?
2. ¿Escribí "se descarta" donde sólo tenía "sin evidencia actual de"?
3. Si otro médico leyera sólo mi frase final, ¿sabría qué vigilar y qué me haría cambiar?

Interludio I**La ficha de Carmen**

Al tercer día, la becada del servicio reescribe la evaluación de Carmen usando lo que esta parte del libro ha ido separando. Su versión:

Hechos. Cuarto episodio obstructivo en doce meses en hernia incisional conocida (tres previos resueltos con manejo médico, según fichas de esos ingresos). Este episodio: hipotensión con requerimiento de noradrenalina por 36 horas, lactato máximo 6,0 (7:15 del ingreso, arterial), relleno capilar 5 segundos documentado por enfermería, hemocultivos 2/2 con bacilos gramnegativos (identificación pendiente), TAC de ingreso sin signos de isquemia, perforación ni estrangulación. Afebril y sin drogas vasoactivas desde hace 24 horas. Refiere, textual: "esta vez la hernia no se dejó acomodar, el dolor era otro".

Inferencias. Obstrucción intestinal por hernia incisional: demostrada. Foco abdominal de la bacteriemia: probable (secuencia temporal y microbiología compatible; sin foco alternativo evidente); mecanismo exacto —¿translocación?, ¿isquemia transitoria no captada?— no demostrado. Gravedad de este episodio: cualitativamente distinta de los previos (primer shock, primera bacteriemia).

Incetidumbre. Probabilidad y momento de una nueva obstrucción: no estimables con precisión; la historia reciente (cuatro episodios en un año, el último grave) desplaza el riesgo hacia arriba. Aptitud quirúrgica tras la recuperación: por evaluar. La duda peligrosa no es etiológica sino pronóstica: un quinto episodio podría repetir o superar esta gravedad fuera del hospital.

Decisión. Completar antibióticos según foco probable; evaluación quirúrgica temprana para reparación electiva una vez optimizada. El argumento no es "fracasó el manejo médico" —los tres episodios previos se resolvieron—, sino que la gravedad alcanzada cambia el costo esperado de seguir esperando. Reevaluar si reaparece dolor desproporcionado, fiebre, íleo o inestabilidad; responsable de seguimiento: equipo tratante, con control quirúrgico ambulatorio si alta antes de la evaluación.

El jefe de servicio lee la nota y no agrega nada clínico. Sólo comenta: "Ahora la ficha piensa. Cualquiera que la abra mañana sabe qué vimos, qué creemos, qué nos falta y por qué hacemos lo que hacemos". La frase de ingreso —"cuadro habitual, manejo habitual"— sigue en la primera página, como recordatorio de lo que una frase puede ocultar.

PARTE II

La mente que se observa

Si la Parte I separó los materiales del conocimiento clínico, esta parte se pregunta por el instrumento que los maneja: la propia mente del médico. ¿Cómo se monitorea el juicio mientras juzga (capítulo 5)? ¿Qué es la intuición experta y cuándo merece confianza (capítulo 6)? ¿Cómo se produce realmente el error diagnóstico, más allá del catálogo de sesgos (capítulo 7)? ¿Y cuándo conviene desacelerar (capítulo 8)? El interludio final vuelve a Carmen: esta vez no a su ficha, sino a la cabeza de quienes la atienden.

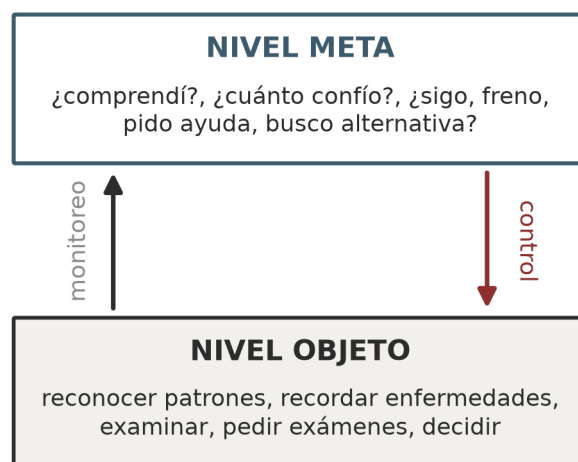
Capítulo 5

Metacognición: monitorear y regular el propio juicio

Hay un momento, en la madrugada de cualquier turno, en que el diagnóstico "se siente" correcto. Yo aprendí a desconfiar de esa sensación una noche en que la sentí con total nitidez: un cólico renal típico, dolor lumbar irradiado, un paciente joven que se retorció. Estaba tan seguro que casi no examiné el abdomen. El aneurisma lo encontró el ecografista de la mañana. Desde entonces distingo dos preguntas que esa noche confundí: "¿qué tan seguro me siento?" y "¿qué tan probable es que esté en lo cierto?". Este capítulo trata de la diferencia entre ambas.

Pensar sobre el pensamiento

Flavell definió la metacognición como conocimiento y cognición acerca de los fenómenos cognitivos, e incluyó experiencias, metas y estrategias de regulación (Flavell, 1979). Nelson y Narens propusieron una arquitectura en dos niveles: el nivel objeto realiza la tarea y el nivel meta recibe información sobre su desempeño y ejerce control sobre él (Nelson & Narens, 1990). La distinción es especialmente fértil en medicina, y la psicología experimental la ha convertido en un campo maduro, con métodos propios para estudiar cómo la gente monitorea su memoria, su comprensión y sus decisiones (Dunlosky & Metcalfe, 2009).



Ambos niveles usan señales imperfectas: la supervisión también puede equivocarse

Figura 4. El modelo de dos niveles de Nelson y Narens: el nivel meta recibe información del nivel objeto (monitoreo) y ejerce control sobre él. Ninguno de los dos es infalible.

En el nivel objeto, el clínico reconoce patrones, recupera enfermedades, solicita exámenes y decide. En el nivel meta, estima si comprendió el caso, detecta

conflicto, valora confianza, decide buscar ayuda o frenar el cierre. El segundo nivel no observa el primero desde una posición perfecta. También usa señales incompletas: fluidez, familiaridad, emoción, dificultad, coherencia narrativa y respuesta de otros.

Confianza y calibración

La confianza es una experiencia útil, pero no equivale a precisión. La investigación contemporánea distingue sesgo metacognitivo —tendencia global a usar niveles altos o bajos de confianza— de sensibilidad metacognitiva —capacidad de discriminar entre respuestas correctas e incorrectas— (Fleming & Dolan, 2012; Fleming & Lau, 2014). Dos médicos con igual exactitud pueden diferir en su capacidad de saber cuándo probablemente están equivocados. Fleming ha mostrado que esta capacidad de autoconocimiento varía entre personas, puede medirse y, al menos en parte, entrenarse (Fleming, 2021).

La calibración compara confianza y desempeño a lo largo de múltiples decisiones. Es difícil obtenerla en clínica porque el desenlace puede tardar, permanecer ambiguo o no regresar al médico. La falta de retroalimentación favorece una ilusión de competencia: recordamos diagnósticos confirmados y perdemos de vista casos que evolucionaron en otro lugar. La National Academies destacó la necesidad de sistemas que entreguen feedback diagnóstico y permitan aprender de errores y casi errores (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015).

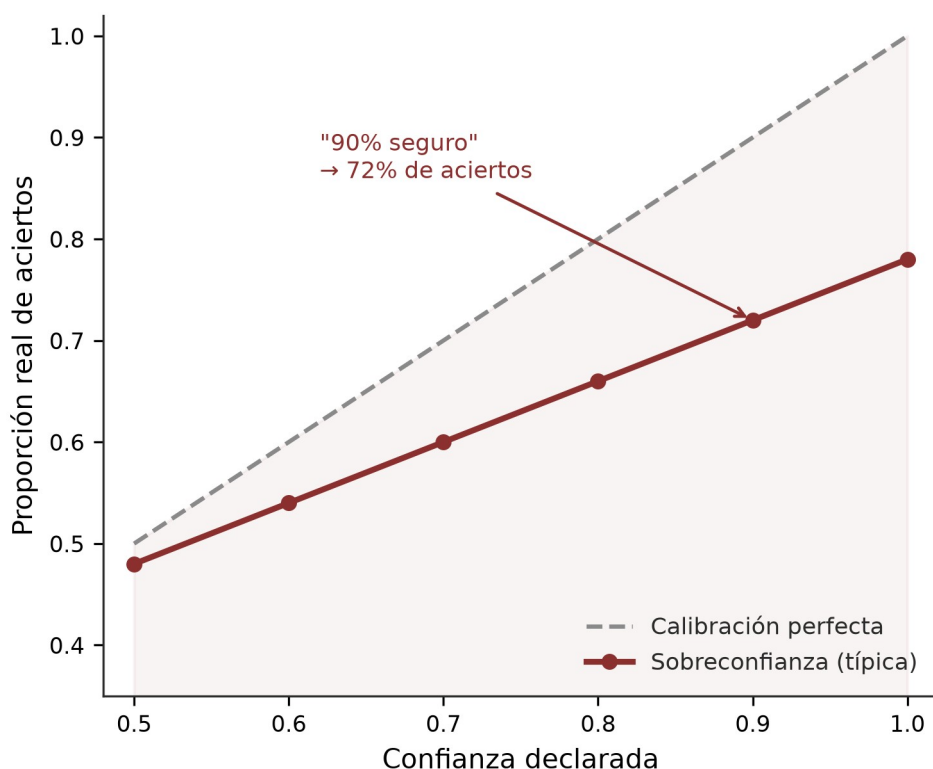


Figura 5. Curva de calibración: la diagonal representa la correspondencia perfecta entre confianza y proporción de aciertos. La sobreconfianza vive debajo de la diagonal; el exceso de prudencia, encima. Sin registrar predicciones y desenlaces, nadie sabe en qué curva está.

Eva y Regehr cuestionaron la idea de que la autoevaluación global sea suficiente para guiar el aprendizaje. Los profesionales no siempre identifican con precisión sus déficits y suelen necesitar datos externos, tareas específicas y comparación con estándares (Eva & Regehr, 2005). La metacognición madura no es introspección solitaria. Es un sistema que combina percepción interna, evidencia de desempeño y retroalimentación social.

Caja de herramientas. Medir la metacognición: del porcentaje al meta-d'

La investigación contemporánea no se conforma con preguntar "qué tan seguro estás". Distingue y mide por separado tres cosas: el sesgo metacognitivo (la tendencia global a declarar confianzas altas o bajas), la calibración (si el 80% declarado corresponde a un 80% de aciertos reales) y la sensibilidad metacognitiva (si la confianza sube cuando aciertas y baja cuando te equivocas, independiente de su nivel absoluto). Para esta última existe un estándar: el meta-d', que expresa cuánta de la información disponible para decidir aprovecha el observador al evaluar su propia decisión; dividido por la sensibilidad de la tarea (el llamado M-ratio), permite comparar personas y dominios (Maniscalco & Lau, 2012; Fleming & Lau, 2014). Dos hallazgos de esta literatura importan a la clínica: la sensibilidad metacognitiva varía sustancialmente entre individuos de igual desempeño, y tiene un componente parcialmente general junto a

componentes específicos de dominio (Rouault et al., 2018) — ser buen juez de las propias respuestas en un ámbito no garantiza serlo en otro. La letra chica también importa: estas medidas exigen decenas de juicios comparables con desenlace conocido, exactamente lo que la práctica clínica no devuelve por sí sola. Esa es la justificación técnica del portafolio del Taller 5: no calcula un meta-d' formal, pero construye la serie sin la cual ninguna medición —ni siquiera la intuitiva— es posible.

La sensación de corrección

Muchos juicios llegan acompañados por una sensación de corrección. La respuesta aparece fluida, familiar y coherente. Esa experiencia puede reflejar pericia genuina: un patrón altamente entrenado se reconoce con rapidez. Pero también puede surgir por disponibilidad reciente, repetición o narrativa atractiva. Koriat mostró que los juicios metacognitivos se apoyan en claves que suelen ser útiles, aunque no infalibles (Koriat, 1997).

Mi cólico renal de aquella noche tenía todas las claves de la fluidez: el patrón era típico, yo lo había visto muchas veces, el relato era coherente. Ninguna de esas claves medía lo único que importaba: la probabilidad de que otra enfermedad estuviera imitando el patrón. La pregunta productiva no es "¿debo confiar en mi intuición?", sino "¿qué condiciones hacen confiable esta intuición?". La validez aumenta cuando el ambiente posee regularidades estables, existe experiencia extensa y hubo retroalimentación oportuna. Disminuye en dominios raros, cambiantes, con feedback demorado o señales engañosas.

Señales de conflicto

La metacognición clínica necesita sensibilidad a señales de conflicto. Algunas son cognitivas: un dato no encaja, dos hallazgos exigen mecanismos incompatibles, el diagnóstico depende de una sola pieza. Otras son afectivas: incomodidad, sorpresa, irritación con el paciente, deseo de terminar, excesiva tranquilidad ante un caso complejo. Las emociones no son ruido del trabajo clínico: son parte de su materia. Tajer ha mostrado cómo atraviesan incluso la fisiopatología de aquello que tratamos —del ánimo al infarto—, y con mayor razón atraviesan a quien trata (Tajer, 2008). Epstein llamó práctica atenta a la capacidad de observar no sólo al paciente, sino las propias categorías, emociones y errores potenciales (Epstein, 1999).

Estas señales no son pruebas de error. Son indicaciones para revisar. El clínico puede formular disparadores explícitos: discordancia entre gravedad y diagnóstico; reconsulta; evolución inesperada; falta de respuesta; diagnóstico que explica sólo una parte; presión de tiempo; transferencia entre equipos; caso que genera una confianza desproporcionadamente rápida.

Control metacognitivo

Monitorear sin regular produce conciencia estéril. El control puede consistir en releer datos, reformular el problema, buscar una alternativa, pedir una segunda opinión, posponer una decisión reversible, intensificar vigilancia o actuar pese a

la duda cuando el costo de esperar es alto. La estrategia debe corresponder a la fuente de incertidumbre.

La metacognición clínica no es pensar indefinidamente sobre cada pensamiento; es detectar cuándo el modo actual de pensar dejó de ser suficiente.

La inteligencia médica incluye una habilidad menos visible que acertar: reconocer el grado de fragilidad del propio acierto. Esa fragilidad debe influir en cómo se escribe, cómo se decide y cómo se diseña el seguimiento.

Taller 5. Un experimento de calibración personal

Durante dos semanas, anote para cada diagnóstico de trabajo relevante: (a) su hipótesis principal, (b) su confianza en porcentaje aproximado (60, 70, 80, 90, 95), (c) la alternativa que más le preocupa. Cuando el caso se resuelva —o al revisar la evolución a los días—, registre el desenlace. Al final, agrupe: de los diagnósticos en que declaró 90% de confianza, ¿qué proporción se confirmó?

Solución comentada. No hay respuesta correcta: el ejercicio produce el dato que la práctica cotidiana casi nunca devuelve. Los patrones típicos que emergen: confianza declarada de 90% con tasa real de confirmación de 70–75% (sobreconfianza moderada, la más frecuente); dominios específicos sistemáticamente peor calibrados (los propios "cólicos renales" de cada uno); y alternativas anotadas que nunca se buscaron activamente. El objetivo no es castigarse: es descubrir en qué franja de confianza las propias palabras ("probable", "seguro") dejan de corresponder a la realidad. Quien repite el ejercicio dos o tres veces al año construye la serie que convierte experiencia en calibración.

En una frase. Sentirse seguro y estar en lo cierto son variables distintas; la metacognición útil consiste en medir su correlación y actuar sobre la brecha.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. En mi diagnóstico más firme de hoy, ¿mi confianza viene de la evidencia o de la fluidez con que reconocí el patrón?
2. ¿Qué señal afectiva (prisa, irritación, alivio) está influyendo en mi evaluación de este caso?
3. ¿Cuándo fue la última vez que supe el desenlace de un paciente que di de alta con diagnóstico incierto?

Capítulo 6

Pericia, intuición y conocimiento tácito

La cirujana que evaluó a Carmen tardó menos de un minuto en decir "esta hernia hay que operarla electivamente, pero no hoy". Un interno que la acompañaba anotó la conclusión; lo que no pudo anotar fue el proceso, porque la cirujana misma no habría podido enumerarlo completo: algo en la consistencia del abdomen, en la curva del lactato, en haber operado doscientas hernias parecidas. Este capítulo trata de ese conocimiento que funciona antes de poder explicarse.

La velocidad del experto

La pericia suele manifestarse como velocidad. Un médico experimentado reconoce una insuficiencia cardiaca, una obstrucción intestinal o un síndrome meníngeo antes de formular conscientemente todos los pasos. Esto no implica ausencia de razonamiento. Implica que años de exposición han organizado el conocimiento de modo que ciertos patrones activan representaciones compactas.

Schmidt y Rikers describieron un desarrollo desde conocimiento biomédico elaborado hacia encapsulación y formación de illness scripts (Schmidt & Rikers, 2007). El experto no olvida la fisiología; la comprime en conceptos clínicos que pueden desplegarse cuando aparece una anomalía. La experiencia permite saltar niveles, pero el salto sigue apoyado en estructuras aprendidas.

La práctica deliberada contribuye a la adquisición de desempeño experto cuando incluye tareas desafiantes, objetivos claros y feedback específico (Ericsson et al., 1993). En medicina, sin embargo, la mera acumulación de años no garantiza calibración. La experiencia puede consolidar atajos útiles o hábitos erróneos si el entorno no devuelve información confiable.

Conocimiento tácito

Polanyi sostuvo que "sabemos más de lo que podemos decir". El examen clínico ofrece ejemplos: reconocer que un paciente "se ve tóxico", percibir una respiración preocupante o notar que una historia no tiene la textura habitual. Parte de esta capacidad puede explicitarse; otra permanece integrada en percepción y acción (Polanyi, 1966).

El carácter tácito no exime de evaluación. Una impresión global puede iniciar vigilancia o generar hipótesis, pero debe buscar anclajes observables. "Mal aspecto general" gana valor cuando se acompaña de perfusión, interacción, patrón respiratorio, tono, postura o cambio respecto del basal. La tarea no es expulsar lo tácito, sino conectarlo con evidencia comunicable.

Dos procesos, no dos médicos

Las teorías de doble proceso distinguen un modo rápido, asociativo y automático de otro más lento, analítico y controlado. En clínica han sido útiles para explicar reconocimiento de patrones y revisión deliberada (Croskerry, 2009; Norman, 2009). No deben interpretarse como dos sistemas anatómicos aislados ni como

una oposición moral entre intuición mala y análisis bueno. Los procesos interactúan y ambos pueden acertar o errar (Evans & Stanovich, 2013).

El análisis depende del conocimiento disponible. Un médico puede pensar lentamente y equivocarse por déficit conceptual. La intuición experta puede superar una lista analítica en un patrón familiar. Norman y colaboradores han insistido en que los errores atribuidos a sesgo frecuentemente incluyen conocimiento insuficiente y que enseñar sólo a "pensar despacio" no reemplaza la construcción de representaciones robustas (Norman et al., 2017).

Phronesis

Aristóteles distinguió el conocimiento teórico de la prudencia práctica, o phronesis: la capacidad de deliberar bien acerca de lo que conviene hacer en situaciones particulares. La clínica comparte esta estructura. La regla general necesita ser aplicada a un caso con bienes en tensión, información incompleta y consecuencias asimétricas (Aristotle, 2009).

Gadamer y Montgomery recuperaron esta idea para la medicina: el juicio no es una desviación de la ciencia, sino el modo en que la ciencia se vuelve acción en una persona concreta (Gadamer, 1996; Montgomery, 2006). La pericia madura integra conocimiento causal, reconocimiento, probabilidad, valores y temporalidad.

El peligro de la fluidez

La misma fluidez que hace eficaz al experto puede ocultar supuestos. El patrón familiar reduce carga cognitiva, pero favorece asimilación: lo nuevo se fuerza a encajar en lo conocido. El experto necesita mecanismos para detectar excepciones. Una representación discrepante, una evolución atípica o una consecuencia desproporcionada deben reabrir el caso.

La enseñanza de la pericia no puede consistir sólo en transmitir conclusiones. Debe hacer visible qué características fueron decisivas, qué alternativas fueron descartadas, qué incertidumbres permanecieron y qué señal habría obligado a cambiar. Cuando el interno le preguntó a la cirujana cómo lo supo tan rápido, ella hizo el ejercicio: la gravedad fisiológica sin correlato anatómico en la imagen, la recurrencia acelerándose, el abdomen que "avisa pero todavía no exige". El razonamiento del experto necesita ser desempaquetado para que el aprendiz no copie únicamente su seguridad.

La intuición clínica es conocimiento comprimido; la metacognición decide cuándo esa compresión debe volver a desplegarse.

La excelencia no pertenece al médico que siempre analiza todo ni al que siempre "ve" el diagnóstico. Pertenece a quien cambia de modo de pensamiento según la estructura del caso y puede justificar ese cambio.

En una frase. La intuición experta es conocimiento organizado que se ejecuta rápido; su valor depende del entorno que la entrenó y de la disposición a desplegarla cuando el caso no encaja.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿En qué dominio tengo suficiente experiencia con feedback real como para confiar en mi primera impresión?
2. La última vez que "vi" un diagnóstico al instante, ¿qué características lo activaron? ¿Puedo nombrarlas?
3. ¿Qué caso reciente forcé a encajar en un patrón conocido cuando algo no calzaba?

Capítulo 7**Error, sesgo y ecología del diagnóstico**

Voy a contar un error mío. Una paciente mayor, traída por su hija, con decaimiento y orina turbia. La nota de urgencias decía "ITU a repetición"; el urocultivo del ingreso salió positivo. Indiqué el antibiótico, anoté "ITU, evolución favorable esperable" y pasé al siguiente ingreso. Al tercer día, la paciente seguía decaída; al cuarto hizo fiebre y el abdomen se defendió: colecistitis aguda, ya complicada. Durante años conté esta historia como "me anclé". Hoy creo que esa etiqueta, aunque correcta, era otra forma de cierre prematuro: nombrar el sesgo me eximía de reconstruir cómo se produjo el error —una nota heredada con autoridad de hecho, un cultivo que confirmaba lo que yo ya creía, una sala llena, un abdomen que examiné mal porque no esperaba encontrar nada. Este capítulo trata de esa reconstrucción.

El atractivo de nombrar el sesgo

La literatura sobre heurísticas y sesgos transformó nuestra comprensión del juicio. Tversky y Kahneman mostraron que estimamos probabilidades mediante reglas rápidas que producen errores sistemáticos en determinadas condiciones (Tversky & Kahneman, 1974; Kahneman, 2011). En medicina, Croskerry y otros autores difundieron conceptos como anclaje, disponibilidad, confirmación, cierre prematuro y búsqueda satisfecha (Croskerry, 2003).

El vocabulario es útil porque permite reconocer patrones. Pero también puede producir una explicación retrospectiva demasiado fácil. Después de un error, casi siempre es posible encontrar un sesgo que parezca describirlo. Etiquetar "anclaje" no demuestra el mecanismo ni explica por qué el anclaje ocurrió en ese momento, con ese equipo y bajo esas condiciones.

Error como trayectoria

Los estudios de errores diagnósticos muestran combinaciones de fallas en historia, examen, interpretación, seguimiento y comunicación (Graber et al., 2005; Schiff et al., 2009). La National Academies definió el diagnóstico como un proceso iterativo y de equipo, no como un acto mental instantáneo (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015). El error debe reconstruirse como trayectoria: qué información existía, quién la recibió, cómo fue representada, qué decisiones se tomaron, qué feedback faltó y cuándo habría sido posible corregir.

Mi error con la colecistitis, reconstruido como trayectoria, tiene por lo menos cinco estaciones: una frase heredada ("ITU a repetición") que llegó con estatus de antecedente; un dato confirmatorio (urocultivo) que en una paciente mayor con sondajes previos confirmaba mucho menos de lo que yo le atribuí; un examen abdominal hecho para no encontrar; dos días de evolución "atípica" que reinterpreté para que encajara ("las viejitas responden lento"); y la ausencia de cualquier disparador externo —una pausa, una pregunta de otro, un criterio de reevaluación escrito— que me obligara a mirar de nuevo. El "anclaje" está ahí,

pero el error es la trayectoria completa. La responsabilidad cognitiva individual no desaparece; se vuelve contextual.

El cierre prematuro, en general, puede surgir de una hipótesis inicial convincente, pero también de sobrecarga, interrupciones, fragmentación del registro, jerarquía, ausencia de acceso a exámenes previos o presión de camas.

Sesgo, conocimiento y señal

Norman y colaboradores advirtieron que muchos errores no son fallas puras de proceso, sino déficits de conocimiento. No reconocer una enfermedad rara puede parecer disponibilidad, pero quizá el clínico nunca desarrolló un script adecuado. Un análisis excesivamente psicologizado puede recomendar una pausa cuando lo necesario es enseñar fisiopatología o ampliar experiencia (Norman et al., 2017).

Las heurísticas tampoco son enemigas de la racionalidad. Gigerenzer ha mostrado que reglas simples pueden ser adaptativas cuando corresponden a la estructura del ambiente (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). El problema no es usar atajos, sino usarlos fuera de su ecología de validez. "Lo frecuente es frecuente" funciona como prior, no como veto a la evidencia discordante.

Sobreconfianza

La sobreconfianza ha sido vinculada al error diagnóstico, especialmente cuando impide buscar evidencia o revisar una conclusión (Berner & Graber, 2008). Sin embargo, medirla no es trivial. La confianza puede ser apropiada en casos fáciles y excesiva en casos difíciles. Meyer y colaboradores observaron que la relación entre confianza y exactitud es imperfecta, lo que refuerza la necesidad de calibración y feedback (Meyer et al., 2013).

Una cultura que castiga toda expresión de duda puede aumentar la sobreconfianza performativa. El médico aprende a hablar con certeza aunque piense probabilísticamente. Por el contrario, una cultura que equipara autoridad con infalibilidad dificulta la corrección temprana. La seguridad clínica requiere autoridad revisable.

Debiasing con prudencia

Las estrategias de debiasing incluyen considerar alternativas, usar reglas de forzamiento, listas de verificación, pausas diagnósticas y reflexión estructurada. Sus fundamentos teóricos y sus obstáculos prácticos han sido descritos en detalle (Croskerry et al., 2013a, 2013b), pero la evidencia de eficacia es heterogénea y los efectos dependen del contexto (Graber et al., 2012; Lambe et al., 2016). Una lista aplicada a todos los casos puede generar fatiga y ruido. La intervención más prometedora suele ser selectiva: identificar situaciones de alto riesgo cognitivo y activar una respuesta específica.

En lugar de preguntar siempre "¿qué sesgo tengo?", puede ser más útil preguntar:

- ¿qué dato sostiene desproporcionadamente mi conclusión?;

- ¿qué hallazgo estoy reinterpretando para que encaje?;
- ¿qué alternativa cambiaría la conducta?;
- ¿qué elemento del sistema impide recibir feedback?;
- ¿qué supuse que otro miembro del equipo había verificado?

El sesgo es una posibilidad explicativa; el análisis serio del error exige reconstruir la interacción entre mente, conocimiento, tarea y sistema.

La metacognición no debe convertirse en vigilancia moral del pensamiento. Debe ser una ingeniería humilde de condiciones que permitan detectar, corregir y aprender antes de que la coherencia narrativa se vuelva irreversible.

Taller 7. Reconstruir una trayectoria, no asignar un sesgo

Tome el error de la colecistitis narrado al inicio del capítulo (o, mejor, un error propio que recuerde con suficiente detalle). Prohibido usar nombres de sesgos. Responda: (1) ¿qué información existía y en qué formato viajaba?, (2) ¿qué dato confirmatorio valía menos de lo que se le atribuyó, y por qué?, (3) ¿en qué momento exacto una señal discordante fue reinterpretada para encajar?, (4) ¿qué barrera —humana, escrita o tecnológica— habría interceptado el error, y cuánto habría costado tenerla?

Solución comentada. Sobre el caso del capítulo: (1) "ITU a repetición" viajaba como antecedente sin procedencia —el formato (frase heredada en ficha) le daba más autoridad que su origen (nadie sabía quién la escribió ni con qué base). (2) El urocultivo: en una mujer mayor con sondajes previos, la bacteriuria tiene alta prevalencia basal; confirma poco cuando la probabilidad pretest de otra causa es sustancial. (3) El día 3: "sigue decaída" se convirtió en "responde lento", una reinterpretación que inmunizaba la hipótesis. (4) Dos barreras baratas: un criterio de reevaluación escrito al indicar el antibiótico ("si no mejora en 48 h, reexaminar abdomen y ampliar estudio") y una pausa de pase de visita con la pregunta "¿qué no explica la ITU?" —el decaimiento desproporcionado no lo explicaba. El ejercicio termina cuando puede formular la barrera, no cuando encuentra al culpable.

En una frase. Nombrar el sesgo es el comienzo del análisis, no su conclusión: el error real es una trayectoria que atraviesa mente, conocimiento, tarea y sistema.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Qué frase heredada estoy tratando como hecho en mi paciente más complejo?
2. ¿Qué dato "confirmatorio" de hoy confirmaría también la hipótesis rival?
3. ¿Qué evolución atípica estoy reinterpretando para no reabrir el caso?

Capítulo 8

Reflexión y desaceleración selectiva

En el pase de las 8:00, el caso de la sala 12 se presenta en cuarenta segundos: "pielonefritis en tratamiento, afebril, buena respuesta". La jefa de sala mira dos segundos la hoja y dice: "Preséntenmelo de nuevo, pero sin usar la palabra pielonefritis". El residente empieza: "Paciente sondado, afebril, hemodinámicamente estable, con orina turbia, piuria y urocultivo positivo, sin síntomas urinarios evaluables por lesión medular, con marcadores inflamatorios elevados y una neoplasia activa como explicación alternativa...". A la tercera frase, ya nadie en la sala está seguro del diagnóstico. Ese es exactamente el punto.

Reflexionar no es rumiar

Schön describió al profesional reflexivo como alguien capaz de pensar durante y después de la acción, especialmente cuando la situación resiste las categorías habituales (Schön, 1983). En medicina, reflexión no significa prolongar indefinidamente cada decisión. Significa volver deliberadamente sobre la representación del problema, examinar supuestos y reorganizar la evidencia cuando existe una razón para hacerlo.

La práctica atenta de Epstein añade una dimensión: curiosidad, presencia y capacidad de reconocer las propias respuestas emocionales y categorías (Epstein, 1999). La reflexión clínica eficaz es concreta. Tiene un objeto, un disparador y una consecuencia posible.

Cuándo desacelerar

Moulton y colaboradores propusieron "desacelerar cuando se debe" como característica del juicio experto. Los profesionales alternan entre flujo automático y esfuerzo deliberado cuando detectan señales de dificultad, novedad o peligro (Moulton et al., 2007). La dificultad es que el momento de desacelerar también debe ser reconocido; si la metacognición falla, el clínico continúa con fluidez precisamente cuando debería detenerse.

Disparadores razonables incluyen: evolución inesperada; reconsulta; falta de respuesta; discrepancia entre el diagnóstico y la gravedad; datos incompatibles; transición de cuidados; presión emocional; caso raro en un dominio poco familiar; y decisión irreversible con evidencia débil. La desaceleración debe ser proporcional. Puede durar treinta segundos o requerir una discusión formal.

Reflexión estructurada

Mamede y colaboradores estudiaron la reflexión deliberada y encontraron que, en ciertos problemas complejos, comparar hipótesis mediante evidencia a favor y en contra puede mejorar la precisión diagnóstica (Mamede et al., 2008). El mismo grupo mostró después algo más específico: la exposición reciente a ciertos diagnósticos induce sesgo de disponibilidad en residentes, y la reflexión

estructurada revierte ese efecto (Mamede et al., 2010) — la mejor evidencia disponible de que la pausa correcta no es un ritual, sino un antídoto con indicación precisa. Otros trabajos y revisiones muestran resultados variables, lo que impide convertir la reflexión en una receta universal (Graber et al., 2012; Lambe et al., 2016).

Una estructura breve puede ser:

1. Reformular el caso sin usar el diagnóstico actual.
2. Nombrar dos o tres hipótesis que expliquen los hallazgos decisivos.
3. Identificar evidencia a favor y en contra de cada una.
4. Buscar el dato que más podría cambiar la conducta.
5. Definir qué desenlace obligaría a reabrir el caso.

La primera instrucción es especialmente poderosa, como muestra la escena que abre este capítulo. Al quitar la etiqueta, reaparecen datos que habían sido subordinados a ella. La nueva representación no resuelve, pero impide que el nombre decida por adelantado.

Pausa diagnóstica y segundo lector

Una pausa diagnóstica puede incorporarse a rondas, altas y transferencias. No necesita preguntar por todas las enfermedades posibles. Debe focalizarse en riesgos: ¿qué podría estar pasando que no estamos tratando?, ¿qué supuesto no verificamos?, ¿qué explicación alternativa cambia el destino o el tiempo de intervención?

El segundo lector —otro médico, un especialista, un equipo interdisciplinario o una herramienta de apoyo— aporta diversidad de representación. Su valor no reside sólo en saber más, sino en no estar comprometido con la narrativa inicial. Para que funcione, el caso debe presentarse con datos suficientes y no sólo con la conclusión del primer equipo.

Reflexión después del desenlace

La revisión retrospectiva corre riesgo de hindsight bias: una vez conocido el desenlace, parece que las señales eran evidentes. El análisis debe reconstruir qué era razonable con la información disponible en cada momento. Una decisión puede haber sido racional y terminar mal; otra puede haber sido irracional y terminar bien. Aprender exige separar calidad del proceso y suerte del resultado.

Los portafolios de calibración, conferencias de morbilidad y seguimiento de diagnósticos pendientes pueden transformar la experiencia en aprendizaje. Sin feedback, la repetición no es práctica deliberada. Mann, Gordon y MacLeod encontraron que la reflexión en educación sanitaria es valorada, pero su enseñanza requiere estructura, contexto y apoyo (Mann et al., 2009).

Desacelerar no es pensar más por principio; es cambiar de régimen cognitivo cuando el riesgo, la discordancia o la novedad lo justifican.

La pausa correcta no paraliza la medicina. Le devuelve capacidad de revisión antes de que la decisión se vuelva daño, inercia o certeza documental.

Taller 8. Presentar sin la etiqueta

Elija el paciente de su lista actual cuyo diagnóstico lleva más días sin discutirse. Preséntelo por escrito en cinco líneas sin usar el diagnóstico de trabajo ni sus sinónimos. Luego responda: ¿qué dato reapareció que la etiqueta tenía subordinado?, ¿qué hipótesis alternativa se volvió formulable?, ¿la conducta actual sigue siendo la mejor para la nueva descripción?

Solución comentada. El ejercicio funciona por sustracción: la etiqueta organiza la percepción, y quitarla obliga a re-observar. En el caso de la sala 12, la reformulación hizo visible que (a) los "síntomas urinarios" eran inevaluables —dato clave que la palabra "pielonefritis" ocultaba—, (b) los marcadores inflamatorios tenían una explicación alternativa activa (neoplasia), y (c) la "buena respuesta" era atribuible al menos a dos causas. Nada de eso exige cambiar el tratamiento hoy; exige saber qué se vigila y qué reabrirla el caso. Si al hacer el ejercicio con su propio paciente no reaparece ningún dato, enhorabuena: la etiqueta probablemente está bien puesta. El costo fueron cinco minutos; el beneficio, saberlo.

En una frase. La reflexión clínica eficaz es selectiva: se activa por disparadores definidos, tiene estructura breve y termina en una consecuencia concreta —confirmar, vigilar o reabrir.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál de mis pacientes actuales cumple un disparador de desaceleración (evolución inesperada, discordancia gravedad-diagnóstico, reconsulta)?
2. ¿Puedo presentar mi caso más complejo sin usar su etiqueta diagnóstica?
3. En mi última alta con diagnóstico incierto, ¿dejé escrito qué debería motivar reconsulta?

Interludio II

Lo que el equipo pensó

La historia clínica de Carmen registra qué se hizo. No registra —casi ninguna ficha lo hace— cómo se pensó. Reconstruyámoslo.

El residente de urgencias que escribió "cuadro habitual, manejo habitual" no fue negligente: reconoció un patrón real (tres episodios previos idénticos, resueltos igual) y su intuición ejecutó el script aprendido. Su error no fue intuir; fue no registrar la señal discordante que su propio examen había encontrado —las rodillas moteadas— y que no pertenecía al patrón. El dato quedó en la hoja de enfermería, huérfano de interpretación.

La internista de la mañana desaceleró, y vale la pena notar por qué: no porque "pensara despacio" en general, sino porque dos disparadores concretos se activaron —discordancia entre la gravedad fisiológica (shock, lactato 6) y la etiqueta ("suboclusión habitual"), y un dato incompatible con la serie previa (nunca había requerido vasoactivos)—. Su primera acción no fue pedir más exámenes: fue reformular el caso sin la etiqueta. "Mujer con obstrucción mecánica recurrente que hoy está en shock" abre un espacio de hipótesis que "cuadro habitual" cerraba.

La cirujana aportó la intuición entrenada: doscientas hernias la autorizaban a decir "electiva, no hoy" en un minuto. Pero el valor de su juicio para el equipo no estuvo en la conclusión sino en que aceptó desempaquetarla: gravedad sin correlato anatómico, recurrencia acelerándose, abdomen que "avisa". Esa explicitación permitió que la internista y el residente pudieran vigilar lo mismo que ella vigilaba —y discrepar, si la evolución lo justificaba.

Y está la confianza. En la reunión de la tarde, la internista hizo una pregunta que rara vez se hace en voz alta: "¿Qué tan seguros estamos de que la bacteriemia es de foco abdominal? ¿Ochenta por ciento? ¿Noventa y cinco?". El número exacto importaba menos que el efecto: al ponerle cifra, el equipo descubrió que su seguridad venía sobre todo de la coherencia narrativa —la historia se contaba bien— y no de haber excluido el foco urinario ni revisado el catéter. Diez minutos de trabajo redujeron una incertidumbre que la retórica había tapado.

Nada de esto aparece en la ficha como "metacognición". Aparece como una nota mejor escrita, dos exámenes dirigidos y un plan con criterios de reapertura. La metacognición clínica no es un género literario: es la diferencia entre una trayectoria que se corrige a tiempo y otra que necesita que el error se vuelva evidente para ser vista.

PARTE III

Decidir en el tiempo y con otros

Las dos primeras partes examinaron el conocimiento y la mente que lo maneja. Esta parte los pone en movimiento: la evidencia poblacional que debe traducirse a una persona y convertirse en decisión por umbrales (capítulo 9), el tiempo que transforma el significado de los hechos (capítulo 10), la ficha que piensa o que fosiliza (capítulo 11) y el equipo donde el conocimiento circula, se degrada o se corrige, incluida la conversación con el paciente (capítulo 12). El interludio final encuentra a Carmen frente a una decisión de verdad.

Capítulo 9

De la evidencia a la decisión: poblaciones, umbrales y consecuencias

El ensayo clínico dice: "la reparación electiva de hernia incisional reduce la recurrencia obstructiva en pacientes comparables". La paciente de la cama 12 tiene 61 años, una recuperación reciente de un shock séptico, un EPOC moderado y una pregunta simple: "¿Y si no me opero?". Entre el ensayo y la respuesta hay una cadena de inferencias que este capítulo intenta hacer visible.

La evidencia responde a una pregunta distinta

La medicina basada en evidencia corrigió una debilidad histórica: la tendencia a confundir experiencia, autoridad y tradición con conocimiento confiable. Los ensayos controlados, las revisiones sistemáticas y los estudios de exactitud diagnóstica permiten estimar efectos y reducir errores que la intuición aislada no detecta. Sin embargo, la evidencia de investigación responde habitualmente a una pregunta poblacional: qué ocurrió, en promedio y bajo ciertas condiciones, en un conjunto de personas definidas por criterios de inclusión, comparación y desenlace. El médico debe responder otra: qué significa esa estimación para esta persona, en este momento y frente a estas alternativas.

Sackett y colaboradores definieron la medicina basada en evidencia como la integración de la mejor evidencia disponible con la experiencia clínica y los valores del paciente (Sackett et al., 1996). La formulación original ya impedía convertir la evidencia en algoritmo autosuficiente. Con el tiempo, sin embargo, la jerarquía de diseños pudo confundirse con una jerarquía completa de decisiones, y varios autores han alertado sobre la reducción de la medicina basada en evidencia a reglas burocráticas y métricas desconectadas del cuidado (Greenhalgh et al., 2014; Djulbegovic & Guyatt, 2017). En español, Novoa ha propuesto para esta corrección el nombre de terapia epistémica: un juicio clínico centrado en la persona, apoyado en pluralismo evidencial y contextualización del conocimiento, contra la tentación de que los números decidan solos (Novoa Jurado, 2025). Un ensayo aleatorizado puede estimar con gran validez interna un efecto promedio y, aun así, no resolver si conviene tratar a una persona con diferente riesgo basal, comorbilidades, expectativas, horizonte temporal o vulnerabilidad a los efectos adversos.

Del efecto promedio al caso singular

La particularización exige varias operaciones inferenciales. Primero, establecer si el paciente se parece de manera relevante a la población estudiada. La semejanza no depende sólo de edad o diagnóstico: incluye severidad, fase de enfermedad, tratamientos concomitantes, capacidad funcional, adherencia posible y desenlaces que realmente importan. Segundo, estimar el riesgo basal. Una reducción relativa idéntica produce beneficios absolutos muy diferentes en pacientes con riesgos iniciales distintos. Tercero, considerar modificación del efecto, riesgos competitivos y tiempo necesario para obtener beneficio.

La validez externa no es una propiedad binaria del estudio. Es una relación entre una evidencia y un uso propuesto. Tonelli sostuvo que el conocimiento clínico incorpora fuentes heterogéneas y que la individualidad del paciente no puede derivarse por completo de resultados poblacionales (Tonelli, 1998). La crítica no invalida la evidencia; impide exigirle aquello para lo cual no fue diseñada. Cartwright y Hardie expresan una dificultad paralela: saber que una intervención funcionó en un contexto no garantiza que funcione aquí, porque el efecto depende de una red de condiciones de apoyo (Cartwright & Hardie, 2012).

En términos HII, un resultado de investigación es un hecho acerca de una población estudiada. Su aplicabilidad al caso es una inferencia. El grado de transportabilidad permanece incierto. La conducta surge al integrar esa incertidumbre con la magnitud del beneficio esperado, el daño posible, la reversibilidad y las preferencias. Confundir esas capas produce frases como "está indicado por evidencia" cuando lo demostrado es más limitado: "en pacientes comparables, esta estrategia redujo cierto desenlace; en esta paciente el beneficio absoluto probablemente sea menor y debe ponderarse frente a un riesgo adverso mayor".

La singularidad no autoriza la arbitrariedad

La defensa del juicio clínico puede convertirse en excusa para ignorar datos incómodos. Que cada paciente sea singular no significa que toda decisión sea incomparable ni que la experiencia personal tenga igual fuerza que un estudio robusto. La singularidad clínica es una tarea de integración, no una licencia para abandonar estándares. Debe explicitar qué rasgo del caso modifica la inferencia poblacional y por qué.

Una formulación responsable podría distinguir: evidencia de eficacia; evidencia de seguridad; semejanza del paciente con la población; factores que aumentan o disminuyen el efecto esperado; preferencias; y condiciones locales de implementación. Esta separación evita dos excesos simétricos: el positivismo ingenuo que cree que el estudio decide por sí solo y el particularismo romántico que presenta la intuición del médico como conocimiento inaccesible a examen.

La medicina clínica utiliza además evidencia que no siempre ocupa la parte superior de una pirámide: evolución temporal, respuesta previa, patrones fisiopatológicos, datos locales, factibilidad y experiencia técnica. Su menor jerarquía para estimar causalidad poblacional no la vuelve irrelevante para una decisión individual. La pregunta correcta es qué función epistémica cumple cada fuente y qué error puede corregir o introducir.

De la verdad a la acción: el enfoque de umbrales

El diagnóstico pregunta qué explicación es más plausible. La decisión pregunta qué conviene hacer. Ambas preguntas se relacionan, pero no son idénticas. Una enfermedad puede ser poco probable y aun así justificar una acción si el daño de omitirla es grave y la intervención es segura. Otra puede ser probable y no requerir tratamiento inmediato si la conducta tiene alto riesgo o el diagnóstico puede confirmarse antes.

Pauker y Kassirer formalizaron el enfoque de umbrales: bajo cierto nivel de probabilidad no se investiga o trata; en una zona intermedia se testea; sobre un umbral se actúa (Pauker & Kassirer, 1980). Los valores exactos rara vez se calculan al lado de la cama, pero la estructura es útil. El umbral depende de sensibilidad y especificidad de pruebas, beneficio y daño del tratamiento, urgencia, reversibilidad y preferencias.

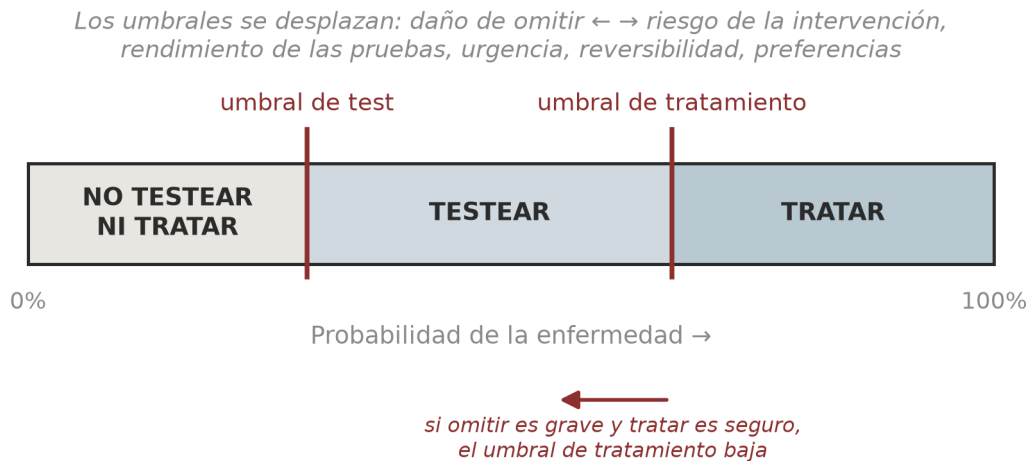


Figura 6. El enfoque de umbrales de Pauker y Kassirer: la probabilidad de enfermedad se divide en tres zonas de conducta. Los umbrales no son fijos: se desplazan según el daño de omitir, el riesgo de la intervención y el rendimiento de las pruebas disponibles.

Errores asimétricos

Falso positivo y falso negativo no tienen el mismo costo en todos los casos. En una condición letal y tratable, toleramos más falsos positivos para reducir omisiones. En un tratamiento tóxico o irreversible, exigimos mayor evidencia. La incertidumbre diagnóstica debe traducirse en una matriz de consecuencias.

Considere la obstrucción recurrente de Carmen. La ausencia de isquemia en la imagen reduce la indicación de cirugía de emergencia, pero un episodio actual con shock y bacteriemia puede modificar el balance de una reparación electiva. La decisión no depende sólo de si hubo estrangulación demostrada; depende de la gravedad alcanzada, recurrencia, aptitud fisiológica futura y mortalidad potencial de un nuevo episodio.

El umbral es un juicio de valor: el riesgo inductivo

La estructura de umbrales tiene una fundamentación filosófica precisa que rara vez se nombra en medicina. Richard Rudner argumentó en 1953 que ningún científico acepta o rechaza una hipótesis por lógica pura: como la evidencia nunca es concluyente, decidir que *ya es suficiente* exige ponderar qué tan grave sería equivocarse, y esa ponderación es un juicio de valor (Rudner, 1953). Heather

Douglas llamó a esto riesgo inductivo y mostró que atraviesa toda la ciencia con consecuencias prácticas: cuánta evidencia exigimos antes de afirmar que un compuesto es tóxico depende de qué error —afirmar de más o afirmar de menos— produce más daño (Douglas, 2000).

La clínica es el caso extremo y más honesto de esta tesis. El umbral de Pauker y Kassirer es exactamente el riesgo inductivo vuelto aritmética: el punto donde "suficiente evidencia" queda definido por el costo de los dos errores posibles. Por eso "se descarta" nunca es una afirmación puramente epistémica: descartar una embolia con dímero negativo en un paciente de baja probabilidad no significa que la probabilidad sea cero, sino que el residuo de duda ya no justifica el daño esperado de seguir estudiando. Quien entiende esto deja de buscar un umbral "objetivo" escondido en las guías y empieza a hacer la pregunta correcta: ¿qué error estamos más dispuestos a tolerar en este paciente, y quién decidió eso?

Esta fundamentación tiene una consecuencia liberadora. Reconocer que hay valores dentro del umbral no corrompe la objetividad clínica; la localiza. Los hechos y las probabilidades se estiman con toda la disciplina de la Parte I; el punto de corte se delibera —con el paciente cuando es posible— y se declara. Lo indefendible no es que haya valores en la decisión: es esconderlos detrás de una retórica de pura evidencia.

Tiempo y reversibilidad

La misma probabilidad conduce a decisiones distintas según el tiempo. Cuando el daño progresa rápidamente, el valor de esperar información disminuye. Cuando la conducta es reversible, puede iniciarse con un umbral menor y reevaluarse. Cuando es irreversible, la deliberación debe ser más exigente.

Una forma práctica de pensar incluye cinco dimensiones: probabilidad, magnitud del daño, velocidad de evolución, reversibilidad de la intervención y capacidad de vigilancia. La observación activa no es "no hacer nada" si incluye objetivos, plazos y criterios de escalamiento. Del mismo modo, iniciar tratamiento empírico no significa declarar certeza etiológica.

Decisiones correctas con desenlaces adversos

Evaluar una decisión sólo por su resultado produce sesgo. Un médico puede actuar racionalmente con la información disponible y enfrentar un desenlace improbable. También puede tomar una decisión débil y obtener buen resultado por evolución favorable. La calidad debe juzgarse por proceso: representación, alternativas, estimación de consecuencias, comunicación, seguimiento y revisabilidad.

Esto tiene implicancias éticas. Reconocer incertidumbre no disminuye responsabilidad; la hace más precisa. El médico es responsable de buscar la información razonablemente accesible, interpretar con competencia, comunicar límites y establecer una estrategia de reevaluación. No es responsable de volver determinista un mundo que no lo es.

Certeza epistémica y compromiso práctico

Puede existir alta incertidumbre epistémica y fuerte compromiso práctico. "No conocemos el foco con certeza, pero el cuadro exige antibióticos y control de fuente mientras se investiga." También puede existir alta certeza diagnóstica y decisión expectante. Confundir ambos planos lleva a tratar para demostrar convicción o a retrasar una acción porque el nombre no está completo.

La decisión clínica no exige convertir una probabilidad en certeza; exige justificar por qué, bajo esa probabilidad y esas consecuencias, actuar supera a no actuar.

Evidencia local y aprendizaje del caso

La evidencia externa convive con conocimiento local: epidemiología, disponibilidad diagnóstica, tiempos de traslado, perfiles de resistencia, experiencia técnica y capacidad de seguimiento. Estos datos pueden modificar la decisión sin contradecir un estudio. Su legitimidad depende de que sean explícitos y actualizables, no simples tradiciones institucionales.

El paciente también genera evidencia longitudinal sobre sí mismo. Respuestas previas, recurrencias, efectos adversos y preferencias estables constituyen información relevante, aunque no equivalgan a un ensayo N-of-1 formal. El desafío es evitar atribuciones causales fáciles: la mejoría posterior a una intervención no demuestra que haya sido causada por ella, especialmente cuando coexisten historia natural y tratamientos simultáneos.

Una deliberación bien formulada puede declarar: qué proviene de estudios; qué se extrapola; qué aporta la historia individual; qué depende del contexto local; y qué permanece desconocido. Esa estratificación protege tanto contra la obediencia automática a la evidencia como contra su rechazo anecdótico. La competencia metacognitiva consiste en reconocer cuándo se está citando un resultado, cuándo se está extrapolando, cuándo se está suponiendo un mecanismo y cuándo una preferencia está inclinando la balanza. La pregunta final no es "¿existe evidencia?", sino "¿qué evidencia existe, para qué afirmación, con qué transportabilidad y con qué consecuencias para esta persona?".

Taller 9. Frecuencias naturales al lado de la cama

Suponga una condición con probabilidad pretest de 10%, y una prueba con sensibilidad 90% y especificidad 80%. El resultado llega positivo. Antes de calcular: ¿qué probabilidad le habría asignado intuitivamente al diagnóstico? Ahora calcule con frecuencias naturales sobre 1.000 pacientes.

Solución comentada. De 1.000 pacientes, 100 tienen la condición; de ellos, 90 dan positivo. De los 900 sin la condición, 180 dan positivo (20% de falsos positivos). Total de positivos: 270. Probabilidad postest = $90/270 = 33\%$. La mayoría de los clínicos estima intuitivamente 70-90%, porque la sensibilidad y la especificidad "suenan" altas: el error clásico de ignorar la probabilidad previa (Hoffrage & Gigerenzer, 1998). La lección de umbral: con 33%, el caso probablemente queda

en la zona de "seguir testeando", no en la de tratar —salvo que el daño de omitir sea catastrófico y el tratamiento, benigno. Repetir este cálculo con las probabilidades del propio hospital (¿qué proporción de los "urocultivos positivos" de su servicio son infección?) suele ser más correctivo que cualquier lectura teórica.

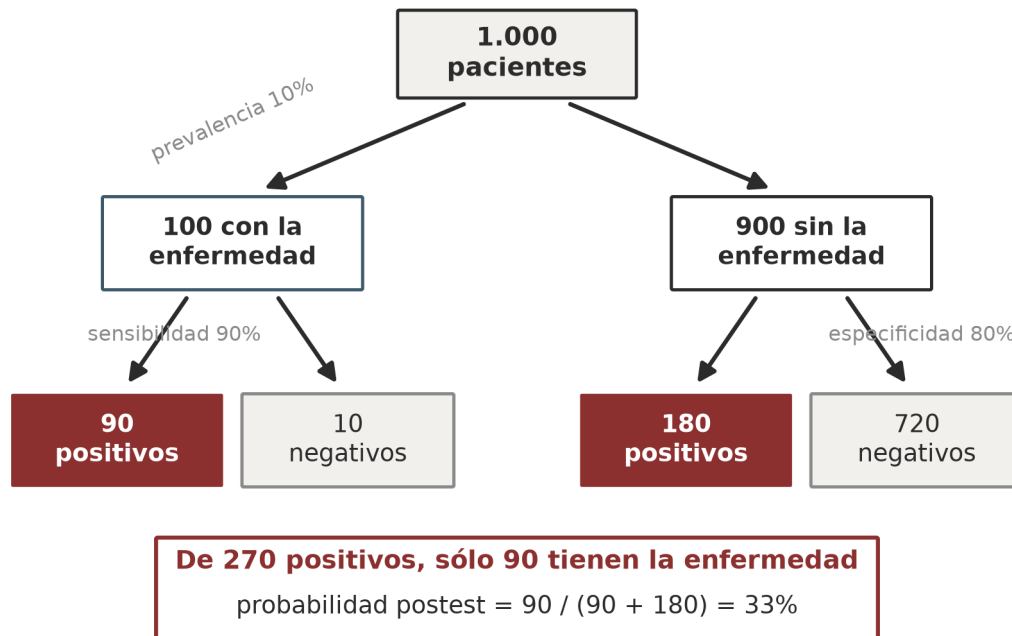


Figura 7. El cálculo del Taller 9 en frecuencias naturales: de 270 resultados positivos, sólo 90 corresponden a la enfermedad. La probabilidad posttest (33%) queda lejos de la certeza que la intuición atribuye a una "prueba positiva".

En una frase. La evidencia no desciende intacta desde la población hacia el individuo: debe traducirse mediante inferencias explícitas, y la decisión final se toma por umbrales y consecuencias, no por certeza.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. Para mi indicación más importante de hoy: ¿qué demostró exactamente el estudio que la respalda, y en qué se parece mi paciente a esa población?
2. ¿Cuál es el umbral implícito de mi decisión: qué probabilidad de estar equivocado la haría cambiar?
3. ¿Estoy exigiendo certeza diagnóstica donde bastaría compromiso práctico, o actuando para no tolerar una duda?

Capítulo 10**Temporalidad, trayectoria y razonamiento contrafactual**

"Está mejor." La frase se dice en cada pase de visita y casi nunca se pregunta: ¿mejor que cuándo?, ¿mejor en qué variable?, ¿mejor a qué velocidad? Un lactato de 3 puede ser una buena noticia (venía de 6) o una pésima (venía de 1,5). Este capítulo trata del tiempo: la dimensión donde los hechos clínicos cambian de significado sin cambiar de valor.

El caso clínico es una trayectoria

La ficha suele presentar al paciente como una serie de fotografías: signos vitales, laboratorio, imagen, examen físico. La enfermedad, sin embargo, existe en el tiempo. El orden de los acontecimientos, su velocidad, recurrencia y respuesta a intervenciones puede ser más informativo que cualquier valor aislado. Un mismo lactato tiene significado distinto si asciende pese a reanimación, desciende en paralelo a la perfusión o aparece después de una crisis convulsiva. La temporalidad no acompaña al dato; forma parte de él.

Pensar en trayectorias obliga a preguntar por el punto de comparación. "Mejor" carece de sentido sin un estado previo y un intervalo. "Recurrente" requiere definir episodios y recuperaciones. "Fracaso terapéutico" exige un objetivo, una dosis, un tiempo suficiente y un desenlace observado. La precisión temporal protege contra diagnósticos retrospectivos contruidos con información que no estaba disponible al decidir.

El tiempo como fuente de evidencia

La evolución puede funcionar como prueba diagnóstica. La aparición de un signo esperado, la ausencia persistente de una complicación o la respuesta a una intervención modifican probabilidades. Pero la prueba temporal rara vez es específica. Mejorar con antibióticos no demuestra por sí solo una etiología bacteriana; también pudieron actuar el soporte, el drenaje, la historia natural o tratamientos simultáneos. La respuesta terapéutica es un hecho; atribuirle un mecanismo es una inferencia.

El tiempo también selecciona qué incertidumbres pueden tolerarse. En un paciente estable, observar puede producir información con bajo costo. En una amenaza tiempo-dependiente, esperar puede destruir la oportunidad terapéutica. "Esperar y observar" no es ausencia de conducta: es una intervención diagnóstica con condiciones de seguridad, variables de vigilancia y criterios de salida. Debe formularse qué se espera aprender, durante cuánto tiempo y qué cambio obligará a actuar.

La temporalidad modifica además la probabilidad previa. Una enfermedad puede ser plausible al inicio y mucho menos plausible tras una evolución discordante. El anclaje aparece cuando la hipótesis inicial conserva autoridad aun después de perder capacidad explicativa. Una revisión temporal útil pregunta: ¿qué hechos

nuevos surgieron desde la formulación anterior?, ¿qué predijo correctamente?, ¿qué no explicó?, ¿la conducta sigue siendo razonable con la información actual?

Causalidad y contrafactuales

Las afirmaciones causales contienen una comparación implícita: qué habría ocurrido sin la exposición, sin la enfermedad o sin la intervención. Ese escenario contrafactual no puede observarse simultáneamente en el mismo paciente. La inferencia causal utiliza comparadores, mecanismos, secuencia y diseños de estudio para aproximarse a él (Hernán & Robins, 2020; Pearl & Mackenzie, 2018). En clínica, los contrafactuales también sirven como disciplina mental: "si esta hipótesis fuera falsa, ¿qué patrón alternativo esperaríamos?"; "si no intervengo hoy, ¿qué desenlace evitable se vuelve plausible?"; "si operamos y el mecanismo supuesto no existe, ¿qué daño habremos causado?".

El razonamiento contrafactual puede esclarecer, pero también fabricar certezas retrospectivas. Tras un desenlace adverso es fácil imaginar que otra decisión lo habría evitado. Para que el contrafactual sea serio debe respetar la información, opciones y recursos disponibles en el momento. La evaluación de una decisión no debe contaminarse por el conocimiento posterior del desenlace.

Puntos de inflexión

Algunas evoluciones cambian cualitativamente el caso. Una recurrencia menor puede convertirse en un episodio con shock; una enfermedad estable puede adquirir disfunción orgánica; una respuesta inicial puede dar paso a deterioro. El punto de inflexión no es sólo otro dato: redefine el riesgo de estrategias futuras. La frase clínica medular debe hacerlo visible.

Por ejemplo: "Cuarto episodio obstructivo en un año, esta vez asociado a bacteriemia e hipoperfusión grave, lo que modifica el balance previo favorable al manejo expectante." La frase no afirma que una nueva recurrencia será necesariamente fatal. Expresa que la historia observada ha cambiado la inferencia pronóstica y, con ella, el umbral de intervención.

El tiempo no sólo revela la enfermedad; transforma el significado de los hechos y puede convertir una estrategia antes razonable en una decisión ya insuficiente.

Una escritura temporalmente lúcida distingue fecha y secuencia, estado basal y actual, tendencia y variabilidad, intervención y respuesta, predicción y desenlace. Además, deja un horizonte prospectivo: qué se espera que ocurra, cuándo se reevaluará y qué hallazgo contará como fracaso. De este modo, la nota clínica no sólo documenta el pasado; organiza la próxima oportunidad de corregir el juicio.

Taller 10. La observación activa, por escrito

Un paciente con dolor abdominal inespecífico y laboratorio tranquilizador quedará "en observación". Redacte la indicación en no más de cuatro líneas, de modo que la observación sea una intervención diagnóstica y no una postergación.

Solución comentada. Una versión defendible: "Observación activa por dolor abdominal no filiado, con probabilidad baja pero no excluida de causa quirúrgica. Reevaluación médica dirigida a las 4 h (o antes si dolor creciente, vómitos, fiebre o taquicardia sostenida); control de laboratorio a las 6 h; si el dolor localiza, aparece defensa o el paciente no tolera vía oral, avisar de inmediato y repetir imagen. Si a las 8 h permanece asintomático y camina sin dolor, alta con instrucciones escritas de reconsulta." La estructura tiene los cuatro elementos: qué se espera aprender (evolución del dolor), en qué plazo (4-8 h), qué se vigila (variables nombradas, con responsable implícito) y qué constituye salida en ambas direcciones (escalar o alta). Compárese con "control según evolución", la fórmula que delega en la suerte lo que debía organizar el plan.

En una frase. Los hechos clínicos tienen fecha: la trayectoria —secuencia, velocidad, respuesta, recurrencia— es un dato mayor que cualquier valor aislado, y decidir es siempre apostar sobre un futuro contrafactual.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. "Está mejor": ¿mejor que cuándo, en qué variable y a qué velocidad?
2. ¿Qué predijo mi diagnóstico hace 48 horas, y la evolución lo confirmó o lo desmintió?
3. Mi "observación" de hoy, ¿tiene plazo, variables y criterio de salida, o es una espera sin diseño?

Capítulo 11**La ficha clínica como instrumento de pensamiento**

Abra la evolución de cualquier paciente con más de una semana de hospitalización y busque el párrafo que se repite idéntico desde el ingreso. Casi siempre existe. Alguien lo escribió el primer día, alguien lo copió el segundo, y desde entonces viaja como un polizón: "paciente con antecedente de ITU a repetición", "en estudio por baja de peso", "manejo habitual". Este capítulo trata de la ficha como tecnología cognitiva: la diferencia entre un registro que piensa y uno que fosiliza.

Registrar no es archivar

La ficha clínica suele entenderse como memoria legal y medio de comunicación. También puede ser un dispositivo cognitivo. Weed propuso el registro orientado por problemas para que la información guiara y enseñara, vinculando datos, evaluación y plan (Weed, 1968a, 1968b). La estructura del registro influye en lo que el equipo ve, recuerda y considera resuelto.

Una nota extensa puede ser epistemológicamente pobre si copia datos sin jerarquía. Una nota breve puede ser peligrosa si sólo conserva conclusiones. El objetivo es trazabilidad: que otro lector pueda identificar qué se observó, qué se infirió, qué permanece incierto y por qué se decidió.

La ficha produce lo visible

Foucault mostró que la clínica moderna no nació simplemente de mirar mejor, sino de reorganizar qué era decible y registrable: el hospital, la autopsia y el registro crearon un espacio donde ciertos fenómenos pudieron convertirse en signos y otros ni siquiera podían formularse (Foucault, 1973). La ficha contemporánea hace hoy ese mismo trabajo, silenciosamente. Sus campos deciden qué existe institucionalmente: si la plantilla tiene casilla para "dolor EVA" pero no hay lugar para "esta vez el dolor era otro", la primera afirmación sobrevivirá en el registro y la segunda morirá en el pasillo. Lo que no cabe en el formulario no se pierde por descuido; se pierde por diseño.

Esta perspectiva cambia el estatuto del registro: no es una ventana neutra sobre el caso, sino un instrumento óptico con distorsiones propias. Los menús desplegados convierten un continuo en categorías administrativas; los campos obligatorios producen texto ritual; las frases autocompletadas homogeneizan descripciones que eran distintas. Nada de esto es neutral para el razonamiento, porque —como vimos en el capítulo 4— el equipo piensa con las representaciones que el artefacto le permite conservar. Una epistemología clínica operativa incluye, por eso, la crítica del formulario: preguntar qué vuelve visible, qué vuelve invisible y a quién sirve esa distribución. El médico no siempre puede rediseñar la plantilla; siempre puede saber qué le está haciendo a su percepción.

El problema como unidad

La lista de problemas es más que una colección de diagnósticos. Puede incluir síndromes, hallazgos no explicados, riesgos y decisiones pendientes. "Anemia" puede ser un problema; "probable sangrado digestivo oculto" es una inferencia; "endoscopia pendiente" es una acción; "etiología no aclarada" es incertidumbre. Al separarlos, la ficha evita que una hipótesis adquiera estatus de hecho por repetición.

El copiado automático amenaza esta función. Una formulación inicial se reproduce durante días, aun cuando la evidencia cambió. El registro deja de representar el estado actual y se transforma en fósil narrativo. Cada evolución debería responder qué cambió en hechos, interpretación, incertidumbre y plan.

La matriz HII-D

Puede aplicarse una secuencia simple:

- **H — Hechos:** datos relevantes, fuente, fecha y evolución.
- **I — Inferencias:** diagnóstico o mecanismo propuesto, con grado de respaldo.
- **I — Incertidumbre:** alternativas, límites de pruebas y preguntas abiertas.
- **D — Decisión:** conducta, razón, umbral y criterio de reevaluación.

No es necesario rotular cada párrafo. La estructura puede estar implícita, pero debe ser recuperable. En casos complejos, explicitarla reduce ambigüedad.

Ejemplo:

Hechos: paciente con vejiga neurogénica y sonda permanente; sonda recambiada; orina turbia, piuria y urocultivo positivo; afebril, estable, sin nuevo deterioro sistémico; marcadores inflamatorios elevados con neoplasia avanzada como explicación alternativa.

Inferencia: bacteriuria asociada a catéter, sin evidencia clínica suficiente de infección urinaria sintomática.

Incertidumbre: síntomas urinarios clásicos no evaluables; debe vigilarse aparición de fiebre, inestabilidad, espasticidad nueva u otro cambio autonómico o sistémico.

Decisión: no iniciar antibiótico por ahora; monitorización y reevaluación ante criterios clínicos, considerando que el antecedente de microorganismo multirresistente eleva el costo ecológico de tratamiento innecesario.

Frase medular

Después de ordenar el caso, conviene formular una frase medular. No reemplaza la evolución completa; ofrece una representación operativa. Debe incluir la naturaleza del evento, el elemento que cambia el riesgo y el límite principal de certeza.

En el caso anterior: "Bacteriuria y piuria tras recambio de sonda en paciente con colonización crónica probable, sin manifestaciones sistémicas que sostengan CAUTI; se prioriza vigilancia clínica para evitar exposición innecesaria a antibióticos de amplio espectro."

La frase contiene una inferencia y una conducta. No declara que la infección sea imposible. Explica por qué la evidencia actual no supera el umbral terapéutico.

Temporalidad y revisión

La nota clínica debe preservar el tiempo. "Actualmente estable" no borra shock previo; "sin dolor" después de analgesia no describe el ingreso; "imagen sin complicación" no garantiza el futuro. Las fechas y secuencias permiten distinguir respuesta, coincidencia y causalidad.

También debe registrar qué haría cambiar. "Reevaluar si fiebre o deterioro" es mejor que "control evolutivo", porque define el mecanismo de revisión. Una decisión sin criterio de reapertura se vuelve inercia.

Una ficha de calidad no sólo cuenta lo que el equipo piensa; permite examinar cómo llegó a pensarlo y en qué condiciones debería dejar de pensarlo.

Escribir bien no es cosmética. Es una intervención sobre el razonamiento colectivo. La frase que mezcla capas puede perpetuar error; la que las distingue crea una oportunidad de corrección.

Taller 11. Desfosilizar una evolución

La siguiente evolución se ha copiado casi idéntica durante cinco días: "Paciente con neumonía en tratamiento antibiótico, hemodinamia estable, afebril, se mantiene manejo". El día 5, los datos reales son: afebril, pero con requerimiento de oxígeno que subió de 2 a 4 litros, PCR estancada y un derrame pleural nuevo en la radiografía de control. Reescriba la evolución del día 5 con estructura HII-D.

Solución comentada. "Hechos: día 5 de antibióticos por neumonía. Afebril desde el día 2, pero O₂ en aumento (2→4 L en 48 h), PCR sin descenso (180→165) y derrame pleural nuevo en radiografía de hoy. *Inferencia:* evolución discordante con neumonía en resolución; derrame paraneumónico complicado o empiema pasan a ser probables; falla del esquema o diagnóstico alternativo, posibles. *Incetidumbre:* características del derrame desconocidas hasta punción; la afebrilidad no excluye complicación supurativa. *Decisión:* toracocentesis diagnóstica hoy; reevaluar esquema según resultado; si no se puede puncionar en 24 h, escalar discusión con cirugía de tórax. Criterio de reapertura explícito: cualquier aumento adicional de O₂ o inestabilidad adelanta la punción.* La versión copiada no era falsa —el paciente estaba afebril y estable—; era un fósil: describía al paciente del día 2 con los datos del día 5. La reescritura no agregó información nueva: dejó de omitir la que ya existía.

En una frase. La ficha es una tecnología del pensamiento colectivo: bien escrita hace auditable el juicio y programable su revisión; copiada, convierte hipótesis viejas en hechos falsos.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Qué párrafo de mi evolución de hoy es copia de ayer, y sigue siendo verdad?
2. Si yo no estuviera mañana, ¿el médico que me reemplace sabría por mi nota qué vigilar y qué reabriría el caso?
3. ¿Mi lista de problemas distingue hechos, hipótesis, acciones pendientes e incertidumbres, o todo tiene el mismo estatus?

Capítulo 12**Pensar con otros: equipos, desacuerdo y comunicación de la incertidumbre**

A las 2:00, la enfermera de turno anota: "paciente más quejumbrosa, rechaza la cena, diuresis límite". A las 8:00, el pase de turno resume: "sin novedades". Entre esas dos frases no hay mala fe: hay una cadena de transmisión donde la información se comprimió hasta desaparecer. Este capítulo trata del conocimiento clínico como propiedad de un equipo —médicos, enfermería, paciente, familia, artefactos— y de cómo se degrada, se discute y se comunica.

La mente clínica no termina en el cráneo

La imagen clásica del razonamiento médico muestra a un profesional que reúne datos, formula hipótesis y decide. Esa unidad de análisis es necesaria, pero insuficiente para la práctica contemporánea. El conocimiento clínico se distribuye entre médicos, enfermería, kinesiólogos, técnicos, pacientes, familiares, monitores, formularios, sistemas informáticos y rutinas organizacionales. Nadie posee por sí solo el caso completo. Hutchins llamó cognición distribuida al estudio de cómo el procesamiento de información se realiza a través de personas y artefactos coordinados (Hutchins, 1995).

En una unidad hospitalaria, la enfermera puede reconocer primero un cambio de perfusión; el laboratorio produce una medición crítica; el sistema decide cómo la muestra se etiqueta y cuándo el resultado se hace visible; el médico integra el patrón; un familiar aporta la trayectoria basal; una hoja de balance conserva información que ninguna memoria individual podría reconstruir. La decisión emerge de esa red. La responsabilidad profesional permanece, pero el objeto metacognitivo debe ampliarse: no sólo "¿cómo pensé?", sino "¿cómo circuló y se transformó la información?".

Transferir es transformar

Un dato no viaja intacto. En cada entrega de turno, llamada o resumen se selecciona, comprime y reinterpreta. "Paciente estable" puede borrar una dosis creciente de oxígeno; "cultivo positivo" puede perder el contexto de colonización; "TAC sin complicaciones" puede convertirse erróneamente en "hernia no complicada" pese a un episodio fisiológicamente grave. Los artefactos también interpretan: una interfaz prioriza ciertos campos, separa otros y convierte opciones discretas en categorías administrativas.

Rajkomar y Blandford mostraron cómo la administración de infusiones en UCI puede comprenderse mediante cognición distribuida, atendiendo a la interacción entre profesionales, bombas, prescripciones y entorno (Rajkomar & Blandford, 2012). La lección es general: muchos errores que parecen "de una persona" son fallas de propagación, representación o coordinación. El sistema puede aumentar la capacidad cognitiva mediante redundancia y memoria externa, pero también fragmentar la situación y ocultar señales.

La ficha clínica es uno de estos artefactos. Una nota bien estructurada conserva procedencia, temporalidad y grado de certeza para el siguiente lector. Una nota retórica transmite una conclusión sin las condiciones para revisarla. La calidad epistemológica del equipo depende de que las representaciones sean auditables.

El desacuerdo como instrumento

Los equipos suelen tratar la discrepancia como obstáculo que debe cerrarse rápido. Sin embargo, un desacuerdo bien formulado puede revelar supuestos diferentes, hechos omitidos o umbrales distintos de acción. La diversidad de perspectivas sólo mejora el juicio cuando existe posibilidad real de expresar y examinar la diferencia. Sin seguridad psicológica, la jerarquía convierte la convergencia aparente en silencio.

No todo desacuerdo tiene igual valor. Debe traducirse a proposiciones evaluables: "no comparto que exista infección porque los hallazgos se explican mejor por colonización y no hay cambio fisiológico"; "acepto que la probabilidad de isquemia es baja, pero considero inaceptable el daño de perderla"; "estamos de acuerdo en los hechos, pero usamos distintos umbrales de intervención". Esta traducción muestra si la discrepancia está en datos, inferencias, incertidumbre, valores o decisión.

Las rondas clínicas pueden usar una pausa breve: ¿qué hechos nuevos cambian el caso?, ¿cuál es la inferencia principal y su alternativa?, ¿qué incertidumbre domina el riesgo?, ¿qué conducta se propone y qué la hará cambiar? La estructura HII-D no reemplaza la discusión libre; crea un lenguaje común para localizar la diferencia.

Diseño para la corrección

Un sistema seguro no depende de que cada individuo recuerde cuestionarlo todo. Diseña momentos y artefactos que facilitan detectar discordancias: tendencias visibles, alertas selectivas, listas de problemas actualizadas, criterios de reevaluación, acceso a datos fuente y roles claros para escalar preocupación. La National Academies conceptualizó el diagnóstico como un proceso de equipo y aprendizaje continuo, no como un acto aislado (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015).

La redundancia debe ser inteligente. Repetir información sin contraste aumenta ruido. La redundancia útil incorpora independencia parcial: una segunda lectura, una revisión por otro profesional o una comprobación contra datos primarios. Del mismo modo, la tecnología debe reducir carga sin convertir la automatización en autoridad incuestionada.

Comunicar incertidumbre sin perder confianza

Muchos clínicos temen que expresar incertidumbre debilite la confianza del paciente o del equipo. El resultado puede ser un lenguaje excesivamente categórico. El dilema es falso: la alternativa a la certeza no es desorientación. Es

una explicación estructurada de lo que se sabe, lo que se sospecha, lo que importa y qué se hará.

La confianza clínica no depende sólo de parecer seguro. Depende de competencia, honestidad, presencia y continuidad. Una frase como "no sabemos nada" abandona; "no puedo asegurar todavía la causa, pero hemos descartado las amenazas inmediatas más probables, vigilemos estos cambios y repetiremos la evaluación en este plazo" transforma incertidumbre en plan.

Una comunicación útil incluye cuatro elementos:

1. **Qué sabemos:** hallazgos confirmados y su relevancia.
2. **Qué creemos:** explicación principal y alternativas importantes.
3. **Qué no sabemos todavía:** límites concretos.
4. **Qué haremos:** acción, vigilancia y momento de revisión.

Este esquema reduce dos riesgos: transmitir falsa seguridad y trasladar al paciente una ambigüedad no elaborada.

Decisión compartida y narrativa

La decisión compartida cobra especial importancia cuando existen varias opciones razonables y los valores modifican el balance. El modelo de Elwyn y colaboradores propone deliberación sobre opciones, preferencias y decisión, no una simple entrega de información (Elwyn et al., 2012). La incertidumbre debe comunicarse de forma que la persona pueda entender cómo afecta las alternativas.

Los números ayudan cuando son confiables y comprensibles. Las frecuencias naturales —por ejemplo, "de 100 personas similares"— suelen ser más claras que probabilidades condicionales aisladas (Gigerenzer et al., 2007). Pero no todo puede cuantificarse. En esos casos se debe explicar la dirección y magnitud aproximada de la incertidumbre, evitando palabras vagas sin contexto.

La medicina narrativa recuerda que una decisión no ocurre sólo dentro de una distribución estadística. Ocurre en una biografía (Greenhalgh & Hurwitz, 1998; Charon, 2006). El mismo riesgo puede ser aceptable para una persona y no para otra según responsabilidades, experiencias, temor, tolerancia al deterioro y concepción de calidad de vida. Escuchar la historia también corrige inferencias. Una conducta que parece "mala adherencia" puede ser imposibilidad económica; "rechazo" puede expresar una experiencia previa; "síntoma funcional" puede ser vivido como invalidación. El lenguaje del médico puede abrir o cerrar la posibilidad de conocimiento.

Incertidumbre dentro del equipo

En pases de turno, la frase "está cubierto" suele ocultar supuestos. Es preferible nombrar quién verificará un resultado, qué diagnóstico no debe perderse y qué cambio exige avisar. La incertidumbre compartida se convierte en tarea distribuida.

Las jerarquías influyen. Si el médico más senior presenta una hipótesis como hecho, los demás pueden dejar de ofrecer datos discordantes. Una formulación como "mi impresión principal es X; me preocupa Y por esta razón; ¿qué dato no encaja?" conserva liderazgo y abre corrección.

La ética de la fuerza verbal

Cada palabra de certeza distribuye responsabilidad. "Descartado" puede cerrar vigilancia; "probable" puede justificar tratamiento; "posible" puede generar estudios de bajo valor. La modalidad epistémica tiene efectos. Por ello, su uso es también una cuestión ética.

La metacognición clínica madura es individual y colectiva: examina tanto el juicio del médico como la arquitectura que permitió, deformó o corrigió ese juicio.

Después de un error, preguntar "¿quién se equivocó?" puede ser necesario, pero rara vez es suficiente. También debe preguntarse dónde se originó la información, en qué transformación perdió significado, qué señales estaban disponibles, quién podía contradecir la hipótesis y por qué el sistema no aprendió antes. La lucidez de un equipo se mide menos por la ausencia imposible de errores que por su capacidad de hacerlos visibles, limitarlos y convertirlos en conocimiento compartido.

Taller 12. Traducir un desacuerdo

En la ronda, el intensivista dice: "Yo la operaría ahora; esto va a volver a pasar". La internista responde: "Me parece apresurado; acaba de salir de un shock". Traduzca el desacuerdo a proposiciones evaluables: ¿discrepan en hechos, inferencias, incertidumbre, valores o decisión?

Solución comentada. Al traducir, el desacuerdo se descompone: en los **hechos** no hay disputa (cuatro episodios, shock reciente, imagen sin isquemia). En la **inferencia** pronóstica están de acuerdo más de lo que creen: ambos consideran probable una nueva obstrucción. La divergencia real está en dos lugares: la **incertidumbre** sobre la aptitud quirúrgica actual (¿cuánto deteriora el riesgo operatorio el shock reciente? — dato reducible con evaluación objetiva, no con opinión) y el **umbral de decisión** (cuánto riesgo perioperatorio aceptar para evitar cuánto riesgo obstructivo — que además involucra **valores** de la paciente, ausente de la conversación). Traducido así, el plan se escribe solo: evaluación funcional formal, optimización, y una conversación con Carmen sobre los dos riesgos. El desacuerdo no se "ganó": se usó.

En una frase. El conocimiento clínico vive en una red de personas y artefactos: cuidar cómo se transfiere, cómo se discute y cómo se comunica la incertidumbre es cuidar el razonamiento mismo.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Qué observó enfermería en las últimas 24 horas que no pasó por mi evaluación?
2. En mi último desacuerdo clínico, ¿discrepábamos en hechos, inferencias, incertidumbre, valores o umbral?
3. ¿Mi paciente sabe qué sabemos, qué creemos, qué no sabemos aún y qué haremos —o sólo recibió una etiqueta?

Interludio III**La decisión de Carmen**

El día 7, Carmen está sin sonda, comiendo, caminando por el pasillo. La evaluación preoperatoria muestra un EPOC moderado compensado y una capacidad funcional aceptable. Es el momento de la conversación que el equipo había ido preparando sin decirlo: la internista, la cirujana y Carmen, con su hija presente porque ella lo pidió.

La cirujana no empieza por la propuesta. Empieza por el esquema de cuatro pasos: "Le voy a contar qué sabemos, qué creemos, qué no sabemos y qué opciones hay. Lo que sabemos: usted tiene una hernia que este año se ha obstruido cuatro veces, y la última vez llegó grave, con infección en la sangre y presión muy baja. Lo que creemos: que la probabilidad de que vuelva a pasar es alta, y que un próximo episodio puede ser tan grave como este o peor; no podemos ponerle fecha. Lo que no sabemos: si la cirugía va a ser sencilla —su tejido está operado de antes— ni cómo va a responder su pulmón a la anestesia; el riesgo existe y no es despreciable. Las opciones: operarnos ahora que usted está recuperada, en forma programada, con todo preparado; o esperar, sabiendo que la próxima obstrucción puede llegar de urgencia, de noche, con usted más débil".

Carmen pregunta lo que casi todos preguntan: "¿Y usted qué haría?". La cirujana responde con la estructura del capítulo 14 en mente: "Yo le recomiendo operarse, y le digo por qué: prefiero un riesgo quirúrgico conocido, con usted optimizada, a un riesgo obstructivo que no controlamos ni podemos programar. Pero la que pasó el shock fue usted, y la que decide cuánto miedo le tiene a cada uno de esos riesgos también es usted".

La hija pregunta si la cirugía "garantiza" que no habrá más obstrucciones. "No", dice la cirujana, "baja mucho la probabilidad; no la hace cero. Si le dijera otra cosa, le estaría mintiendo."

Carmen acepta. En la ficha, la internista escribe la frase medular que resume tres semanas de trabajo epistémico: "Obstrucción recurrente por hernia incisional, cuarto episodio en un año y primero con shock y bacteriemia; sin complicación anatómica aguda en imagen. El cambio cualitativo de gravedad, la aceleración de las recurrencias y la preferencia informada de la paciente justifican reparación electiva tras optimización, asumiendo riesgo perioperatorio moderado como alternativa preferible a una nueva urgencia no programada. Reevaluar decisión si deterioro funcional o nuevo episodio antes de la fecha quirúrgica."

Ninguna palabra de esa frase es adorno. Cada una carga un capítulo de este libro.

PARTE IV

Una epistemología operativa

Las tres primeras partes construyeron las herramientas; esta las pone a trabajar. Primero frente al espejo nuevo de la inteligencia artificial (capítulo 13) y frente a la responsabilidad que ninguna herramienta puede delegar (capítulo 14). Luego, el método HII-D en forma completa y en versión de sesenta segundos (capítulo 15), un cuaderno de ocho casos para leer metacognitivamente — incluida la resolución de la historia de Carmen—, y el problema de enseñar y organizar todo esto (capítulo 16).

Capítulo 13

Inteligencia artificial como espejo del razonamiento

Un residente pega la historia de un paciente en un asistente de lenguaje y recibe, en ocho segundos, una evaluación impecablemente redactada: diagnóstico probable, diferenciales ordenados, plan sugerido. Todo suena verosímil. La pregunta que este capítulo propone no es "¿acierta la máquina?", sino una más incómoda: ¿en qué se parece esa prosa fluida y segura a la que escribimos nosotros?

Lenguaje plausible y verdad

Los grandes modelos de lenguaje generan continuaciones plausibles a partir de patrones aprendidos en enormes corpus. Su fluidez puede producir respuestas clínicamente útiles, pero también afirmaciones falsas presentadas con coherencia. La literatura denomina *hallucination* a contenido no sustentado o inconsistente con la fuente o el mundo (Ji et al., 2023). El término es metafórico: el modelo no tiene una experiencia perceptiva que se desorganice como en la alucinación humana.

La medicina reconoce el peligro porque también trabaja con narrativas plausibles. Un clínico puede completar huecos, atribuir causalidad o recordar un dato de manera congruente con su hipótesis. La semejanza no implica identidad. El médico posee cuerpo, responsabilidad, acceso al paciente, experiencia situada y capacidad de actuar; el modelo manipula representaciones lingüísticas y depende del contexto que recibe.

Competencia sin garantía

Estudios han mostrado que modelos avanzados codifican conocimiento médico y alcanzan alto rendimiento en preguntas y casos seleccionados (Singhal et al., 2023). Lee, Bubeck y Petro describieron beneficios potenciales junto con límites y riesgos de GPT-4 en medicina (Lee et al., 2023). El rendimiento promedio no garantiza confiabilidad en un caso individual, especialmente cuando faltan datos, hay ambigüedad o la tarea exige conocimiento local. Y las consecuencias no intencionadas del aprendizaje automático en medicina —desde la automatización de sesgos presentes en los datos hasta la erosión de habilidades por deferencia— han sido advertidas desde antes de los modelos generativos (Cabitza et al., 2017).

La fluidez aumenta el riesgo de automatización: el usuario puede aceptar una respuesta porque está bien estructurada. El problema es metacognitivo. La confianza percibida en el lenguaje no informa necesariamente la probabilidad de corrección. La IA puede parecer mejor calibrada de lo que está.

Una diferencia central

El clínico responsable puede distinguir "lo vi", "lo infiero" y "no lo sé". Un modelo suele mezclar estas capas si el prompt no exige separación y si no tiene fuentes

verificables. Puede transformar ausencia de información en un detalle probable, porque su objetivo generativo favorece continuidad.

La matriz HII-D permite auditar una respuesta de IA:

- ¿qué hechos provienen realmente del caso?;
- ¿qué información agregó el modelo?;
- ¿qué inferencias formula y con qué respaldo?;
- ¿qué incertidumbres omitió?;
- ¿qué decisión propone y cuáles serían sus riesgos?;
- ¿qué fuente primaria permite verificar la afirmación?

El modelo puede servir como generador de alternativas, revisor de coherencia, organizador de información o segundo lector. Su valor aumenta cuando el usuario mantiene la responsabilidad de verificación y disminuye cuando se usa como autoridad final.

Metacognición artificial

Algunos sistemas pueden expresar confianza, criticar una respuesta o revisar pasos. Eso no demuestra autoconocimiento en el sentido humano. Una salida metacognitiva puede ser otra generación entrenada para imitar evaluación. La pregunta práctica no es si el sistema "sabe que sabe", sino si sus señales de confianza están empíricamente calibradas y si el flujo de trabajo detecta fallas.

Esa pregunta ya tiene datos. La evidencia disponible muestra que la confianza verbalizada de los grandes modelos —el "estoy bastante seguro" que escriben— tiende a la sobreconfianza sistemática y se calibra mal, aun cuando algunas señales internas del modelo discriminan mejor de lo que su prosa deja ver (Kadavath et al., 2022; Xiong et al., 2024). La implicación práctica es idéntica a la del capítulo 5, aplicada ahora a la máquina: preguntarle a un modelo cuán seguro está no sustituye la verificación, igual que la seguridad de un colega no sustituye sus razones. La calibración se demuestra con series de predicciones y desenlaces, no con tono.

La OMS ha recomendado gobernanza, evaluación, transparencia y supervisión para modelos multimodales en salud, atendiendo riesgos de inexactitud, sesgo, privacidad y dependencia excesiva (World Health Organization, 2024). La supervisión humana no debe ser una firma ritual al final. Debe contar con tiempo, datos y autoridad para cuestionar.

La IA como provocación filosófica

La IA revela que una frase puede conservar la forma externa del razonamiento sin tener acceso directo al evento. Esto obliga a recordar que la coherencia verbal nunca fue garantía suficiente. También muestra el valor del lenguaje como espacio de prueba: pedir alternativas, contraejemplos y explicitar incertidumbre puede mejorar la deliberación humana, aunque no vuelva verdadero al modelo.

La IA puede ampliar el espacio de hipótesis; no puede asumir por sí sola la responsabilidad de transformar una hipótesis en conducta clínica.

Usada con disciplina, puede ser un instrumento metacognitivo externo. Usada por deferencia, puede reforzar el mismo error que pretendía corregir: convertir plausibilidad en certeza.

En una frase. La IA generativa produce exactamente aquello contra lo que este libro entrena: prosa fluida donde hechos, inferencias e incertidumbre llegan mezclados — auditarla con HII-D es el mismo ejercicio que auditar la propia escritura.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. Si uso IA en este caso, ¿qué dato de su respuesta verifiqué contra una fuente primaria antes de actuar?
2. ¿Qué agregó el modelo que el caso no contenía?
3. ¿Estoy usando la herramienta para ampliar hipótesis o para confirmar rápido la que ya tenía?

Capítulo 14**Humildad epistémica y responsabilidad clínica**

Hay una frase que me costó años aprender a decir delante de una familia: "no lo sé". La primera vez que la dije completa —"no sé todavía por qué empeoró; sé qué descartamos, sé qué vamos a vigilar esta noche y sé cuándo tendremos más información"— esperaba encontrar decepción. Encontré alivio. La familia no necesitaba mi certeza; necesitaba saber que la incertidumbre estaba siendo trabajada. Este capítulo trata de esa diferencia: entre parecer seguro y ser responsable.

Afirmar es asumir una responsabilidad

Una frase clínica no es moralmente neutra. Puede activar una cirugía, justificar aislamiento, etiquetar a una persona, limitar tratamientos o fijar una interpretación que otros repetirán. Cuando escribimos "rechaza", "no adherente", "funcional", "terminal" o "sin indicación", no sólo describimos. Distribuimos credibilidad, urgencia y recursos. La ética del razonamiento comienza antes de la decisión: comienza en la forma en que se recibe un testimonio y se concede fuerza a una afirmación.

La prudencia aristotélica —phronesis— no es cautela pasiva, sino capacidad de deliberar bien sobre lo que conviene hacer en una situación particular. Pellegrino y Thomasma situaron el juicio clínico en el encuentro entre conocimiento técnico, bien del paciente y obligación moral (Pellegrino & Thomasma, 1981). La decisión médica nunca es únicamente correcta por su coherencia lógica; debe ser justificable para la persona sobre la que actúa.

Humildad epistémica

La humildad epistémica no consiste en disminuir artificialmente la propia competencia ni en presentar todas las hipótesis como equivalentes. Consiste en conocer el alcance y los límites de las razones disponibles, reconocer dependencia de otros y mantener apertura real a corrección. Es compatible con decisiones firmes. Un cirujano puede afirmar que una intervención es urgente y, al mismo tiempo, distinguir qué mecanismo está demostrado, qué riesgo se estima y qué desenlace sigue siendo incierto.

La falsa seguridad daña porque cierra la revisión y puede engañar al paciente. La duda indiscriminada también daña: transfiere carga, paraliza decisiones o abandona a la persona bajo una apariencia de neutralidad. La virtud está en calibrar. Decir "no lo sé" es profesional cuando se acompaña de qué sí se sabe, qué se hará, qué riesgo se vigila y cuándo se reevaluará.

Credibilidad y experiencia del paciente

Miranda Fricker denominó injusticia epistémica al daño cometido contra alguien en su capacidad de sujeto de conocimiento (Fricker, 2007). En salud, Carel y Kidd mostraron cómo el testimonio de pacientes puede recibir menor credibilidad o

carecer de categorías interpretativas adecuadas, y cómo la propia experiencia de enfermar agudiza esa vulnerabilidad epistémica (Carel & Kidd, 2014; Kidd & Carel, 2017). El enfermo posee un conocimiento de primera persona sobre dolor, cambio funcional, tolerancia, valores y trayectoria cotidiana que no puede ser sustituido por mediciones externas. Ese conocimiento tampoco es infalible, pero merece evaluación y no descarte reflejo.

La filosofía del testimonio ayuda a precisar qué significa "evaluar sin descartar". Contra la sospecha heredada del empirismo —que creerle a otro es siempre conocimiento de segunda categoría—, Coady mostró que el testimonio es una fuente básica de conocimiento, tan constitutiva como la percepción o la memoria: sin una confianza por defecto en lo que otros informan, ni la ciencia ni la vida cotidiana serían posibles (Coady, 1992). Lackey corrigió el exceso opuesto: la confianza por defecto no es un cheque en blanco; el oyente responsable mantiene una sensibilidad activa a las señales de error o engaño, y el conocimiento testimonial se logra cuando ambas condiciones —decir fiable y escuchar vigilante— se cumplen a la vez (Lackey, 2008). La anamnesis es exactamente ese contrato epistémico: el paciente aporta un informe que el médico no puede obtener por ninguna otra vía, y el médico aporta el examen de consistencia, forma temporal y relación con otros hallazgos. Ni credulidad ni auditoría hostil: recepción con estándares. La injusticia testimonial es, en estos términos, un fallo del segundo contratante: aplicar a ciertos hablantes un estándar de vigilancia que no se aplica a otros, por razones que nada tienen que ver con la fiabilidad de su informe.

La injusticia testimonial aparece cuando prejuicios sobre edad, género, origen, diagnóstico psiquiátrico, discapacidad o estilo comunicativo reducen injustificadamente la credibilidad. La injusticia hermenéutica surge cuando faltan conceptos compartidos para expresar una experiencia o cuando la institución sólo admite aquello que cabe en sus formularios. En ambos casos, el problema no es cortesía: se pierde evidencia clínicamente relevante.

Escuchar de manera epistémica implica preguntar qué sabe esta persona que el equipo no puede observar, qué interpretación atribuye a sus síntomas y qué experiencias anteriores modifican su decisión. También exige distinguir desacuerdo de incapacidad. Un paciente puede comprender la evidencia y valorar de manera diferente los desenlaces. Cuando Carmen dijo "esta vez el dolor era otro", estaba entregando el dato pronóstico más importante del ingreso; la nota que lo hubiera omitido habría cometido, además de una injusticia, un error técnico.

La ética de la incertidumbre

Comunicar incertidumbre es una obligación de veracidad, pero la forma importa. Entregar una lista de posibilidades sin jerarquía puede aumentar angustia sin mejorar autonomía. Ocultar la duda para preservar confianza produce una alianza frágil. La comunicación responsable estructura: qué explicación es más probable, qué alternativas relevantes permanecen, qué riesgos justifican actuar, qué señales deben motivar consulta y qué aspectos dependen de preferencias.

La decisión compartida no significa que médico y paciente aporten lo mismo. El profesional ofrece conocimiento técnico, estimación de consecuencias y recomendación; el paciente aporta experiencia, objetivos y tolerancia al riesgo (Elwyn et al., 2012).

Existe además una ética de la revisión. Una hipótesis provisional que se documenta sin plan de seguimiento puede transformarse en daño por inercia. Quien decide bajo incertidumbre adquiere la obligación de definir cómo se reconocerá el error. Los criterios de alarma, controles, responsable y plazo no son tareas administrativas agregadas: completan la racionalidad moral de la decisión.

Autoridad sin opacidad

La relación clínica es asimétrica: el profesional posee conocimientos, acceso institucional y capacidad de activar intervenciones que el paciente no controla. Esa asimetría hace necesaria la recomendación experta, pero también exige que la autoridad sea explicable. "Yo haría esto" tiene valor cuando resume razones; se vuelve problemática cuando sustituye su examen.

Recomendar no es imponer ni retirarse. El médico debe señalar qué opción considera preferible, qué hechos sostienen esa preferencia, qué incertidumbres podrían modificarla y qué valores del paciente son decisivos. La neutralidad aparente puede abandonar a una persona precisamente cuando necesita orientación. La autoridad bien ejercida reduce complejidad sin ocultar desacuerdos razonables. La respuesta de la cirujana a Carmen —"yo le recomiendo operarse, y le digo por qué"— es la forma completa del gesto: recomendación, razones, límites y devolución de la decisión.

También existe responsabilidad sobre las palabras que permanecen. Un diagnóstico inscrito en la ficha puede condicionar futuras interpretaciones incluso después de perder sustento. Corregir, fechar y explicar cambios de hipótesis es una obligación epistémica. No basta con pensar de nuevo; el sistema debe poder reconocer que se pensó de nuevo.

La humildad clínica no consiste en afirmar menos, sino en no afirmar más de lo que permiten los hechos y no decidir menos de lo que exige el riesgo.

La lucidez une epistemología y ética. Sobreestimar la certeza puede conducir a intervenciones injustificadas; subestimar la gravedad puede negar protección; desacreditar un relato puede borrar el dato decisivo. Por ello, hechos, inferencias e incertidumbre no son sólo categorías del conocimiento. Son también una disciplina de respeto: permiten que el paciente sepa qué sostiene nuestra recomendación, dónde están sus límites y cómo responderemos si la realidad contradice lo esperado.

La confianza profesional más robusta no depende de parecer infalible. Se construye cuando el paciente y el equipo pueden reconocer una pauta: afirmaciones proporcionadas, revisión ante nueva evidencia y responsabilidad sobre las consecuencias de la decisión.

En una frase. Afirmar, dudar y recomendar son actos morales: la humildad epistémica bien entendida produce decisiones más firmes, no más tibias, porque cada afirmación carga exactamente el peso que puede sostener.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿A qué paciente le estoy creyendo menos de lo que su testimonio merece, y por qué?
2. Mi última recomendación firme: ¿podría explicar qué hechos la sostienen, qué incertidumbres la modificarían y qué valores del paciente pesan?
3. ¿Hay en mis fichas una etiqueta ("funcional", "no adherente", "poco colaborador") que esté distribuyendo credibilidad en lugar de información?

Capítulo 15**El método HII-D: una epistemología operativa**

Todo lo anterior cabe en una hoja. Esa es, deliberadamente, la ambición de este capítulo: condensar el libro en un método que pueda usarse en una discusión de caso, en una nota difícil, en una auditoría de IA o en los sesenta segundos previos a una decisión nocturna. La condensación tiene un precio —ningún método piensa por nadie— y una condición: saber cuándo usarlo y cuándo no.

Una heurística, no una escala

HII-D organiza el razonamiento en cuatro dominios: hechos, inferencias, incertidumbre y decisión. No pretende describir toda la cognición médica ni asignar puntajes. Es una heurística para casos en que la representación se ha vuelto confusa, la conducta es controvertida, existe alto riesgo o se necesita una comunicación especialmente trazable.

Su principio es simple: cada afirmación importante debe poder ubicarse en una capa, y cada decisión debe mostrar cómo se relaciona con las otras. El método agrega un quinto movimiento transversal: reevaluación. Toda formulación es temporal.

Hechos sin inferencia son inventario; inferencias sin incertidumbre, dogma; incertidumbre sin decisión, parálisis; decisión sin reevaluación, inercia.



Versión de 60 segundos: ¿qué vi? · ¿qué creo y con qué derecho? ·
¿qué dañaría al paciente si me equivoco? · ¿qué me haría cambiar?

Figura 8. El método HII-D en una página: cinco pasos, cuatro capas y un movimiento transversal de reevaluación que devuelve al mundo la capacidad de corregirnos.

Paso 1. Definir la pregunta

Antes de ordenar datos, conviene precisar qué decisión está en juego. "¿Cuál es el diagnóstico?" puede ser demasiado amplio. Preguntas más útiles son: ¿existe infección que justifique antibiótico?, ¿hay una complicación anatómica que exige cirugía urgente?, ¿el riesgo de recurrencia modifica la oportunidad de reparación?, ¿qué explicación del síntoma requiere excluirse antes de un manejo funcional?

La misma información adquiere distinta relevancia según la pregunta. Definirla evita estudiar todo sin jerarquía.

Paso 2. Inventariar hechos y procedencia

Se seleccionan hechos capaces de modificar la respuesta. Cada uno conserva fuente, fecha, tendencia y limitación. Debe distinguirse dato presente, hallazgo negativo, dato ausente y dato no evaluable.

Una técnica útil es escribir primero sin diagnósticos: edad y contexto; temporalidad; fisiología; examen; microbiología; imagen; respuesta;

antecedentes que modifican prior. Esta suspensión breve impide que la etiqueta ordene retroactivamente los datos.

Paso 3. Formular inferencias graduadas

Se propone una representación principal y, si importa, alternativas. Cada inferencia se acompaña de una fuerza verbal proporcional: demostrado, altamente probable, probable, posible o no sustentado. Deben explicitarse los enlaces causales no observados.

Una inferencia clínica útil explica por qué los hechos se agrupan y qué predice. Si no cambia comprensión, conducta o vigilancia, quizá sea sólo un nombre.

Paso 4. Mapear incertidumbre

Se pregunta qué parte del modelo puede estar equivocada, qué prueba reduciría la duda, qué sólo aclarará la evolución y qué permanecerá incierto. Luego se prioriza por consecuencias: ¿cuál incertidumbre es peligrosa?, ¿cuál es tolerable?, ¿cuál no cambia el manejo?

Aquí se reconoce la diferencia entre "no sé la etiología exacta" y "no sé si existe una amenaza inmediata". La segunda suele dominar la acción.

Paso 5. Decidir por umbral y consecuencias

La decisión integra probabilidad, gravedad, tiempo, reversibilidad, capacidad de monitorización y valores. Debe poder formularse: "aunque X no está demostrado, actúo porque..." o "aunque X es posible, no actúo todavía porque...". Esta frase obliga a distinguir compromiso práctico de certeza epistémica.

Toda decisión incluye un plan de reapertura: criterio clínico, examen pendiente, plazo o evento. Sin él, HII-D queda incompleto.

Plantilla condensada

- Pregunta operativa:
- Hechos decisivos:
- Inferencia principal y grado:
- Alternativa que cambiaría conducta:
- Incertidumbre crítica:
- Decisión y razón:
- Criterio de reevaluación:

Caja de herramientas. HII-D en 60 segundos

La versión completa es para casos difíciles. Para el resto —el ingreso número doce de la noche, la reevaluación entre dos urgencias— existe una versión mínima de cuatro preguntas, pensada para decirse mentalmente en el pasillo:

1. **¿Qué vi y qué me contaron?** (un hecho decisivo, con su fuente)
2. **¿Qué creo y cuánto derecho tengo a creerlo?** (la inferencia principal, con su grado)
3. **¿Qué me mataría al paciente si estoy equivocado?** (la incertidumbre peligrosa, no todas)
4. **¿Qué hago, y qué me haría cambiar antes del próximo control?** (decisión con criterio de reapertura)

Sesenta segundos no producen una epistemología; producen algo más modesto y a veces suficiente: impiden que la frase "cuadro habitual, manejo habitual" se escriba sola. Si alguna de las cuatro respuestas incomoda —el hecho decisivo resulta heredado, la confianza no tiene fuente, la incertidumbre peligrosa no tiene vigilancia—, esa incomodidad es la indicación para la versión completa.

Uso en equipo

En una ronda, cada integrante puede desafiar una capa distinta. Enfermería aporta evolución y respuesta; radiología delimita lo que la imagen muestra y lo que no; microbiología precisa relevancia y contaminación; cirugía integra anatomía y oportunidad; el paciente aporta síntomas, preferencias y desenlaces que valora. El método no centraliza el conocimiento en una sola voz.

También puede usarse para revisar una nota, un informe de alta o una respuesta de IA. La pregunta siempre es la misma: ¿la fuerza del lenguaje corresponde a la fuerza de la evidencia y la decisión corresponde a las consecuencias?

Calibración y auditoría del método

HII-D puede usarse retrospectivamente para examinar decisiones. La pregunta no es sólo si el diagnóstico final coincidió, sino si los hechos fueron representados con fidelidad, si las inferencias recibieron una fuerza proporcional, si la incertidumbre relevante fue identificada y si la decisión era defendible con la información disponible. Este análisis evita confundir calidad del proceso con fortuna del desenlace.

La calibración requiere comparar predicciones con resultados. Cuando sea posible, conviene registrar no sólo una hipótesis, sino un grado verbal o numérico de confianza y una expectativa temporal. Más tarde puede revisarse: ¿la certeza fue excesiva?, ¿la alternativa descartada ocurrió con frecuencia?, ¿el criterio de alarma fue sensible?, ¿la conducta se modificó cuando debía? Sin retorno de información, la experiencia puede acumular años sin transformarse en pericia.

Qué evidencia me haría abandonar este método

Un libro que exige compromisos observables a cada hipótesis clínica debe formular los suyos. Estos son los míos.

Primero: si clínicos entrenados no logran un acuerdo razonable al clasificar las frases de una nota en hechos, inferencias e incertidumbre, la distinción central del método es subjetiva en la práctica, y HII-D debe reformularse o abandonarse.

La trazabilidad que promete depende de que las capas sean reconocibles entre lectores, no sólo para quien escribe.

Segundo: si las notas escritas con esta disciplina no difieren de las convencionales en instrumentos estándar de calidad de registro, ni en la capacidad de otro clínico para reconstruir el razonamiento a partir de ellas, el método es cosmética con nombre propio.

Tercero: si un servicio que adopta el léxico de certeza no modifica en algunos meses ninguna conducta medible —ningún "se descarta" reconvertido, ningún criterio de reapertura agregado, ninguna vigilancia activada que antes no existía —, el léxico es un póster, no una herramienta.

Cuarto: si el tiempo que consume la versión completa supera de forma sostenida el beneficio detectable, la respuesta racional no es la fe sino la poda: quedarse con la versión de sesenta segundos, o con nada.

Formular estas condiciones no es un gesto retórico de modestia. Es la diferencia entre proponer una hipótesis y fundar una escuela. Prefiero lo primero: que el método quede expuesto a la misma reevaluación que le exige a cada diagnóstico, y que el mundo conserve, también aquí, la capacidad de corregirnos.

Límites

HII-D no sustituye protocolos, guías, probabilidades cuantitativas ni experiencia. Puede generar falsa prolijidad si se aplica mecánicamente. No todo caso necesita cuatro subtítulos. En urgencias, la acción puede preceder a la formulación completa; aun así, la reevaluación posterior debe reconstruirla. Debe decirse con la misma claridad: HII-D no ha sido validado como instrumento —no existen aún estudios de fiabilidad ni de impacto—, y este libro lo presenta como heurística de escritura y deliberación, no como tecnología probada. El método debe permanecer liviano. La extensión apropiada depende del riesgo, novedad y reversibilidad. Una decisión rutinaria puede requerir una línea; una situación de alto impacto merece una representación más desplegada. La profundidad debe ser selectiva y proporcional.

Hechos sin inferencia son inventario; inferencias sin incertidumbre son dogma; incertidumbre sin decisión es parálisis; decisión sin reevaluación es inercia.

El valor del método depende de una actitud: aceptar que la claridad no consiste en eliminar la complejidad, sino en ordenar qué tipo de conocimiento representa cada afirmación.

Taller 15. Su paciente, esta semana

Elija el caso más incómodo de su lista actual —el que genera discusión en cada ronda o el que nadie discute hace días— y complete la plantilla condensada por escrito. Después compárela con la última evolución de la ficha: ¿qué contiene la plantilla que la ficha no registra?

Solución comentada. No hay solución única, pero hay un patrón casi universal al comparar: la ficha suele contener los hechos y la decisión, y omitir las dos capas intermedias —el grado de la inferencia ("neumonía" sin "probable/demostrada") y la incertidumbre crítica con su vigilancia—. Es decir: registra qué se piensa y qué se hace, pero no cuánto derecho hay a pensarlo ni qué lo haría cambiar. Si su plantilla y su ficha coinciden, este libro le debe una disculpa por las horas invertidas. Si no coinciden, la plantilla acaba de mostrarle qué escribir mañana.

En una frase. HII-D es el libro entero plegado en una hoja: pregunta, hechos con procedencia, inferencias graduadas, incertidumbre priorizada, decisión por umbral y reapertura programada.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál es la pregunta operativa de mi caso más difícil —la decisión real en juego, no "el diagnóstico"?
2. ¿Mi nota de hoy permite a otro médico reconstruir mis cuatro capas, o sólo mi conclusión?
3. ¿Qué decisión de esta semana tomé sin criterio de reapertura, y todavía estoy a tiempo de escribirlo?

Cuaderno de casos**Ocho viñetas para una lectura metacognitiva**

Las viñetas siguientes son composiciones docentes. Cada una se presenta con la estructura HII-D y una frase medular. No son casos "resueltos": son casos representados. La invitación es leer cada uno dos veces —primero como clínico, buscando la conducta; después como lector metacognitivo, observando qué hace cada capa.

Viñeta 1. Carmen: obstrucción recurrente y cambio cualitativo de riesgo

La historia completa atraviesa este libro; aquí queda su forma condensada, la que cabría en una discusión de caso.

Mujer de 61 años con hernia incisional y tres ingresos por suboclusión resueltos sin cirugía. Cuarto episodio con íleo, shock, hiperlactatemia, perfusión periférica alterada y hemocultivos con bacilos gramnegativos. Mejora con reposo digestivo, antibióticos y noradrenalina. La tomografía no muestra perforación, isquemia ni estrangulación.

Hechos: recurrencia documentada y acelerada; episodio actual fisiológicamente grave; bacteriemia; respuesta favorable; ausencia de complicación anatómica visible en la imagen.

Inferencia: foco abdominal y relación con el evento obstructivo son probables, pero el mecanismo exacto no está demostrado. La ausencia de estrangulación reduce la indicación de emergencia, no el riesgo futuro.

Incertidumbre: probabilidad y momento de recurrencia; causalidad microbiológica exacta; aptitud y riesgo operatorio una vez recuperada.

Decisión: valoración quirúrgica temprana para reparación electiva una vez optimizada, con decisión compartida documentada. El argumento no es "fracasó todo manejo médico", sino que la gravedad actual cambia el costo esperado de una nueva estrategia expectante.

Frase medular: "Obstrucción recurrente por hernia incisional, por primera vez asociada a shock y bacteriemia, sin complicación anatómica aguda en tomografía; el cambio cualitativo de gravedad justifica priorizar resolución electiva tras recuperación fisiológica."

Epílogo. Carmen fue operada seis semanas después, en forma programada. La cirugía encontró adherencias firmes y un anillo herniario estrecho; no hubo complicaciones mayores. Nada de eso demuestra que la decisión fue correcta —un desenlace no valida un proceso—, pero el proceso era defendible antes de conocer el desenlace, que es lo único que puede pedírsele a una decisión clínica. La frase de su ingreso, "cuadro habitual, manejo habitual", quedó en la ficha como lo que era: la hipótesis rápida que el trabajo de tres semanas convirtió en otra cosa.

Viñeta 2. Bacteriuria en paciente con sonda permanente

Un paciente con lesión medular completa, vejiga neurogénica, sonda Foley y neoplasia avanzada presenta orina turbia, piuria y urocultivo positivo después de recambio de sonda. Está afebril, estable y sin otro cambio clínico. Los marcadores inflamatorios están elevados, sin valor basal y con explicación tumoral posible. Tiene antecedente de enterobacteria productora de BLEE.

Hechos: colonización de alto riesgo basal; cultivo positivo; piuria; ausencia de fiebre o inestabilidad; síntomas urinarios clásicos no evaluables; costo alto de antibiótico amplio.

Inferencia: bacteriuria asociada a catéter es más probable que infección sintomática con la información actual. Piuria y turbidez no distinguen por sí solas colonización de infección.

Incetidumbre: la lesión medular modifica la expresión clínica; se requiere vigilancia de signos autonómicos, espasticidad, malestar nuevo o deterioro sistémico.

Decisión: no tratar de inmediato; establecer criterios explícitos de reevaluación. El antecedente de BLEE no es argumento para tratar antes, sino una razón adicional para exigir umbral clínico suficiente.

Frase medular: "Urocultivo positivo y piuria en usuario crónico de Foley, sin manifestaciones sistémicas nuevas que sostengan CAUTI; cuadro más compatible con bacteriuria asociada a catéter, con vigilancia reforzada por expresión sintomática limitada y antecedente de resistencia."

Viñeta 3. Globus y necesidad de una explicación no reductiva

Una paciente refiere sensación persistente de cuerpo extraño faríngeo, sin disfagia progresiva, odinofagia, pérdida de peso ni alteración estructural en evaluación inicial. Los síntomas fluctúan con estrés y atención corporal. Solicita "un examen que muestre qué tiene".

Hechos: sensación localizada; ausencia de signos de alarma; evaluación estructural no reveladora; variabilidad contextual.

Inferencia: globus funcional es probable después de una evaluación apropiada. "Funcional" no significa inventado; describe alteración de percepción, atención, sensibilidad y regulación sin lesión estructural suficiente para explicarla.

Incetidumbre: ningún examen elimina todo riesgo futuro; la conducta depende de evolución y aparición de banderas rojas. Puede coexistir reflujo, tensión muscular o factores afectivos sin causalidad única.

Decisión: explicar el diagnóstico positivo, evitar escalamiento indiscriminado de pruebas, tratar factores contribuyentes seleccionados y usar estrategias cognitivo-conductuales orientadas a atención, interpretación y respuesta al síntoma.

Frase medular: "Sensación de globus sin disfagia verdadera ni signos de alarma y con evaluación estructural negativa, compatible con trastorno funcional de

percepción faríngea; se propone manejo positivo y seguimiento, no una búsqueda indefinida de lesión oculta."

Viñeta 4. Infiltrados pulmonares y causalidad múltiple

Una persona mayor presenta insuficiencia respiratoria con infiltrados multifocales, derrame pequeño y signología obstructiva. Existe posibilidad de infección, congestión, aspiración y reacción inflamatoria farmacológica. Mejora con soporte, antibióticos, broncodilatación y ajuste terapéutico.

Hechos: insuficiencia respiratoria; hallazgos radiológicos mixtos; marcadores inflamatorios; respuesta bajo intervenciones simultáneas.

Inferencia: neumopatía multifactorial es una representación más fiel que atribuir todo a una causa. La mejoría no permite identificar qué intervención fue específica.

Incetidumbre: peso relativo de infección, inflamación y congestión; causalidad farmacológica; riesgo de recurrencia.

Decisión: completar una duración antibiótica proporcionada si la probabilidad inicial lo justifica, retirar la exposición sospechosa cuando el balance favorece hacerlo y documentar que la causalidad no está demostrada. El seguimiento debe buscar recurrencia tras reexposición y evolución radiológica.

Frase medular: "Insuficiencia respiratoria por neumopatía multifocal probablemente mixta, con componentes infeccioso-inflamatorio y posible contribución farmacológica; evolución favorable bajo medidas concomitantes, sin posibilidad de atribución causal única."

Viñeta 5. Tres de la mañana: decidir con el reloj en contra

Urgencias, 3:10. Hombre de 54 años, dolor torácico opresivo de 40 minutos, sudoroso, con antecedente de tabaquismo. Electrocardiograma: alteraciones inespecíficas de la repolarización. Primera troponina: pendiente. Hay otros nueve pacientes esperando y una sola reanimación disponible. No hay tiempo para la plantilla completa; hay tiempo para los sesenta segundos.

¿Qué vi y qué me contaron? Dolor opresivo con descarga adrenérgica, observado; ECG no diagnóstico pero anormal, medido ahora.

¿Qué creo y cuánto derecho tengo? Síndrome coronario agudo: posible-probable; el patrón clínico pesa más que el ECG inespecífico. No demostrado.

¿Qué me mataría al paciente si me equivoco? Tratarlo como "dolor inespecífico, espera troponina en sala" y que sea una oclusión en evolución. La incertidumbre peligrosa no es la etiqueta; es el tiempo.

¿Qué hago y qué me haría cambiar? Monitor, acceso, antiagregación según protocolo, ECG seriado en 15 minutos, troponina acelerada; escala a activación de hemodinamia si nuevo ECG cambia o el dolor persiste. Queda escrito: "SCA no demostrado; conducta por umbral dada gravedad del error de omisión".

Frase medular: "Dolor torácico de perfil isquémico con ECG no diagnóstico: se maneja como SCA probable por asimetría de consecuencias mientras la seriación confirma o degrada la hipótesis."

Lectura metacognitiva. La decisión correcta a las 3:10 no fue diagnóstica sino estratégica: comprar tiempo de vigilancia con intervenciones de bajo riesgo. El error clásico en este escenario no es intelectual, es logístico: la hipótesis correcta ("probable SCA") sin sistema de reevaluación (¿quién repite el ECG si la sala explota?). El criterio de reapertura con responsable es la mitad de la decisión.

Viñeta 6. La consulta ambulatoria y el chequeo reciente

Atención primaria. Mujer de 47 años consulta por fatiga de tres meses. Trae exámenes "normales de hace poco": hemograma y perfil realizados cinco meses atrás, cuando la fatiga no existía. Refiere además sudoración nocturna ocasional que atribuye a "premenopausia" y ha perdido "dos o tres kilos, por comer menos". Agenda llena, doce minutos por paciente.

Hechos: fatiga nueva de tres meses (relato consistente); exámenes normales previos al síntoma (dato real, pero anterior al problema); sudoración y baja de peso referidas con explicación alternativa plausible; examen físico de hoy sin adenopatías palpables ni visceromegalia (búsqueda dirigida, limitada por tiempo).

Inferencia: la mayoría de las fatigas en este contexto son benignas o funcionales: probable. Pero el conjunto fatiga + sudoración + baja de peso configura una tríada que no debe cerrarse contra exámenes previos al síntoma: los "normales de hace poco" no cubren el período de la enfermedad actual.

Incetidumbre: la peligrosa no es "¿qué causa la fatiga?" sino "¿hay un proceso sistémico en curso que estos doce minutos no pueden excluir?". Reducible con laboratorio actual dirigido y un control programado, no con más preguntas hoy.

Decisión: laboratorio actualizado (hemograma, VHS/PCR, TSH, glicemia, perfil hepático), control con resultados en dos semanas con la misma profesional, y safety-netting explícito por escrito: reconsultar antes si fiebre, adenopatías, dolor óseo o baja de peso mayor. No se tranquiliza con los exámenes viejos ni se alarma sin datos: se convierte el tiempo en prueba diagnóstica con red de seguridad.

Frase medular: "Fatiga de tres meses con sudoración y baja de peso leves; exámenes normales previos al inicio del cuadro no excluyen proceso actual: se actualiza estudio y se programa control con criterios explícitos de reconsulta."

Lectura metacognitiva. El riesgo ambulatorio típico es el cierre por evidencia caducada: "tiene exámenes normales" es un hecho cuya fecha lo vuelve casi irrelevante. La herramienta central de la atención primaria —el tiempo longitudinal— sólo funciona como prueba si tiene control programado y red de seguridad; sin ellos, es una espera que confía en la suerte.

Viñeta 7. Pronóstico incierto al final de la vida

Hombre de 78 años con cáncer de páncreas metastásico, en tercera línea de tratamiento, ingresa por deterioro funcional rápido y una neumonía. La familia pregunta cuánto tiempo queda; una hija pide "que se haga todo"; el equipo de oncología sugiere que "podría haber una ventana para otra línea". El paciente, lúcido a ratos, dice que está cansado.

Hechos: enfermedad oncológica avanzada en progresión bajo tratamiento (documentado); deterioro funcional acelerado en semanas (trayectoria observada por la familia y objetivable); infección aguda potencialmente reversible; voluntad expresada por el paciente en momentos de lucidez, consistente en dos conversaciones separadas.

Inferencia: la neumonía es tratable; la trayectoria de fondo es de final de vida próximo. Pronóstico en semanas a pocos meses: probable, con imprecisión irreductible en el caso individual. "Podría responder a otra línea" es una posibilidad no cuantificada, no una expectativa fundada en la evolución observada.

Incetidumbre: el plazo exacto es incognoscible; lo comunicable es la dirección de la trayectoria y los escenarios. La incertidumbre que domina no es pronóstica sino de metas: ¿qué quiere este hombre para el tiempo que queda? Esa no se resuelve con exámenes sino con conversación.

Decisión: tratar la neumonía con objetivo de confort y posible retorno a casa (intervención reversible, proporcionada); pausar la discusión de nueva línea hasta ver respuesta funcional; conversación estructurada de metas con paciente y familia: qué sabemos (la enfermedad progresa), qué creemos (el tiempo se mide probablemente en semanas a meses), qué no sabemos (el plazo exacto; si esta infección marcará un descenso definitivo), qué proponemos (priorizar lo que él declaró importante). Criterio de reevaluación: respuesta funcional a 72 horas.

Frase medular: "Neumonía potencialmente reversible sobre cáncer avanzado en progresión con deterioro funcional acelerado: se trata la parte reversible con metas de confort, se comunica la trayectoria sin fingir precisión de plazo, y las decisiones mayores se subordinan a las metas del paciente, no a la disponibilidad de otra línea."

Lectura metacognitiva. El final de la vida concentra todos los temas del libro: la tentación de responder "¿cuánto queda?" con una cifra falsa (certeza retórica), la de esconderse en "no se puede saber" (abandono), y la confusión entre lo técnicamente posible y lo indicado. Comunicar dirección y escenarios en vez de plazos, y anclar la decisión en las metas del enfermo, es la forma que toma aquí la incertidumbre bien gobernada.

Viñeta 8. Anatomía de un error consumado

Esta viñeta analiza un error completo, con la disciplina del capítulo 8: sin usar nombres de sesgos y sin dejar que el desenlace conocido juzgue lo que era razonable saber en cada momento.

El caso. Mujer de 82 años, traída de su casa por "compromiso del estado general". Nota de ingreso nocturno: "ITU en anciana, frecuente en ella según hija; orina de mal olor. Se inicia ceftriaxona". Día 2: "afebril, sigue decaída, ITU en tratamiento". Día 3: "evolución lenta, propia de la edad". Noche del día 3: hipotensión, abdomen agudo; laparotomía: colecistitis gangrenosa. Sobrevive tras UCI prolongada.

Reconstrucción por capas. **Hechos disponibles el día 1:** compromiso general inespecífico (relato); "ITU frecuente" (dato heredado de la hija, nunca verificado en registros); orina de mal olor (observación de baja especificidad); sin fiebre documentada; abdomen "blando" en un examen nocturno no dirigido; sin laboratorio hepático solicitado. **Inferencia del día 1:** "ITU" —formulada como hecho, no como hipótesis; fuerza real: posible, apoyada sobre todo en la frecuencia de la etiqueta en ancianas y en el dato heredado. **Incertidumbre nunca escrita:** ¿qué explica el compromiso general si la orina no lo explica? (una anciana decaída "por ITU" sin fiebre ni sepsis urinaria es una historia que se cuenta mejor de lo que se sostiene). **Decisión del día 1:** antibiótico razonable como apuesta empírica; el error no fue tratarla, fue tratarla *sin criterio de reapertura*: ninguna nota decía qué evolución obligaría a reexaminar.

Dónde estuvo la oportunidad. El día 2, "afebril pero sigue decaída" era una discordancia informativa: el tratamiento correcto de la hipótesis correcta debía producir mejoría del estado general, no sólo apirexia. La reinterpretación ("evolución lenta, propia de la edad") inmunizó la hipótesis justo cuando la evolución la estaba degradando. Un examen abdominal dirigido, un perfil hepático o la simple pregunta de pase de visita —"¿qué no explica la ITU?"— tenían, ese día, su máximo valor. El día 3 la pregunta ya era innecesaria: el abdomen la respondió solo.

Lo que no debe concluirse. El desenlace no demuestra que el equipo fuera incompetente, ni que toda "ITU en anciana" esconda una colecistitis. Con la información del día 1, la ITU era una apuesta empírica defendible. Lo indefendible era la arquitectura: un dato heredado con autoridad de hecho, una etiqueta que absorbió el caso, ninguna incertidumbre registrada, ninguna condición de reapertura. El mismo proceso, con desenlace benigno (una ITU real que respondía), habría dejado la misma vulnerabilidad instalada para la próxima paciente.

Frase medular (la que faltó el día 1): "Compromiso del estado general no explicado en mujer de 82 años; bacteriuria posible como causa, no demostrada —tratamiento empírico iniciado. El decaimiento no tiene aún explicación suficiente: reexaminar abdomen y ampliar estudio si no hay mejoría global en 48 horas."

Lectura metacognitiva. Nótese que la frase que faltó no requería más conocimiento médico, más tiempo ni más exámenes esa noche. Requería una disciplina de escritura: separar el hecho (decaimiento no explicado) de la inferencia (bacteriuria posible), conservar la incertidumbre (explicación insuficiente) y programar la revisión (48 horas, criterio global). Es la demostración más dura de la tesis de este libro: la epistemología de una frase puede ser la diferencia entre un susto y una laparotomía de madrugada.

Lo común a las ocho viñetas

En cada caso, la buena formulación evita dos extremos: describir sin interpretar o interpretar como si se hubiera observado directamente. El hecho guía la hipótesis; la incertidumbre modula su fuerza; la consecuencia define la decisión; la evolución conserva el derecho a corregir. Y en todas —de la urgencia de las 3:00 al final de la vida— la decisión termina con la misma cláusula: qué la haría cambiar, quién lo detectará y cuándo.

Capítulo 16**Enseñar y organizar la metacognición clínica**

Una jefa de servicio que quiera "instalar metacognición" en su equipo no puede indicarla como se indica un antibiótico. Puede, en cambio, cambiar tres cosas que ve todas las semanas: qué se pregunta en la ronda, qué estructura tiene la ficha y qué pasa después de un error. Este capítulo trata de esas palancas.

De la virtud individual al diseño institucional

La metacognición suele presentarse como una habilidad personal: el médico debe ser humilde, reflexivo y consciente de sus sesgos. Esa expectativa es insuficiente si el sistema oculta resultados, interrumpe el trabajo, fragmenta información y castiga la duda. La lucidez necesita infraestructura.

La National Academies recomendó educación diagnóstica, trabajo en equipo, tecnologías que apoyen el proceso y mecanismos de feedback y aprendizaje (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015). Una institución metacognitiva no sólo registra errores; hace visible cómo se piensa y crea momentos para revisar.

Enseñar representaciones, no sólo respuestas

En formación, pedir "el diagnóstico" prematuramente favorece la adivinación. Es más útil solicitar primero una representación del problema y preguntar qué datos fueron transformados en calificadores. Bowen y Eva han destacado la enseñanza explícita del razonamiento, mientras la teoría de illness scripts explica por qué el conocimiento debe organizarse alrededor de condiciones, mecanismos y consecuencias (Eva, 2005; Bowen, 2006).

El docente puede pedir al aprendiz que marque cada frase como hecho, inferencia o incertidumbre. Luego puede comparar la versión inicial con una formulación experta, no para imponer estilo, sino para mostrar qué relaciones fueron seleccionadas. El feedback debe ser específico: "presentaste la bacteriuria como infección", "omitiste que la imagen sólo excluye complicación actual", "tu plan no indica qué te haría cambiar". La devolución constructiva tiene técnica y tradición docente propia en nuestra lengua: describir conducta observable en lugar de juzgar a la persona, equilibrar lo logrado con lo corregible y terminar en un plan (Alves de Lima, 2008).

Un debate honesto: ¿se puede enseñar a pensar mejor?

Este libro toma posición en una controversia real de la educación médica, y conviene declararla. De un lado, Croskerry y su tradición sostienen que conocer los sesgos y entrenar estrategias de debiasing mejora el diagnóstico (Croskerry, 2003; Croskerry et al., 2013a, 2013b). Del otro, Norman, Monteiro y colegas han acumulado evidencia incómoda: la mayoría de los errores diagnósticos se asocia a déficits de conocimiento más que a fallas puras de proceso, los cursos de "pensamiento crítico" generalizable transfieren poco, y obligar a reflexionar

sistemáticamente sobre casos fáciles no mejora la precisión y consume tiempo (Norman et al., 2017; Monteiro & Norman, 2013; Monteiro et al., 2020).

La posición de este libro es intermedia, pero no equidistante. Con los escépticos: no existe una habilidad general de "pensar bien" que flote por encima del conocimiento; la representación rica del problema —illness scripts, experiencia con feedback— es la condición de todo lo demás, y ningún método, HII-D incluido, compensa no saber medicina. Contra el escepticismo total: de esa evidencia no se sigue que la única intervención posible sea enseñar más contenido. Lo que este libro propone no es vigilancia interna permanente ni listas universales —las versiones que la evidencia ha desinflado—, sino artefactos externos y selectivos: un lenguaje que obliga a graduar afirmaciones, una estructura de nota que conserva las capas, pausas activadas por disparadores definidos y circuitos de feedback que conviertan experiencia en calibración. Es una apuesta con compromisos observables (véase el capítulo 15): si estas herramientas no cambian conductas medibles, deben abandonarse como cualquier hipótesis mimada. Entre tanto, la controversia se enseña mejor de lo que se oculta: un residente que conoce el debate sabrá desconfiar por igual del catálogo de sesgos como solución universal y del nihilismo pedagógico como coartada.

Rondas y pases de turno

Una ronda puede incorporar una pausa breve en casos seleccionados:

- ¿cuál es la pregunta operativa de hoy?;
- ¿qué hecho nuevo cambió la representación?;
- ¿qué inferencia estamos tratando como si fuera dato?;
- ¿qué incertidumbre podría producir mayor daño?;
- ¿quién verificará el resultado pendiente?

El pase de turno debe transmitir tareas epistémicas, no sólo tratamientos. "Pendiente observar si..." y "si ocurre X, reabrir Y" son componentes de seguridad.

Conferencias de aprendizaje

La morbilidad tradicional puede centrarse en quién se equivocó o en una secuencia factual sin análisis cognitivo. Una revisión más útil reconstruye la evolución de la representación: qué se pensó en cada punto, qué señales estaban disponibles, qué información faltó, qué condiciones favorecieron la inercia y qué barrera podría permitir corrección futura. La viñeta 8 del cuaderno de casos es un ejemplo del formato: capas, oportunidades y barreras, sin moralismo retrospectivo.

Debe evitarse el hindsight bias. El desenlace no convierte automáticamente en obvia una alternativa que tenía baja probabilidad inicial. El aprendizaje surge al identificar oportunidades razonables de actualización, no al exigir omnisciencia retrospectiva.

Feedback diagnóstico

Los médicos necesitan saber qué ocurrió con pacientes derivados, dados de alta o transferidos. Sistemas simples pueden devolver diagnósticos finales, resultados discrepantes, reconsultas y cambios terapéuticos. La calibración requiere series, no recuerdos aislados.

Un portafolio privado puede registrar: hipótesis principal, confianza aproximada, alternativa relevante, desenlace y aprendizaje. No busca puntuar moralmente; busca detectar patrones: exceso de confianza en un dominio, subestimación de recurrencias, tendencia a tratar cultivos sin síndrome o dificultad para reconocer diagnósticos funcionales. El Taller 5 de este libro es su versión mínima. El portafolio como instrumento docente tiene además desarrollo propio en la educación médica latinoamericana, incluida la validación en español de instrumentos para evaluar su uso (Riquelme et al., 2011).

Lenguaje institucional

Las plantillas de ficha pueden apoyar o degradar el pensamiento. Campos obligatorios interminables producen copia; campos demasiado libres ocultan información crítica. Una plantilla equilibrada incluye problema, hechos nuevos, evaluación con grado de certeza, plan y criterios de reevaluación. La tecnología debería facilitar comparación temporal y procedencia de datos, no sólo acumular texto.

La cultura importa. Un residente debe poder decir "no entiendo este dato" sin perder legitimidad; una enfermera debe poder señalar que la evolución no coincide con el diagnóstico; un especialista debe explicitar límites; un jefe debe corregirse en público. La revisabilidad se aprende por modelamiento.

Evaluar el razonamiento, no sólo la respuesta

La educación clínica suele premiar el diagnóstico correcto, aunque haya sido obtenido por un proceso frágil, y castigar el diagnóstico incorrecto incluso cuando la incertidumbre estaba bien calibrada. Este patrón enseña a ocultar dudas y reconstruir narrativas retrospectivas. Una evaluación metacognitiva debe observar también representación del problema, calidad de alternativas, uso de evidencia contradictoria, confianza y plan de revisión.

Los docentes pueden pedir al aprendiz que marque cada afirmación como hecho, inferencia o incertidumbre; que identifique el dato de mayor peso; que señale qué cambio modificaría la conducta; y que estime su confianza antes de conocer la respuesta. El objetivo no es ralentizar todas las decisiones, sino construir un repertorio de pausas transferibles a casos reales.

Las instituciones aprenden cuando conservan no sólo resultados, sino trayectorias de decisión. Auditorías, reuniones clínicas y sistemas de reporte deberían reconstruir qué información estaba disponible en cada momento y cómo circuló. Esa memoria protege contra el sesgo retrospectivo y permite transformar errores en cambios concretos de representación, coordinación o umbral.

Una competencia profesional

La metacognición no reemplaza conocimiento, técnica ni ética. Los coordina. Puede enseñarse mediante casos contrastados, reflexión estructurada, práctica deliberada y feedback, pero no como asignatura aislada de la clínica (Sandars, 2009; Schmidt & Mamede, 2015).

Una organización clínica aprende cuando convierte las discrepancias entre lo pensado y lo ocurrido en información accesible, no en culpa silenciosa ni en relato retrospectivo perfecto.

La medicina del futuro necesitará profesionales capaces de trabajar con información creciente, equipos complejos e inteligencia artificial. La competencia decisiva no será sólo producir más respuestas, sino reconocer qué tipo de respuesta se está produciendo y qué evidencia le da derecho a orientar una acción.

Enseñar metacognición es enseñar una relación con el conocimiento: suficiente confianza para actuar, suficiente humildad para revisar y suficiente precisión para explicar por qué.

En una frase. La metacognición clínica se enseña con representaciones y feedback, y se organiza con rondas, fichas y revisiones diseñadas para hacer visible el pensamiento — no se decreta.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. La última vez que enseñé un caso, ¿pedí el diagnóstico o pedí primero la representación del problema?
2. ¿Qué pasó con el último paciente que derivé o di de alta con diagnóstico incierto — y cómo podría enterarme sistemáticamente?
3. Si mañana dirigiera mi servicio, ¿cuál de las tres palancas (ronda, ficha, revisión de errores) cambiaría primero, y qué costaría?

Conclusión. Una medicina lúcida

La medicina habita una tensión permanente. Debe conocer con rigor y actuar antes de que el conocimiento esté completo. Su lenguaje intenta fijar un fenómeno que continúa evolucionando; sus decisiones cambian aquello que luego será observado; sus categorías científicas se aplican a personas que nunca son idénticas a una población de estudio.

Esta tensión no es un defecto que pueda eliminarse mediante mayor seguridad retórica. Es la estructura del trabajo clínico. Los hechos llegan incompletos y situados. Las inferencias organizan su significado, pero tienen grados. La incertidumbre puede reducirse, clasificarse o tolerarse; no siempre desaparece. La decisión incorpora probabilidad y, además, consecuencias, tiempo, reversibilidad, valores y capacidad de vigilancia.

La metacognición permite sostener estas capas sin confundirlas. No ofrece una conciencia transparente de la propia mente. Ofrece una práctica de monitoreo y regulación: detectar conflicto, calibrar confianza, buscar feedback, cambiar de modo de pensamiento y diseñar criterios de revisión. Su virtud no es hacer al médico permanentemente dubitativo, sino permitirle ser categórico cuando la evidencia lo justifica y prudente cuando no.

El lenguaje clínico es uno de sus instrumentos más poderosos. La frase medular no es la más breve ni la más elegante. Es aquella que conserva la estructura decisiva del evento, distingue dato y explicación, expresa el grado de certeza y muestra por qué una conducta es razonable. Una frase así puede orientar a un equipo, proteger contra la inercia y mantener abierta la posibilidad de corrección. La historia de Carmen, que acompañó todo este libro, empezó con la frase contraria —"cuadro habitual, manejo habitual"— y terminó con una frase que cargaba, palabra por palabra, el trabajo de distinguir, graduar, dudar y decidir. Entre ambas frases no cambió la medicina disponible; cambió la epistemología con que se usó.

La inteligencia artificial vuelve esta exigencia aún más visible. La plausibilidad verbal puede separarse de la verdad. Por ello, tanto ante una respuesta automática como ante nuestra propia narrativa, debemos preguntar qué proviene del caso, qué fue inferido, qué permanece incierto y qué responsabilidad implica actuar.

HII-D resume una disciplina posible:

- **Hechos:** observar con procedencia y límites.
- **Inferencias:** explicar con fuerza proporcional.
- **Incetidumbre:** nombrar lo que puede cambiar el modelo o la conducta.
- **Decisión:** actuar por umbrales y consecuencias, no por necesidad de certeza.
- **Reevaluación:** devolver al mundo la capacidad de corregirnos.

Esta secuencia no promete infalibilidad. Promete algo más realista: errores más visibles, dudas mejor formuladas, decisiones más trazables y aprendizaje más probable.

La lucidez clínica no consiste en ver la verdad completa. Consiste en no atribuir a nuestra representación más certeza de la que los hechos permiten, sin usar esa limitación como excusa para dejar de decidir.

Una medicina científicamente seria y humanamente responsable no es la que nunca duda. Es la que sabe qué hacer con su duda.

Una disciplina cotidiana

La epistemología clínica puede parecer abstracta hasta que se traduce en hábitos: verificar la fuente del dato decisivo; reformular una etiqueta como una proposición; nombrar la principal explicación rival; separar la gravedad de la probabilidad; registrar qué hará cambiar la conducta; y revisar después si la confianza estuvo bien calibrada. Ningún hábito elimina el error. Juntos construyen condiciones para reconocerlo antes y aprender de él después.

La medicina necesita afirmaciones suficientemente firmes para coordinar acciones y suficientemente abiertas para admitir corrección. Esa doble exigencia no es una contradicción que deba resolverse eligiendo seguridad o duda. Es la forma propia del juicio clínico. La frase medular es valiosa porque condensa esa arquitectura: conserva el hecho, gradúa la inferencia, localiza la incertidumbre y hace visible la decisión.

El ideal no es un médico que nunca se equivoca, sino uno cuyo razonamiento puede ser comprendido, discutido y revisado. Tampoco es un sistema que acumula datos, sino uno que preserva significado y distribuye oportunidades de corrección. La lucidez no se demuestra mediante tono categórico. Se demuestra en la correspondencia entre lo que se afirma, lo que se sabe y lo que se hace.

Apéndice A. Hoja HII-D para discusión de casos

Pregunta operativa

¿Qué decisión concreta debe resolverse ahora?

H — Hechos decisivos

- Fuente y fecha de cada dato.
- Tendencia temporal.
- Hallazgos positivos y negativos.
- Datos no evaluados o no disponibles.
- Confiabilidad y límites del método.

I — Inferencia principal

- Representación del problema en una frase.
- Grado de certeza: demostrado / altamente probable / probable / posible / no sustentado.
- Mecanismo causal propuesto y qué parte no fue observada.
- Evidencia convergente y dato discordante.

I — Incertidumbre

- Alternativa que cambiaría la conducta.
- Duda reducible con examen.
- Duda dependiente de evolución.
- Duda irreducible o no relevante para la decisión inmediata.
- Error de mayor consecuencia.

D — Decisión

- Conducta elegida.
- Por qué el beneficio esperado supera al de las alternativas.
- Urgencia, reversibilidad y capacidad de vigilancia.
- Preferencias del paciente.

Reevaluación

- Resultado pendiente.
- Plazo.
- Cambio clínico que obliga a reabrir el caso.
- Responsable de verificar y comunicar.

Frase medular final

Una o dos frases que expresen la naturaleza del evento, el grado de inferencia, la incertidumbre crítica y el efecto sobre la conducta.

Versión de 60 segundos (para casos de rutina o alta presión de tiempo)

1. ¿Qué vi y qué me contaron? (un hecho decisivo, con fuente)
2. ¿Qué creo y cuánto derecho tengo a creerlo? (inferencia con grado)
3. ¿Qué le haría daño al paciente si estoy equivocado? (la incertidumbre peligrosa)
4. ¿Qué hago y qué me haría cambiar antes del próximo control? (decisión con reapertura)

Apéndice B. Léxico de certeza y pausa diagnóstica

Léxico de certeza, con usos correctos e incorrectos

Término	Significa	Uso correcto	Uso incorrecto típico
Demostrado / documentado	Evidencia directa pertinente y suficiente	"Bacteriemia por E. coli documentada (2/2 hemocultivos)"	"Neumonía aspirativa documentada" (nadie presenció aspiración; la imagen no distingue mecanismo)
Altamente probable	Convergencia fuerte; alternativas relevantes poco plausibles	"Foco abdominal altamente probable: secuencia temporal, microbiología y ausencia de foco alternativo"	Usarlo como cortesía retórica para una hipótesis única no contrastada
Probable	Explicación principal con soporte significativo, no concluyente	"CAUTI probable si aparece fiebre sin otro foco"	"Probable" para rellenar donde falta la explicación ("dolor probablemente multifactorial")
Compatible con	Los hallazgos encajan; no expresa por sí solo probabilidad alta	"Imagen compatible con neumonía; también con congestión"	Leer "compatible con X" como "es X" en la nota siguiente
Posible	Merece consideración; soporte limitado o inespecífico	"Contribución farmacológica posible; se retira exposición"	Listas de "posibles" sin consecuencia para estudio ni vigilancia
No demostrado	Hipótesis razonable sin evidencia suficiente para afirmarla	"Estrangulación no demostrada en imagen ni cirugía"	Confundirlo con "descartado" (ausencia de prueba $\neq$ prueba de ausencia)
Sin evidencia actual de	El método empleado no mostró el fenómeno en ese momento	"Sin evidencia actual de isquemia en TAC"	"Sin evidencia de isquemia" citado días después como "isquemia descartada"
No evaluable	Las condiciones no permiten determinar presencia o ausencia	"Síntomas urinarios no evaluables por lesión medular"	Registrar "niega disuria" en paciente que no puede percibirla
Menos probable	Existe evidencia contraria o una explicación superior, sin exclusión	"TEP menos probable tras Doppler y dímero; no excluido"	Omitir qué evidencia lo degradó (queda como opinión)
Se descarta	El método y el contexto realmente permiten excluir	"Se descarta embarazo (β -hCG negativa)"	"Se descarta abdomen agudo" tras un examen único en evolución temprana
Probabilidad suficientemente baja para no tratar/testear	Decisión por umbral, no exclusión ontológica	"Probabilidad de SCA suficientemente baja para alta con control en 72 h"	Presentarla al paciente como "usted no tiene nada"

Doce preguntas para una pausa diagnóstica

1. ¿Puedo describir el caso sin usar el diagnóstico actual?
2. ¿Qué dato sostiene más mi conclusión?
3. ¿Ese dato es específico o sólo compatible?
4. ¿Qué hallazgo no encaja?
5. ¿Qué información estoy suponiendo que fue verificada?
6. ¿Qué alternativa cambiaría la conducta inmediata?
7. ¿Estoy usando la respuesta al tratamiento como prueba causal demasiado fuerte?
8. ¿La gravedad es coherente con mi explicación?
9. ¿Existe reconsulta, recurrencia o evolución inesperada?
10. ¿Mi confianza proviene de evidencia o de familiaridad y fluidez?
11. ¿Cuál es el costo de esperar y cuál el costo de actuar?
12. ¿Qué evento obligará a revisar la decisión y quién lo detectará?

Apéndice C. Guía de implementación en un servicio clínico

Esta guía condensa el capítulo 16 en un plan concreto para un servicio que quiera adoptar el lenguaje y las prácticas del libro. Está pensada para un jefe de servicio, un programa de residencia o un grupo de clínicos con voluntad y poco tiempo. Tres advertencias previas: nada de esto está validado como tecnología (véase el capítulo 15, "Límites"); todo debe adaptarse al contexto local; y la palanca más barata —cómo se habla en la ronda— es también la más poderosa.

Semana 1-2: instalar el lenguaje

- Presentar el léxico de certeza (Apéndice B) en reunión clínica, con los ejemplos de uso incorrecto. Imprimirlo y dejarlo visible donde se escribe: junto a las estaciones de trabajo, no en un mural decorativo.
- Acordar tres reglas mínimas de escritura, no negociables y auditables: (1) "se descarta" sólo con método que excluya; (2) todo hallazgo negativo con su límite ("sin evidencia de X en Y"); (3) toda decisión relevante con criterio de reapertura ("reevaluar si...").
- No pedir todavía cambios de estructura en las notas. El vocabulario primero; la arquitectura después.

Semana 3-4: la pausa en la ronda

- Elegir un disparador objetivo para la pausa diagnóstica (no "cuando haya tiempo"): reconsulta, evolución discordante con el diagnóstico, traslado recibido de otro equipo, o caso sin discusión hace 72 horas.
- Cuando se active, usar las cuatro preguntas de la versión de 60 segundos en voz alta. Duración objetivo: dos minutos por caso. El jefe de ronda modela; no interroga.
- Pase de turno: agregar una línea obligatoria por paciente inestable o incierto: "qué vigilar, qué reabrirla el caso, quién verifica el pendiente".

Mes 2: la ficha

- Introducir la plantilla condensada HII-D (Apéndice A) para tres situaciones definidas: ingresos complejos, cambios de conducta mayores y altas con diagnóstico incierto. No para toda evolución diaria: la plantilla universal muere por fatiga.
- Prohibición práctica del fósil: cada evolución debe contener al menos una línea que responda "¿qué cambió desde ayer?" (en hechos, interpretación, incertidumbre o plan). Si nada cambió, escribirlo es información.
- Revisar las plantillas electrónicas existentes: eliminar campos que inducen copia, agregar un campo breve de "criterio de reevaluación".

Mes 3 en adelante: el circuito de aprendizaje

- Reformatear una reunión de morbilidad al formato de la viñeta 8: reconstrucción por capas, con la información disponible en cada momento, sin nombres de sesgos como conclusión y con una barrera concreta como producto de cada sesión.
- Ofrecer (voluntario, privado) el portafolio de calibración del Taller 5: hipótesis, confianza, alternativa, desenlace. Quien lo lleve tres meses tendrá el primer dato real sobre su propia calibración.
- Cerrar el circuito de feedback más barato disponible: una vía sistemática para enterarse del desenlace de derivaciones y altas inciertas (interconsulta con respuesta obligatoria, revisión quincenal de reconsultas a urgencias).

Barreras esperables y respuestas

- **"No hay tiempo."** La versión de 60 segundos existe para eso; la pausa es selectiva por disparador, no universal. El tiempo que consume se compara con el que consume un solo cierre prematuro no detectado.
- **"Esto burocratiza."** La plantilla se usa en tres situaciones, no en todas. La regla es proporcionalidad: una línea para lo rutinario, estructura para lo grave, incierto o irreversible.
- **"La ficha electrónica no lo permite."** El léxico y la pausa no requieren software. La plantilla cabe en texto libre.
- **"El equipo no va a exponer sus dudas."** La seguridad psicológica se modela desde arriba: el primer "no lo sé, y esto es lo que haremos para saberlo" tiene que decirlo la jefatura.

Qué medir (sin inflar métricas)

Tres indicadores simples, auditables sobre una muestra mensual de fichas: proporción de "se descarta" usados con método excluyente; proporción de decisiones mayores con criterio de reapertura explícito; proporción de altas inciertas con instrucciones de consulta específicas. No miden pensamiento; miden las huellas que el pensamiento deja. Su valor es la tendencia, no la cifra.

Glosario

Abducción. Inferencia que propone la hipótesis que, de ser verdadera, volvería esperable lo observado. Descrita por Peirce (que la llamó primero "hipótesis"). Es el movimiento típico de la generación diagnóstica.

Anclaje. Persistencia de una hipótesis inicial que conserva autoridad aun cuando la evidencia acumulada la ha degradado.

Calibración. Correspondencia entre la confianza declarada y la proporción real de aciertos, evaluada sobre una serie de juicios.

Cierre prematuro. Aceptación de un diagnóstico antes de haberlo verificado suficientemente, con suspensión de la búsqueda de alternativas.

Cognición distribuida. Marco que estudia cómo el procesamiento de información se realiza a través de personas y artefactos coordinados, no sólo dentro de mentes individuales (Hutchins).

Conocimiento tácito. Capacidad de reconocer o ejecutar más de lo que puede formularse explícitamente (Polanyi).

Contrafactual. Escenario comparativo implícito en toda afirmación causal: qué habría ocurrido sin la exposición o la intervención.

Decisión compartida. Proceso de deliberación entre profesional y paciente sobre opciones, evidencia y preferencias, distinto de la mera entrega de información (Elwyn).

Densidad epistémica. Propiedad de una formulación clínica que conserva los ejes que cambian la interpretación (tiempo, severidad, mecanismo, evidencia contraria, consecuencia) en lugar de sólo abreviar.

Doble proceso. Familia de teorías que distingue procesamiento rápido, asociativo y automático de procesamiento lento, analítico y controlado; ambos pueden acertar o errar.

Encapsulación. Compresión del conocimiento biomédico en conceptos clínicos de nivel superior, característica del desarrollo de la pericia (Schmidt y Rikers).

Frase medular. Formulación breve que condensa la naturaleza del evento, el elemento que cambia el riesgo, el límite principal de certeza y su efecto sobre la conducta.

Frecuencias naturales. Presentación de probabilidades como conteos sobre una población de referencia ("90 de cada 270 positivos"), que facilita el razonamiento bayesiano intuitivo (Gigerenzer).

Hindsight bias (sesgo retrospectivo). Tendencia a percibir un desenlace conocido como si hubiera sido predecible, contaminando la evaluación de decisiones pasadas.

HII-D. Heurística de escritura y deliberación que ordena el razonamiento en Hechos, Inferencias, Incertidumbre y Decisión, más un movimiento transversal de reevaluación. No validada como instrumento.

Illness script. Estructura de conocimiento que integra condiciones predisponentes, mecanismo fisiopatológico y consecuencias clínicas de una enfermedad, y permite el reconocimiento rápido de patrones.

Incertidumbre aleatoria. La que proviene de variabilidad o contingencia que persiste aun con conocimiento completo del sistema.

Incertidumbre epistémica. La que proviene de conocimiento insuficiente y puede, en principio, reducirse con información.

Injusticia epistémica. Daño cometido contra alguien en su capacidad de sujeto de conocimiento: testimonial (credibilidad rebajada por prejuicio) o hermenéutica (falta de categorías para expresar la experiencia) (Fricker).

Metacognición. Conocimiento y regulación de los propios procesos cognitivos: monitorear la comprensión, valorar la confianza, decidir cambiar de estrategia (Flavell; Nelson y Narens).

Meta-d' / M-ratio. Medida de sensibilidad metacognitiva basada en teoría de detección de señales: expresa cuánta de la información disponible para la decisión aprovecha el observador al evaluar sus propias respuestas; el cociente meta-d'/d' (M-ratio) permite comparar entre personas y tareas (Maniscalco y Lau).

Modalidad epistémica. Recursos del lenguaje que expresan el grado de certeza de una afirmación ("demostrado", "probable", "sin evidencia de").

Phronesis. Prudencia práctica aristotélica: la capacidad de deliberar bien sobre lo que conviene hacer en una situación particular.

Probabilidad pretest / postest. Probabilidad de una condición antes y después de incorporar el resultado de una prueba; su relación depende del rendimiento de la prueba y de la prevalencia.

Representación del problema. Formulación compacta que transforma los datos del caso en relaciones clínicamente significativas mediante calificadores semánticos.

Riesgo inductivo. Tesis de que aceptar o rechazar una hipótesis exige decidir cuánta evidencia es suficiente, y de que esa decisión depende del costo de cada error posible; fundamenta filosóficamente los umbrales de decisión clínica (Rudner; Douglas).

Safety-netting (red de seguridad). Instrucciones explícitas de reconsulta y vigilancia que acompañan una decisión tomada bajo incertidumbre, especialmente en ambulatorio.

Sensibilidad metacognitiva. Capacidad de discriminar los propios aciertos de los propios errores mediante la confianza; distinta del sesgo metacognitivo (tendencia global a confiar mucho o poco).

Testimonio (epistemología del). Estudio del conocimiento obtenido mediante informes de otros. Coady defendió la confianza por defecto como condición de todo conocimiento compartido; Lackey añadió la vigilancia activa del oyente. La anamnesis es su caso clínico paradigmático.

Umbral de decisión. Nivel de probabilidad sobre el cual una conducta (testear, tratar) supera a sus alternativas, dado el balance de daños y beneficios (Pauker y Kassirer).

Validez externa / transportabilidad. Grado en que un resultado de investigación puede aplicarse fuera del contexto en que fue producido; no es propiedad binaria del estudio sino relación entre evidencia y uso propuesto.

Índice analítico

Los números remiten a capítulos (Int = introducción, Interludios I-III, CC = cuaderno de casos, C = conclusión, Ap = apéndices).

- Abducción — 2
- Anclaje — 7, 10, CC (viñeta 8)
- Ausencia de evidencia / evidencia de ausencia — 1, 4, Ap B
- Autoridad revisable — 7, 12, 14
- Calibración — 5, 15, 16, Ap C
- Carga teórica de la observación — 1
- Cierre prematuro — 7, CC (viñeta 8)
- Cognición distribuida — 12
- Comunicación de incertidumbre — 12, 14, CC (viñeta 7)
- Conocimiento tácito — 6
- Contrafactuales — 10
- Copiado de notas (fósil narrativo) — 11, Ap C
- Debate sobre la enseñanza del razonamiento (Croskerry vs. Norman/Monteiro) — 16
- Decisión compartida — 12, 14, Interludio III
- Densidad epistémica — 4
- Desaceleración selectiva — 8, Interludio II
- Desacuerdo clínico — 12, Interludio III
- Doble proceso — 6
- Errores asimétricos — 9, CC (viñeta 5)
- Falsabilidad del método HII-D — 15
- Evidencia poblacional y particularización — 9
- Feedback diagnóstico — 5, 16, Ap C
- Ficha como dispositivo que produce lo visible (Foucault) — 11
- Fichas clínicas y plantillas — 11, 16, Ap C
- Frase medular — 4, 11, C, CC (todas las viñetas)
- Frecuencias naturales — 2, 9, 12
- Grados de facticidad — 1
- Hindsight bias — 8, 10, 16, CC (viñeta 8)
- HII-D (método) — 11, 15, Ap A; auditoría de IA con — 13

- Illness scripts — 2, 6, 16
- Incertidumbre: taxonomía y cartografía — 3; epistémica y aleatoria — 3; knightiana — 3
- Injusticia epistémica — 14
- Intuición experta — 5, 6, Interludio II
- Léxico de certeza — 4, Ap B
- Marcador y enfermedad (lactato, perfusión, ANDROMEDA-SHOCK) — 1
- Medicina basada en evidencia — 9
- Metacognición: definición y niveles — Int, 5; sensibilidad vs. sesgo — Int, 5; artificial — 13
- Meta-d' y medición de la metacognición — 5
- Observación activa — 9, 10
- Pausa diagnóstica — 8, 16, Ap B, Ap C
- Pericia y práctica deliberada — 6
- Phronesis — 6, 14
- Pronóstico e incertidumbre de plazo — CC (viñeta 7)
- Pruebas severas (Popper) — 2
- Puntos de inflexión — 10, Interludio III
- Representación del problema — Int, 2, 8, 16
- Riesgo inductivo (Rudner, Douglas) — 9
- Safety-netting — 10, CC (viñetas 5 y 6)
- Sesgos cognitivos: alcance y límites del vocabulario — 7
- Sobreconfianza — 5, 7
- Sobreestudio e intervenciones innecesarias — 3
- Testimonio del paciente — 1, 14; epistemología del testimonio (Coady, Lackey) — 14
- Trayectoria y temporalidad — 10, Interludio I
- Umbrales de decisión — 9, Interludio III, CC (viñeta 5)
- Verbos epistémicos — 4, Ap B

Referencias

- Alves de Lima, A. (2008). Devolución constructiva: Una estrategia para mejorar el aprendizaje. *Medicina (Buenos Aires)*, 68(1), 88-92.
- Aristotle. (2009). *The Nicomachean Ethics* (D. Ross, Trans.; L. Brown, Rev.). Oxford University Press.
- Barrows, H. S., & Feltovich, P. J. (1987). The clinical reasoning process. *Medical Education*, 21(2), 86-91.
- Berner, E. S., & Graber, M. L. (2008). Overconfidence as a cause of diagnostic error in medicine. *The American Journal of Medicine*, 121(5 Suppl), S2-S23.
- Bordage, G. (1994). Elaborated knowledge: A key to successful diagnostic thinking. *Academic Medicine*, 69(11), 883-885.
- Bowen, J. L. (2006). Educational strategies to promote clinical diagnostic reasoning. *New England Journal of Medicine*, 355(21), 2217-2225.
- Cabitza, F., Rasoini, R., & Gensini, G. F. (2017). Unintended consequences of machine learning in medicine. *JAMA*, 318(6), 517-518.
- Canguilhem, G. (1991). *The Normal and the Pathological*. Zone Books.
- Carel, H., & Kidd, I. J. (2014). Epistemic injustice in healthcare: A philosophical analysis. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 17(4), 529-540.
- Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). *Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better*. Oxford University Press.
- Charlin, B., Boshuizen, H. P. A., Custers, E. J. F. M., & Feltovich, P. J. (2007). Scripts and medical diagnostic knowledge: Theory and applications for clinical reasoning instruction and research. *Academic Medicine*, 82(10), 967-974.
- Charon, R. (2006). *Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness*. Oxford University Press.
- Coady, C. A. J. (1992). *Testimony: A Philosophical Study*. Clarendon Press.
- Croskerry, P. (2003). The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. *Academic Medicine*, 78(8), 775-780.
- Croskerry, P. (2009). A universal model of diagnostic reasoning. *Academic Medicine*, 84(8), 1022-1028.
- Croskerry, P., Singhal, G., & Mamede, S. (2013a). Cognitive debiasing 1: Origins of bias and theory of debiasing. *BMJ Quality & Safety*, 22(Suppl 2), ii58-ii64.
- Croskerry, P., Singhal, G., & Mamede, S. (2013b). Cognitive debiasing 2: Impediments to and strategies for change. *BMJ Quality & Safety*, 22(Suppl 2), ii65-ii72.
- Custers, E. J. F. M. (2015). Thirty years of illness scripts: Theoretical origins and practical applications. *Medical Teacher*, 37(5), 457-462.

- Djulbegovic, B., & Guyatt, G. H. (2017). Progress in evidence-based medicine: A quarter century on. *The Lancet*, 390(10092), 415–423.
- Douglas, H. (2000). Inductive risk and values in science. *Philosophy of Science*, 67(4), 559–579.
- Dunlosky, J., & Metcalfe, J. (2009). *Metacognition*. SAGE.
- Elstein, A. S., Shulman, L. S., & Sprafka, S. A. (1978). *Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning*. Harvard University Press.
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367.
- Epstein, R. M. (1999). Mindful practice. *JAMA*, 282(9), 833–839.
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363–406.
- Eva, K. W. (2005). What every teacher needs to know about clinical reasoning. *Medical Education*, 39(1), 98–106.
- Eva, K. W., & Regehr, G. (2005). Self-assessment in the health professions: A reformulation and research agenda. *Academic Medicine*, 80(10 Suppl), S46–S54.
- Evans, J. St. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on Psychological Science*, 8(3), 223–241.
- Feinstein, A. R. (1967). *Clinical Judgment*. Williams & Wilkins.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
- Fleming, S. M. (2021). *Know Thyself: The Science of Self-Awareness*. Basic Books.
- Fleming, S. M., & Dolan, R. J. (2012). The neural basis of metacognitive ability. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 367(1594), 1338–1349.
- Fleming, S. M., & Lau, H. C. (2014). How to measure metacognition. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 443.
- Foucault, M. (1973). *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Vintage Books.
- Fox, R. C. (1980). The evolution of medical uncertainty. *Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society*, 58(1), 1–49.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.
- Gadamer, H.-G. (1996). *The Enigma of Health: The Art of Healing in a Scientific Age* (J. Gaiger & N. Walker, Trans.). Stanford University Press.
- Gérvás, J., & Pérez Fernández, M. (2013). *Sano y salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias)*. Los Libros del Lince.

- Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic decision making. *Annual Review of Psychology*, 62, 451–482.
- Gigerenzer, G., Gaissmaier, W., Kurz-Milcke, E., Schwartz, L. M., & Woloshin, S. (2007). Helping doctors and patients make sense of health statistics. *Psychological Science in the Public Interest*, 8(2), 53–96.
- Graber, M. L., Franklin, N., & Gordon, R. (2005). Diagnostic error in internal medicine. *Archives of Internal Medicine*, 165(13), 1493–1499.
- Graber, M. L., Kissam, S., Payne, V. L., Meyer, A. N. D., Sorensen, A., Lenfestey, N., et al. (2012). Cognitive interventions to reduce diagnostic error: A narrative review. *BMJ Quality & Safety*, 21(7), 535–557.
- Groopman, J. (2007). *How Doctors Think*. Houghton Mifflin.
- Greenhalgh, T., & Hurwitz, B. (Eds.). (1998). *Narrative Based Medicine: Dialogue and Discourse in Clinical Practice*. BMJ Books.
- Greenhalgh, T., Howick, J., & Maskrey, N. (2014). Evidence based medicine: A movement in crisis? *BMJ*, 348, g3725.
- Han, P. K. J., Klein, W. M. P., & Arora, N. K. (2011). Varieties of uncertainty in health care: A conceptual taxonomy. *Medical Decision Making*, 31(6), 828–838.
- Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall/CRC.
- Hernández, G., Ospina-Tascón, G. A., Damiani, L. P., Estenssoro, E., Dubin, A., Hurtado, J., et al. (2019). Effect of a resuscitation strategy targeting peripheral perfusion status vs serum lactate levels on 28-day mortality among patients with septic shock: The ANDROMEDA-SHOCK randomized clinical trial. *JAMA*, 321(7), 654–664.
- Hoffrage, U., & Gigerenzer, G. (1998). Using natural frequencies to improve diagnostic inferences. *Academic Medicine*, 73(5), 538–540.
- Hunter, K. M. (1991). *Doctors' Stories: The Narrative Structure of Medical Knowledge*. Princeton University Press.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.
- Hyland, K. (1998). *Hedging in Scientific Research Articles*. John Benjamins.
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248.
- Kadavath, S., Conerly, T., Askill, A., Henighan, T., Drain, D., Perez, E., et al. (2022). Language models (mostly) know what they know. *arXiv preprint*, arXiv:2207.05221.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kassirer, J. P. (1989). Our stubborn quest for diagnostic certainty. *New England Journal of Medicine*, 320(22), 1489–1491.

- Kidd, I. J., & Carel, H. (2017). Epistemic injustice and illness. *Journal of Applied Philosophy*, 34(2), 172-190.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Houghton Mifflin.
- Koriat, A. (1997). Monitoring one's own knowledge during study: A cue-utilization approach to judgments of learning. *Journal of Experimental Psychology: General*, 126(4), 349-370.
- Lackey, J. (2008). *Learning from Words: Testimony as a Source of Knowledge*. Oxford University Press.
- Lambe, K. A., O'Reilly, G., Kelly, B. D., & Curristan, S. (2016). Dual-process cognitive interventions to enhance diagnostic reasoning: A systematic review. *BMJ Quality & Safety*, 25(10), 808-820.
- Lee, P., Bubeck, S., & Petro, J. (2023). Benefits, limits, and risks of GPT-4 as an AI chatbot for medicine. *New England Journal of Medicine*, 388, 1233-1239.
- Lifshitz, A. (2014). *La nueva clínica*. Academia Nacional de Medicina de México.
- Mamede, S., Schmidt, H. G., & Penaforte, J. C. (2008). Effects of reflective practice on the accuracy of medical diagnoses. *Medical Education*, 42(5), 468-475.
- Mamede, S., van Gog, T., van den Berge, K., Rikers, R. M. J. P., van Saase, J. L. C. M., van Guldener, C., & Schmidt, H. G. (2010). Effect of availability bias and reflective reasoning on diagnostic accuracy among internal medicine residents. *JAMA*, 304(11), 1198-1203.
- Maniscalco, B., & Lau, H. (2012). A signal detection theoretic approach for estimating metacognitive sensitivity from confidence ratings. *Consciousness and Cognition*, 21(1), 422-430.
- Mann, K., Gordon, J., & MacLeod, A. (2009). Reflection and reflective practice in health professions education: A systematic review. *Advances in Health Sciences Education*, 14(4), 595-621.
- Meyer, A. N. D., Payne, V. L., Meeks, D. W., Rao, R., & Singh, H. (2013). Physicians' diagnostic accuracy, confidence, and resource requests: A vignette study. *JAMA Internal Medicine*, 173(21), 1952-1958.
- Monteiro, S., & Norman, G. (2013). Diagnostic reasoning: Where we've been, where we're going. *Teaching and Learning in Medicine*, 25(Suppl 1), S26-S32.
- Monteiro, S., Sherbino, J., Sibbald, M., & Norman, G. (2020). Critical thinking, biases and dual processing: The enduring myth of generalisable skills. *Medical Education*, 54(1), 66-73.
- Montgomery, K. (2006). *How Doctors Think: Clinical Judgment and the Practice of Medicine*. Oxford University Press.
- Moulton, C.-A. E., Regehr, G., Mylopoulos, M., & MacRae, H. M. (2007). Slowing down when you should: A new model of expert judgment. *Academic Medicine*, 82(10 Suppl), S109-S116.

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2015). *Improving Diagnosis in Health Care*. The National Academies Press.
- Nelson, T. O., & Narens, L. (1990). Metamemory: A theoretical framework and new findings. In G. H. Bower (Ed.), *The Psychology of Learning and Motivation* (Vol. 26, pp. 125-173). Academic Press.
- Norman, G. (2005). Research in clinical reasoning: Past history and current trends. *Medical Education*, 39(4), 418-427.
- Norman, G. (2009). Dual processing and diagnostic errors. *Advances in Health Sciences Education*, 14(Suppl 1), 37-49.
- Norman, G. R., Monteiro, S. D., Sherbino, J., Ilgen, J. S., Schmidt, H. G., & Mamede, S. (2017). The causes of errors in clinical reasoning: Cognitive biases, knowledge deficits, and dual process thinking. *Academic Medicine*, 92(1), 23-30.
- Novoa Jurado, A. J. (2025). Terapia epistémica del conocimiento clínico. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 18(3), 274-282.
- Pauker, S. G., & Kassirer, J. P. (1980). The threshold approach to clinical decision making. *New England Journal of Medicine*, 302(20), 1109-1117.
- Pearl, J., & Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why: The New Science of Cause and Effect*. Basic Books.
- Peirce, C. S. (1878). Deduction, induction, and hypothesis. *Popular Science Monthly*, 13, 470-482.
- Pellegrino, E. D., & Thomasma, D. C. (1981). *A Philosophical Basis of Medical Practice: Toward a Philosophy and Ethic of the Healing Professions*. Oxford University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. University of Chicago Press.
- Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.
- Rajkomar, A., & Blandford, A. (2012). Understanding infusion administration in the ICU through distributed cognition. *Journal of Biomedical Informatics*, 45(3), 580-590.
- Riquelme, A., Méndez, B., de la Fuente, P., Padilla, O., Benaglio, C., Sirhan, M., & Labarca, J. (2011). Desarrollo y validación de encuesta de percepción del portafolio en estudiantes de medicina de pregrado. *Revista Médica de Chile*, 139(1), 45-53.
- Rouault, M., McWilliams, A., Allen, M., & Fleming, S. M. (2018). Human metacognition across domains: Insights from individual differences and neuroimaging. *Personality Neuroscience*, 1, e17.
- Rudner, R. (1953). The scientist qua scientist makes value judgments. *Philosophy of Science*, 20(1), 1-6.
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*, 312, 71-72.

- Salager-Meyer, F. (1994). Hedges and textual communicative function in medical English written discourse. *English for Specific Purposes*, 13(2), 149–170.
- Sandars, J. (2009). The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44. *Medical Teacher*, 31(8), 685–695.
- Schiff, G. D., Hasan, O., Kim, S., Abrams, R., Cosby, K., Lambert, B. L., et al. (2009). Diagnostic error in medicine: Analysis of 583 physician-reported errors. *Archives of Internal Medicine*, 169(20), 1881–1887.
- Schmidt, H. G., & Mamede, S. (2015). How to improve the teaching of clinical reasoning: A narrative review and a proposal. *Medical Education*, 49(10), 961–973.
- Schmidt, H. G., & Rikers, R. M. J. P. (2007). How expertise develops in medicine: Knowledge encapsulation and illness script formation. *Medical Education*, 41(12), 1133–1139.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Simpkin, A. L., & Schwartzstein, R. M. (2016). Tolerating uncertainty — The next medical revolution? *New England Journal of Medicine*, 375, 1713–1715.
- Singhal, K., Azizi, S., Tu, T., Mahdavi, S. S., Wei, J., Chung, H. W., et al. (2023). Large language models encode clinical knowledge. *Nature*, 620, 172–180.
- Tajer, C. (2008). *El corazón enfermo: Puentes entre las emociones y el infarto*. Libros del Zorzal.
- Tonelli, M. R. (1998). The philosophical limits of evidence-based medicine. *Academic Medicine*, 73(12), 1234–1240.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131.
- Weed, L. L. (1968a). Medical records that guide and teach. *New England Journal of Medicine*, 278(11), 593–600.
- Weed, L. L. (1968b). Medical records that guide and teach. *New England Journal of Medicine*, 278(12), 652–657.
- Wittgenstein, L. (2009). *Philosophical Investigations* (G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker, & J. Schulte, Trans.; 4th ed.). Wiley-Blackwell. (Obra original publicada en 1953).
- World Health Organization. (2024). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models*. World Health Organization.
- Xiong, M., Hu, Z., Lu, X., Li, Y., Fu, J., He, J., & Hooi, B. (2024). Can LLMs express their uncertainty? An empirical evaluation of confidence elicitation in LLMs. *Proceedings of ICLR 2024*.